

Buku Ajar

ASUHAN KEBIDANAN NIFAS DAN MENYUSUI

PEMANTAUAN, KONSELING, DAN KOMPLIKASI

Dewi Mayangsari • Rizka Fatmawati • Anita Indra Afriani

Editor : Prof. Dr. Muftulillah, S.SIT., M.Sc.



Buku Ajar :

Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui: Pemantauan, Konseling, dan Komplikasi

Penulis:

Bd. Dewi Mayangsari, S.SiT., M.Kes., M.Keb.

Rizka Fatmawati, S.SiT., M.Kes., M.Keb.

Bd. Anita Indra Afriani, S.ST,M.Kes.

Editor :

Prof. Dr. Mufdlilah, S.SiT., M.Sc.



Buku Ajar:

Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui: Pemantauan, Konseling, dan Komplikasi

Penulis:

Bd. Dewi Mayangsari, S.SiT., M.Kes., M.Keb.

Rizka Fatmawati, S.SiT., M.Kes., M.Keb.

Bd. Anita Indra Afriani, S.ST,M.Kes.

Editor : Prof. Dr. Muftililah, S.SiT., M.Sc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7927-18-7

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar berjudul *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui: Pemantauan, Konseling, dan Komplikasi* ini dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, serta praktisi kesehatan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui.

Masa nifas dan menyusui merupakan periode penting dalam siklus kehidupan seorang ibu. Pada masa ini, ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang memerlukan pemantauan serta pendampingan yang tepat. Bidan sebagai tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan yang komprehensif, mulai dari pemantauan kondisi ibu, pemberian konseling, deteksi dini komplikasi, hingga pelaksanaan tatalaksana awal sesuai kewenangan dan kebutuhan ibu.

Buku ajar ini membahas beberapa topik penting yang relevan dengan pelayanan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Bab pertama menguraikan kebutuhan gizi ibu menyusui serta pentingnya dukungan gaya hidup sehat untuk menunjang pemulihan ibu dan keberhasilan menyusui. Bab kedua membahas infeksi masa nifas, meliputi endometritis, infeksi luka, serta tatalaksana awal yang perlu dipahami dalam praktik kebidanan. Bab ketiga membahas gangguan eliminasi dan komplikasi lain, seperti retensi urine, konstipasi, dan hemoroid yang sering dijumpai pada masa nifas.

Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi secara sistematis, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kebidanan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen dalam proses pembelajaran serta bagi tenaga kesehatan dalam memperkuat pemahaman mengenai asuhan kebidanan nifas dan menyusui.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kelengkapan pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu kebidanan, peningkatan kompetensi mahasiswa, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu pada masa nifas dan menyusui.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 KEBUTUHAN GIZI IBU MENYUSUI DAN DUKUNGAN GAYA HIDUP SEHAT	1
A. Pendahuluan.....	6
B. Menentukan kebutuhangizi dan hidrasiibu menyusui serta rekomendasi suplementasi dasar sesuai kondisi.	7
C. Menyusun rencana dukungan gaya hidup sehat (istirahat, aktivitas, manajemen stres, higienitas) yang realistis.....	32
D. Manajemen Stres dan Kesehatan Psikologis	41
E. Higienitas dan Perawatan Diri.....	44
F. Penyusunan Rencana Dukungan Gaya Hidup Individual.....	46
G. RANGKUMAN.....	75
GLOSARIUM	81
Referensi.....	84
BAB 2 INFEKSI MASA NIFAS: ENDOMETRITIS, INFEKSI LUKA, DAN TATALAKSANA AWAL	89
A. Pengertian Infeksi Masa Nifas.....	95
B. Etiologi	96
C. Manifestasi Klinis.....	96
D. Patofisiologi	97
E. Jenis – jenis Infeksi.....	98
F. Infeksi Luka.....	102
G. Ruptur.....	103
H. Infeksi Luka.....	104
I. Tatalaksana Awal	105
BAB 3 GANGGUAN ELIMINASI DAN KOMPLIKASI LAIN : RETENSI URINE, KONSTIPASI DAN HEMOROID.....	113
A. Retensi Urine.....	117
B. Konstipasi.....	131
C. Hemoroid	142
D. Rangkuman	168
Glosarium	170
Referensi.....	171
Profil Penulis	174

BAB 1

KEBUTUHAN GIZI IBU MENYUSUI DAN DUKUNGAN GAYA HIDUP SEHAT

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab hukum dalam pemberian asuhan nifas dan menyusui.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi interprofesional dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam seluruh rangkaian pelayanan nifas–menyusui.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-4	Melakukan clinical reasoning untuk mengkaji, menafsirkan, dan menyimpulkan status kesehatan ibu nifas dan menyusui.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan keterampilan asuhan nifas dan menyusui secara aman dan bermutu, termasuk stabilisasi awal dan rujukan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Menghasilkan dokumentasi asuhan, edukasi/konseling, dan penggunaan bukti ilmiah dasar untuk peningkatan mutu.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep, ruang lingkup, standar, dan alur pelayanan asuhan nifas dan menyusui berbasis keselamatan pasien.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis–psikologis nifas dan fisiologi laktasi untuk menafsirkan parameter klinis.
CPMK-3	Merancang dan melaksanakan asuhan esensial segera setelah persalinan (kala IV) termasuk pencegahan perdarahan dan keselamatan ibu.
CPMK-4	Melaksanakan pemantauan nifas terjadwal serta manajemen masalah umum (perineum/luka, nyeri, eliminasi) dengan clinical reasoning.
CPMK-5	Mengoptimalkan menyusui melalui teknik menyusui, perlekatan efektif, konseling, dan pemecahan masalah laktasi umum.
CPMK-6	Mengidentifikasi dan melakukan tatalaksana awal komplikasi/kegawatdaruratan nifas (perdarahan, infeksi, kesehatan mental) serta menetapkan kriteria rujukan dan kolaborasi.
CPMK-7	Menyusun edukasi, rencana tindak lanjut, dan dokumentasi asuhan nifas–menyusui berbasis bukti dengan komunikasi terapeutik.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Kebutuhan Gizi Ibu Menyusui dan Dukungan Gaya Hidup Sehat	1.1 Menentukan kebutuhan gizi dan hidrasi ibu menyusui serta rekomendasi suplementasi dasar sesuai kondisi.	1.2 Menyusun rencana dukungan gaya hidup sehat (istirahat, aktivitas, manajemen stres, higienitas) yang realistis.	CPMK-7	CPMK-5; CPMK-2

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian berbasis kasus (analisis); Kuis interpretasi data	Ketepatan interpretasi parameter fisiologis nifas & laktasi ($\geq 80\%$ tepat); Rasional klinis jelas (≥ 3 alasan relevan) untuk simpulan	15	Lembar analisis kasus; lembar kuis
CPMK-5	OSCE teknik menyusui & konseling; Penilaian performa/video	Perlekatan/posisi efektif ($\geq 85\%$ kriteria terpenuhi); Solusi masalah laktasi sesuai penyebab dan tingkat keparahan; Komunikasi konseling empatik dan terstruktur	15	Checklist OSCE; video/demonstrasi; lembar konseling
CPMK-7	Portofolio (dokumentasi & edukasi); Presentasi singkat	Dokumentasi lengkap-akurat-terstruktur ($\geq 90\%$ komponen); Materi edukasi jelas sesuai literasi; Menggunakan ≥ 2 sumber bukti ilmiah; Rencana tindak lanjut spesifik dan realistis	10	Portofolio; leaflet/lembar edukasi; slide/presentasi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Akurasi konsep/terminologi dan standar	Banyak konsep inti keliru; istilah tidak konsisten; standar tidak jelas.	Konsep dasar cukup benar namun ada kekeliruan penting; standar disebut terbatas.	Mayoritas konsep benar; kekeliruan minor; standar relevan digunakan.	Konsep sangat akurat; istilah konsisten; standar digunakan tepat dan menyeluruh.
1.2 Kesesuaian alur pelayanan dengan keselamatan pasien	Alur tidak runtut; langkah kritis keselamatan terlewat.	Alur cukup runtut namun ada langkah kritis yang belum lengkap.	Alur runtut; langkah kritis terpenuhi; risiko utama dikenali.	Alur runtut dan efisien; prioritas jelas; mitigasi risiko & eskalasi dirumuskan tepat.

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter fisiologis nifas & laktasi	Salah menafsirkan data; tidak dapat membedakan normal–abnormal.	Menafsirkan sebagian data namun ada salah simpulan pada temuan penting.	Menafsirkan data dengan benar; membedakan normal–abnormal dengan tepat.	Interpretasi sangat tepat; mengaitkan pola data dan prioritas masalah secara tajam.
2.2 Analisis perubahan emosi & faktor risiko psikologis	Tidak mengenali pola gejala; faktor risiko tidak relevan.	Mengenali gejala umum namun analisis risiko dangkal/tidak lengkap.	Analisis gejala dan risiko memadai; menyusun kebutuhan dukungan awal.	Analisis komprehensif; mempertimbangkan konteks keluarga/sosial; rekomendasi dukungan sangat tepat.

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Pengkajian kala IV dan penetapan status risiko	Pengkajian tidak lengkap; banyak data penting terlewat; risiko tidak tepat.	Pengkajian cukup namun masih ada data penting kurang; risiko sebagian tepat.	Pengkajian lengkap sesuai urutan; status risiko tepat.	Pengkajian sangat sistematis; cepat; risiko diprioritaskan dan dikomunikasikan jelas.
3.2 Intervensi pencegahan perdarahan & keselamatan ibu	Tindakan tidak sesuai prioritas; berisiko/menyalahi prosedur.	Tindakan sebagian tepat namun urutan/prioritas belum konsisten.	Tindakan tepat dan aman; prioritas sesuai protokol.	Tindakan sangat tepat; antisipasi komplikasi; koordinasi tim dan keselamatan optimal.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Pengkajian kunjungan nifas & deteksi dini risiko	Pengkajian tidak terstruktur; tanda risiko sering terlewat.	Pengkajian cukup terstruktur namun deteksi risiko belum konsisten.	Pengkajian terstruktur; risiko terdeteksi tepat; keputusan tindak lanjut sesuai.	Pengkajian sangat komprehensif; mengaitkan tren; rencana tindak lanjut proaktif dan tepat.
4.2 Manajemen masalah umum (luka/nyeri/eliminasi) & rencana tindak lanjut	Intervensi tidak tepat/tidak aman; edukasi minim; tindak lanjut tidak jelas.	Intervensi cukup tepat namun rasional/edukasi kurang lengkap.	Intervensi tepat dan aman; edukasi memadai; tindak lanjut jelas.	Intervensi sangat tepat; personalisasi edukasi; evaluasi respons dan eskalasi direncanakan matang.

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Teknik menyusui & perlekatan efektif	Posisi/perlekatan salah; tidak dapat menunjukkan tanda efektif.	Posisi/perlekatan cukup namun masih ada kesalahan yang mengganggu efektivitas.	Posisi/perlekatan benar; menunjukkan tanda efektivitas menyusui.	Teknik sangat tepat; mampu mengoreksi kesalahan; evaluasi kecukupan menyusui sangat baik.
5.2 Konseling & pemecahan masalah laktasi	Tidak mampu mengidentifikasi penyebab; solusi tidak sesuai.	Identifikasi penyebab sebagian; solusi umum dan kurang spesifik.	Identifikasi penyebab tepat; solusi sesuai dan realistis; komunikasi empatik.	Analisis masalah tajam; solusi bertahap sesuai keparahan; dukungan/kolaborasi direncanakan optimal.

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi cepat komplikasi/kegawatdaruratan	Terlambat mengenali; salah menentukan prioritas; tanda bahaya terlewat.	Mengenali tanda bahaya utama namun belum cepat/kurang lengkap.	Mengenali tanda bahaya dengan cepat; prioritas masalah tepat.	Sangat cepat dan akurat; menilai derajat/keparahan secara sistematis.
6.2 Stabilisasi awal & keputusan rujukan/kolaborasi	Tindakan awal tidak sesuai/berisiko; rujukan tidak tepat.	Tindakan awal sebagian tepat; rujukan/kolaborasi belum jelas.	Stabilisasi awal tepat dan aman; rujukan/kolaborasi sesuai kriteria.	Stabilisasi sangat tepat; koordinasi tim efektif; rujukan disertai informasi klinis lengkap dan tepat waktu.

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Dokumentasi asuhan (lengkap, akurat, terstruktur)	Banyak komponen hilang; data tidak akurat; format tidak runtut.	Komponen utama ada namun masih kurang detail/ada inkonsistensi.	Dokumentasi lengkap dan akurat; format runtut; rencana jelas.	Dokumentasi sangat lengkap; analitis; mudah ditelusuri; mendukung kesinambungan asuhan.
7.2 Edukasi, rencana tindak lanjut, dan penggunaan bukti	Edukasi tidak jelas/tidak sesuai; tindak lanjut tidak spesifik; tanpa rujukan bukti.	Edukasi cukup jelas namun belum sesuai literasi; tindak lanjut umum; bukti minimal.	Edukasi jelas sesuai literasi; tindak lanjut spesifik; menggunakan bukti relevan.	Edukasi sangat jelas dan terpersonalisasi; tindak lanjut terukur; bukti kuat dan diintegrasikan tepat.

A. Pendahuluan

Masa nifas merupakan periode transisi yang sangat penting dalam kehidupan seorang perempuan, dimulai sejak setelah persalinan hingga sekitar enam minggu postpartum. Pada fase ini terjadi berbagai perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang bertujuan mengembalikan kondisi tubuh ibu seperti sebelum hamil sekaligus mendukung keberhasilan proses menyusui. Adaptasi ini melibatkan sistem hormonal, metabolisme energi, serta kesiapan mental ibu dalam menjalankan peran barunya.

Salah satu aspek krusial dalam masa nifas adalah pemenuhan kebutuhan gizi dan hidrasi ibu menyusui. Produksi Air Susu Ibu (ASI) membutuhkan energi, makronutrien, dan mikronutrien dalam jumlah yang adekuat. Kekurangan asupan nutrisi tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu—seperti kelelahan, anemia, dan gangguan pemulihan luka—tetapi juga dapat memengaruhi kualitas dan kuantitas ASI yang diberikan kepada bayi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi berbasis bukti mengenai pola makan yang seimbang, kebutuhan cairan, serta indikasi suplementasi yang tepat sesuai kondisi ibu.

Selain aspek gizi, dukungan gaya hidup sehat juga menjadi komponen penting dalam asuhan masa nifas. Kualitas istirahat yang cukup, aktivitas fisik yang aman dan bertahap, manajemen stres yang efektif, serta praktik higienitas yang baik merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam menjaga kesehatan ibu dan keberhasilan menyusui. Tantangan yang sering dihadapi ibu nifas, seperti kurang tidur akibat frekuensi menyusui, kelelahan fisik, serta perubahan emosional, memerlukan pendekatan edukasi yang realistis, empatik, dan terpersonalisasi.

Dalam konteks pendidikan kebidanan berbasis Outcome-Based Education (OBE), mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik klinik. Bab ini dirancang untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam menentukan kebutuhan gizi dan hidrasi ibu menyusui, menyusun rencana dukungan gaya hidup sehat yang sesuai dengan kondisi individu, serta memberikan edukasi yang efektif menggunakan komunikasi terapeutik. Integrasi antara aspek fisiologis, psikologis, dan sosial menjadi landasan penting dalam menyusun asuhan yang komprehensif dan berkesinambungan.

Dengan memahami dan menguasai materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai edukator dan pendamping ibu nifas yang kompeten, sehingga dapat meningkatkan kualitas asuhan kebidanan, mendukung

keberhasilan menyusui, serta berkontribusi pada peningkatan kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh.

B. Menentukan kebutuhangizi dan hidrasiibu menyusui serta rekomendasi suplementasi dasar sesuai kondisi.

1. Adaptasi Fisiologis Nifas dan Laktasi

Masa nifas merupakan periode transisi fisiologis yang dimulai segera setelah kelahiran plasenta hingga ± 6 minggu postpartum. Pada fase ini, tubuh ibu mengalami perubahan sistemik yang kompleks untuk memulihkan kondisi pra-kehamilan sekaligus mendukung produksi dan pemeliharaan laktasi. Adaptasi tersebut melibatkan perubahan metabolisme energi, regulasi hormonal, keseimbangan cairan, serta respons neuroendokrin terhadap proses menyusui. Pemahaman mendalam terhadap mekanisme ini menjadi fondasi analisis klinis dalam praktik kebidanan (Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., 2022); (Murray, S. S., & McKinney, 2020).

a. Perubahan Metabolisme Postpartum

Selama kehamilan, tubuh berada dalam keadaan anabolik dengan peningkatan penyimpanan lemak sebagai cadangan energi untuk laktasi. Setelah persalinan, terjadi pergeseran menuju kondisi katabolik relatif yang mendukung sintesis ASI melalui mobilisasi cadangan lemak maternal (Neville, M. C., Morton, J., & Umemura, 2012).

Produksi ASI eksklusif membutuhkan tambahan energi sekitar 450–500 kkal per hari pada enam bulan pertama menyusui. Energi tersebut berasal dari kombinasi asupan makanan dan cadangan lemak kehamilan sekitar 2–4 kg. Penurunan berat badan bertahap pada ibu menyusui merupakan adaptasi fisiologis normal, selama tidak disertai tanda malnutrisi atau kelelahan berat.

Studi terbaru menunjukkan bahwa status metabolik ibu, termasuk indeks massa tubuh (IMT), berpengaruh terhadap dinamika onset laktasi. Ibu dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami keterlambatan laktogenesis II akibat gangguan sensitivitas prolaktin dan perubahan inflamasi metabolik (Gomez-Casado, 2025; Li et al., 2024). Temuan ini memperkuat pentingnya analisis status gizi sebagai bagian dari pengkajian postpartum.

Pada minggu pertama nifas juga terjadi diuresis fisiologis akibat penurunan hormon estrogen dan progesteron serta redistribusi cairan ekstraseluler (Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., 2022). Adaptasi ini sering disalahartikan sebagai gangguan hidrasi, padahal merupakan mekanisme normal tubuh untuk mengembalikan keseimbangan volume cairan.

b. Proses Laktogenesis I–III

Produksi ASI berlangsung melalui tiga tahap fisiologis: laktogenesis I, II, dan III.

Laktogenesis I

Terjadi pada trimester akhir kehamilan hingga 2–3 hari postpartum. Sel alveoli payudara telah mampu memproduksi kolostrum, namun kadar progesteron yang tinggi masih menghambat sekresi ASI dalam jumlah besar (Neville, M. C., Morton, J., & Umemura, 2012).

Laktogenesis II

Dimulai sekitar 30–72 jam setelah plasenta lahir dan ditandai dengan peningkatan volume ASI secara signifikan (*"copious milk secretion"*). Penurunan drastis progesteron memungkinkan prolaktin bekerja optimal dalam merangsang sintesis ASI (Pillay, J., & Davis, 2021).

Keterlambatan onset laktogenesis II (>72 jam) merupakan isu klinis penting karena berhubungan dengan kegagalan menyusui dini dan penghentian ASI eksklusif (Cao Z, Huang M, Chen Y, 2024). Faktor risiko meliputi obesitas, persalinan sesar, perdarahan postpartum, stres, dan jarangya inisiasi menyusui dini. Oleh karena itu, analisis faktor perinatal menjadi bagian integral dalam interpretasi klinis mahasiswa kebidanan.

Laktogenesis III (Galaktopoiesis)

Fase pemeliharaan produksi ASI bergantung pada mekanisme supply-demand. Pengosongan payudara yang efektif akan mempertahankan kadar prolaktin dan mencegah akumulasi *Feedback Inhibitor of Lactation* (FIL). Regulasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan menyusui bukan hanya ditentukan oleh kapasitas biologis, tetapi juga oleh praktik menyusui yang tepat.

c. Pengaruh Hormon: Prolaktin dan Oksitosin

Laktasi dikendalikan oleh sistem neuroendokrin yang melibatkan prolaktin dan oksitosin.

Prolaktin

Diproduksi oleh hipofisis anterior dan berfungsi merangsang sel alveolar dalam sintesis ASI. Kadar prolaktin meningkat setiap kali bayi menyusui, terutama pada malam hari (Guyton, A. C., & Hall, 2021). Gangguan sensitivitas prolaktin dapat terjadi pada kondisi metabolik tertentu seperti obesitas (Gomez-Casado et al., 2025).

Produksi ASI rata-rata berkisar 700–800 ml pada ASI matur per hari dengan kandungan energi ± 65 –70 kkal per 100 ml. Dengan demikian, total energi yang dikeluarkan untuk laktasi mencapai ± 500 –700 kkal per hari.

Rekomendasi kebutuhan energi tambahan adalah 330–500 kkal per hari, tergantung cadangan energi maternal. Pada ibu dengan status gizi baik,

produksi ASI relatif stabil meskipun asupan energi sedikit berkurang dalam jangka pendek (Tschann et al., 2015). Namun defisit energi kronis dapat memengaruhi kesehatan ibu dan kualitas hidupnya.

d. Interpretasi Parameter Klinis pada Ibu Menyusui

Berat Badan

Penurunan 0,5–1 kg per minggu pada awal nifas masih dalam batas fisiologis. Penurunan drastis perlu evaluasi lebih lanjut terhadap asupan energi dan kondisi psikologis (Murray, S. S., & McKinney, 2020).

Tanda Anemia

Anemia postpartum sering berkaitan dengan perdarahan saat persalinan. Gejala meliputi lemah, pucat, dan pusing. Pemeriksaan hemoglobin direkomendasikan pada ibu berisiko (World Health Organization, 2016).

Status Hidrasi

Hidrasi yang adekuat penting untuk kenyamanan ibu dan mendukung refleksi oksitosin. Namun konsumsi cairan berlebihan tidak secara langsung meningkatkan produksi ASI.

Tingkat Kelelahan

Kelelahan fisiologis umum terjadi akibat kurang tidur dan adaptasi hormonal. Akan tetapi, kelelahan ekstrem harus dievaluasi untuk menyingkirkan anemia, depresi postpartum, atau gangguan metabolik lainnya (Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., 2022).

Kesimpulan Akademik

Adaptasi fisiologis nifas dan laktasi merupakan proses dinamis yang melibatkan interaksi metabolik, hormonal, dan neuroendokrin. Bukti ilmiah terbaru memperkuat bahwa faktor metabolik maternal, kondisi perinatal, dan praktik menyusui awal sangat memengaruhi keberhasilan laktasi. Oleh karena itu, mahasiswa kebidanan harus mampu mengintegrasikan pemahaman fisiologi dengan interpretasi parameter klinis untuk menyusun asuhan nifas yang berbasis bukti, aman, dan berkesinambungan.

2. Kebutuhan Energi dan Makronutrien

Masa menyusui merupakan periode dengan kebutuhan nutrisi yang meningkat dibandingkan kondisi normal karena tubuh ibu tidak hanya mempertahankan fungsi fisiologisnya sendiri tetapi juga memproduksi ASI untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Produksi ASI membutuhkan energi, protein, lemak, dan karbohidrat dalam jumlah yang cukup agar kualitas dan kuantitas ASI tetap optimal. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan makronutrien pada ibu menyusui menjadi komponen penting dalam asuhan kebidanan berbasis gizi (William, W. W., Bukhari, N. H. B. M., & Abdul, 2025); (UNICEF, 2022)).

Kebutuhan nutrisi yang adekuat juga berperan dalam proses pemulihan tubuh setelah persalinan, termasuk penyembuhan jaringan luka perineum atau luka operasi sesar, stabilitas metabolisme, serta pencegahan kelelahan postpartum. Ketidakseimbangan asupan makronutrien dapat berdampak pada kesehatan ibu maupun kualitas ASI yang dihasilkan (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

a. Tambahan Kebutuhan Kalori pada Ibu Menyusui

Produksi ASI memerlukan energi yang cukup besar karena tubuh harus mensintesis komponen ASI seperti laktosa, protein, dan lemak. Rata-rata produksi ASI eksklusif mencapai sekitar 700–800 ml per hari. Proses ini memerlukan energi tambahan sekitar 450–500 kkal per hari, yang berasal dari kombinasi asupan makanan dan mobilisasi cadangan lemak yang terbentuk selama kehamilan (Brown, 2023)(Butte & King, 2022).

Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Indonesia, kebutuhan energi ibu menyusui meningkat sekitar +330 kkal per hari pada enam bulan pertama dan +400 kkal pada enam bulan berikutnya dibandingkan kebutuhan energi perempuan dewasa normal (Kementerian Kesehatan RI, 2019; Kementerian Kesehatan RI, 2024). Tambahan energi ini diperlukan untuk mempertahankan produksi ASI serta mencegah kelelahan metabolik pada ibu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2024)

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kalori yang berlebihan selama masa menyusui dapat menurunkan produksi ASI serta memperlambat pemulihan kondisi fisiologis postpartum (Carretero-Krug et al., 2024). Oleh karena itu, diet ketat tidak dianjurkan pada masa nifas dan menyusui.

b. Protein dan Penyembuhan Jaringan Nifas

Protein merupakan zat gizi makro yang memiliki peran penting dalam proses regenerasi jaringan tubuh, sintesis hormon, dan produksi komponen protein dalam ASI. Setelah persalinan, tubuh ibu mengalami proses penyembuhan jaringan, baik pada luka perineum maupun luka operasi sesar. Proses ini membutuhkan asupan protein yang cukup untuk mendukung sintesis kolagen dan regenerasi sel (Victoria C, Christian P, 2021).

Kebutuhan protein ibu menyusui meningkat sekitar 20 gram per hari pada enam bulan pertama menyusui dan 15 gram per hari pada enam bulan berikutnya(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2019). Peningkatan kebutuhan ini berkaitan dengan produksi protein dalam ASI serta kebutuhan pemulihan jaringan maternal.

Sumber protein yang dianjurkan meliputi protein hewani seperti ikan, telur, daging tanpa lemak, dan susu, serta protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Kombinasi sumber protein hewani dan nabati dapat meningkatkan kualitas asam amino yang dibutuhkan tubuh (World Health Organization., 2021).

c. Lemak Esensial (DHA) untuk Kualitas ASI

Lemak merupakan komponen penting dalam produksi ASI karena hampir 50% energi dalam ASI berasal dari lemak. Asam lemak esensial, khususnya docosahexaenoic acid (DHA) dan eicosapentaenoic acid (EPA), memiliki peran penting dalam perkembangan otak dan sistem saraf bayi (Koletzko et al., 2020).

Kandungan DHA dalam ASI sangat dipengaruhi oleh pola makan ibu. Ibu yang mengonsumsi makanan kaya omega-3 seperti ikan laut, kacang-kacangan, dan minyak ikan cenderung memiliki kadar DHA ASI yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemenuhan asam lemak esensial selama menyusui menjadi faktor penting dalam kualitas nutrisi ASI (Koletzko et al., 2020);(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2024).

Rekomendasi tambahan lemak pada ibu menyusui menurut AKG adalah sekitar +2,2 gram lemak per hari, dengan penekanan pada konsumsi lemak tidak jenuh dan asam lemak omega-3 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2019). Asupan DHA yang adekuat telah terbukti berkontribusi terhadap perkembangan kognitif dan visual bayi pada masa awal kehidupan.

d. Karbohidrat dan Kestabilan Energi Ibu

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan sangat penting dalam menjaga kestabilan energi ibu selama masa menyusui. Karbohidrat juga berperan dalam sintesis laktosa, yaitu komponen utama karbohidrat dalam ASI yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi bayi (Butte, N. F., & King, 2022).

Rekomendasi tambahan karbohidrat bagi ibu menyusui adalah sekitar +45 gram per hari pada enam bulan pertama menyusui(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2019). Konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, gandum utuh, kentang, dan umbi-umbian dapat membantu menjaga kestabilan kadar glukosa darah sehingga ibu tidak mudah mengalami kelelahan selama proses menyusui (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2024).

Karbohidrat kompleks juga memberikan pelepasan energi yang lebih stabil dibandingkan karbohidrat sederhana, sehingga membantu menjaga stamina ibu dalam menjalankan aktivitas merawat bayi dan menyusui secara rutin.

Tabel 1. 1 Rekomendasi Kebutuhan Energi dan Makronutrien Ibu Menyusui (AKG Indonesia)

Zat Gizi	Perempuan Dewasa (19–29 th)	Tambahan Menyusui (0–6 bln)	Ibu Total Kebutuhan
Energi	2.250 kkal	+330 kkal	2.580 kkal
Karbohidrat	360 g	+45 g	405 g
Protein	60 g	+20 g	80 g
Lemak	65 g	+2,2 g	67,2 g

Sumber: Angka Kecukupan Gizi Indonesia (Permenkes No. 28 Tahun 2019)

3. Mikronutrien Penting pada Ibu Menyusui

Masa menyusui merupakan periode dengan kebutuhan nutrisi yang meningkat karena tubuh ibu harus memenuhi kebutuhan metabolisme sendiri sekaligus mendukung produksi dan kualitas air susu ibu (ASI). Selain energi dan makronutrien, kecukupan mikronutrien sangat penting untuk mempertahankan kesehatan ibu, mempercepat pemulihan postpartum, serta menjamin kualitas nutrisi ASI bagi bayi. Penelitian menunjukkan bahwa komposisi beberapa mikronutrien dalam ASI dipengaruhi oleh asupan nutrisi ibu selama masa laktasi, sehingga status gizi ibu menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan pertumbuhan bayi (Falize et al., 2024); (Kankaew & Briere, 2025).

Beberapa mikronutrien yang memiliki peran penting selama masa menyusui antara lain zat besi, kalsium, vitamin D, asam folat, vitamin B12, iodium, dan zinc (Sizer, F., & Whitney, 2024).

a. Zat Besi

Zat besi merupakan mikronutrien esensial yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, transport oksigen, dan fungsi metabolisme seluler. Pada masa nifas, ibu berisiko mengalami defisiensi zat besi akibat kehilangan darah selama persalinan serta peningkatan kebutuhan untuk pemulihan jaringan. Kekurangan zat besi pada ibu menyusui dapat menyebabkan anemia postpartum yang ditandai dengan kelelahan, penurunan konsentrasi, serta gangguan daya tahan tubuh. Kondisi ini secara tidak langsung dapat memengaruhi keberhasilan menyusui karena ibu menjadi lebih mudah lelah dan kurang optimal dalam merawat bayi.

Meskipun kandungan zat besi dalam ASI relatif stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh asupan ibu, status zat besi ibu tetap penting untuk menjaga kesehatan maternal selama masa menyusui. Oleh karena itu, ibu menyusui dianjurkan mengonsumsi makanan sumber zat besi seperti daging merah, hati, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, serta mempertimbangkan

suplementasi apabila terdapat risiko anemia. Studi sistematis terbaru menunjukkan bahwa banyak ibu menyusui masih mengalami ketidakcukupan asupan beberapa mikronutrien termasuk zat besi, sehingga edukasi nutrisi menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan maternal (Agustina et al., 2023).

b. Kalsium

Kalsium memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi ibu serta mendukung perkembangan sistem skeletal bayi. Selama masa menyusui, sekitar 200–300 mg kalsium dapat ditransfer setiap hari ke dalam ASI untuk memenuhi kebutuhan bayi. Apabila asupan kalsium ibu tidak mencukupi, tubuh akan mengambil cadangan kalsium dari tulang ibu melalui proses resorpsi tulang sementara.

Penelitian menunjukkan bahwa kadar kalsium dalam ASI relatif stabil, tetapi asupan kalsium yang cukup tetap penting untuk menjaga kesehatan tulang ibu

jangka panjang. Sumber kalsium yang baik bagi ibu menyusui antara lain susu dan produk olahannya, ikan dengan tulang lunak (seperti sarden), tahu, tempe, serta sayuran hijau. Analisis sistematis tentang komposisi ASI juga menunjukkan bahwa kadar kalsium, zinc, dan vitamin D dalam ASI dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk status gizi ibu, tahap laktasi, dan pola makan (Rios-Leyvraz & Yao, 2023).

c. Vitamin D

Vitamin D berperan dalam metabolisme kalsium dan fosfor serta penting untuk perkembangan tulang bayi. Defisiensi vitamin D pada ibu menyusui cukup sering terjadi, terutama pada populasi dengan paparan sinar matahari yang rendah atau pola makan yang terbatas.

Kandungan vitamin D dalam ASI sangat dipengaruhi oleh status vitamin D ibu. Oleh karena itu, ibu menyusui dianjurkan memperoleh vitamin D melalui paparan sinar matahari yang cukup, konsumsi makanan seperti ikan berlemak, telur, dan susu fortifikasi, serta suplementasi apabila diperlukan. Studi terbaru menunjukkan bahwa asupan nutrisi ibu selama masa menyusui memiliki hubungan dengan komposisi mikronutrien dalam ASI, termasuk vitamin D, sehingga intervensi nutrisi pada ibu menyusui dapat meningkatkan kualitas nutrisi ASI (Falize et al., 2024).

d. Asam Folat

Asam folat (vitamin B9) berperan dalam sintesis DNA, pembentukan sel darah merah, serta proses metabolisme seluler. Walaupun kebutuhan asam folat lebih dikenal pada masa kehamilan, kebutuhan nutrisi ini tetap penting

selama masa menyusui untuk mendukung regenerasi jaringan dan metabolisme ibu.

Asupan asam folat yang cukup juga penting untuk menjaga kandungan folat dalam ASI yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sumber makanan yang kaya folat meliputi sayuran hijau (bayam, brokoli), kacang-kacangan, hati, serta biji-bijian. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian ibu menyusui masih memiliki risiko kekurangan beberapa mikronutrien termasuk folat, sehingga diperlukan edukasi gizi yang lebih intensif selama masa postpartum (Agustina et al., 2023).

e. Vitamin B12

Vitamin B12 berperan dalam pembentukan sel darah merah, fungsi sistem saraf, serta metabolisme energi. Defisiensi vitamin B12 pada ibu menyusui dapat berdampak pada kualitas nutrisi ASI dan berpotensi menyebabkan gangguan perkembangan neurologis pada bayi.

Vitamin B12 terutama ditemukan pada produk hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu. Oleh karena itu, ibu menyusui yang menjalani pola makan vegetarian atau vegan memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekurangan vitamin B12. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan ibu dapat memengaruhi kandungan beberapa vitamin dalam ASI, termasuk vitamin B kompleks, sehingga pemantauan status nutrisi ibu sangat penting selama masa menyusui (Falize et al., 2024).

f. Iodium

Iodium merupakan mikronutrien penting untuk sintesis hormon tiroid yang berperan dalam metabolisme dan perkembangan otak bayi. Selama masa menyusui, kebutuhan iodium meningkat karena mineral ini ditransfer ke dalam ASI untuk mendukung perkembangan neurologis bayi.

Defisiensi iodium pada ibu menyusui dapat menyebabkan rendahnya kadar iodium dalam ASI dan meningkatkan risiko gangguan perkembangan kognitif pada bayi. Oleh karena itu, ibu dianjurkan mengonsumsi makanan yang kaya iodium seperti garam beryodium, ikan laut, rumput laut, serta produk laut lainnya. Studi terbaru menunjukkan bahwa kekurangan iodium masih menjadi masalah nutrisi pada beberapa populasi ibu menyusui, sehingga intervensi nutrisi dan edukasi menjadi penting dalam pelayanan kesehatan maternal (Kankaew & Briere, 2025).

g. Zinc

Zinc berperan dalam fungsi imun, penyembuhan luka, sintesis protein, serta pertumbuhan dan perkembangan sel. Pada masa nifas, zinc berperan

penting dalam mempercepat penyembuhan jaringan yang mengalami trauma selama persalinan, termasuk luka perineum.

Kadar zinc dalam ASI cenderung tinggi pada awal masa laktasi dan secara bertahap menurun seiring bertambahnya usia bayi. Asupan zinc yang cukup dapat diperoleh dari makanan seperti daging merah, seafood, kacang-kacangan, biji-bijian, serta produk susu. Analisis global tentang komposisi nutrisi ASI menunjukkan bahwa zinc merupakan salah satu mikronutrien penting yang mendukung perkembangan bayi serta fungsi imun pada awal kehidupan (Rios-Leyvraz & Yao, 2023).

h. Analisis Kondisi Khusus pada Ibu Menyusui

Dalam praktik kebidanan, kebutuhan mikronutrien pada ibu menyusui tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh kondisi klinis tertentu. Oleh karena itu, bidan perlu melakukan penilaian individual terhadap status gizi ibu.

1) Ibu dengan anemia

Ibu yang mengalami anemia postpartum memerlukan peningkatan asupan zat besi dan vitamin pendukung seperti vitamin C dan asam folat. Intervensi dapat berupa konseling gizi, konsumsi makanan kaya zat besi, serta suplementasi sesuai indikasi klinis.

2) Ibu vegetarian

Ibu vegetarian memiliki risiko kekurangan vitamin B12, zat besi, dan zinc. Oleh karena itu, pemantauan status nutrisi serta pemberian suplemen vitamin B12 sering direkomendasikan untuk mencegah defisiensi pada ibu dan bayi.

3) Ibu dengan penyembuhan luka perineum

Proses penyembuhan luka membutuhkan nutrisi yang mendukung regenerasi jaringan seperti protein, vitamin C, dan zinc. Kekurangan nutrien tersebut dapat memperlambat proses penyembuhan luka postpartum.

4) Ibu dengan bayi prematur

Bayi prematur memiliki kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan bayi cukup bulan. Oleh karena itu, ibu menyusui bayi prematur perlu memastikan kecukupan nutrisi terutama protein, energi, serta beberapa mikronutrien penting agar kualitas ASI tetap optimal untuk mendukung pertumbuhan bayi.

i. Tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Ibu Menyusui Indonesia

Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan pedoman kebutuhan nutrisi harian yang digunakan untuk menjaga kesehatan individu dan populasi. Berdasarkan rekomendasi gizi di Indonesia, kebutuhan energi ibu menyusui

meningkat dibandingkan perempuan dewasa karena adanya proses produksi ASI.

Secara umum, ibu menyusui membutuhkan tambahan energi sekitar 330–400 kkal per hari selama enam bulan pertama masa menyusui (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., 2019); (WHO, 2023).

Tabel 1. 2 Rekomendasi AKG Ibu Menyusui (Indonesia)

<i>Komponen Gizi</i>	<i>0–6 bulan menyusui</i>	<i>7–12 bulan menyusui</i>
Energi	+330 kkal	+400 kkal
Protein	+20 g	+20 g
Lemak	±65 g	±65 g
Karbohidrat	±360 g	±360 g
Kalsium	1200 mg	1200 mg
Zat Besi	32 mg	34 mg
Vitamin A	850 mcg	850 mcg
Vitamin C	100 mg	100 mg
Zinc	12 mg	12 mg
Iodium	250 mcg	250 mcg

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan energi, protein, serta beberapa mikronutrien meningkat selama masa menyusui karena tubuh ibu harus memenuhi kebutuhan metabolisme sendiri sekaligus mendukung produksi ASI.

j. Algoritma Penilaian Status Gizi Ibu Nifas (Pendekatan Klinis)

Penilaian status gizi pada ibu nifas merupakan bagian penting dalam pelayanan kebidanan untuk memastikan ibu memperoleh nutrisi yang cukup selama masa pemulihan dan menyusui. Penilaian status gizi biasanya dilakukan melalui pendekatan antropometri, klinis, dietetik, dan biokimia.

Tahapan Penilaian Status Gizi Ibu Nifas

Langkah 1 – Skrining awal

- 1) Riwayat kehamilan dan persalinan
- 2) Riwayat anemia atau penyakit kronis
- 3) Pola makan ibu
- 4) Keluhan kelelahan atau penurunan nafsu makan

Langkah 2 – Pemeriksaan antropometri

- 1) Berat badan postpartum
- 2) Indeks Massa Tubuh (IMT)
- 3) Lingkar lengan atas (LILA)

Langkah 3 – Pemeriksaan klinis

- 1) Tanda anemia (pucat, lemah)
- 2) Kondisi luka perineum
- 3) Status hidrasi
- 4) Produksi ASI

Langkah 4 – Pemeriksaan dietetik

- 1) Food recall 24 jam
- 2) Frekuensi konsumsi makanan
- 3) Asupan energi dan protein

Langkah 5 – Pemeriksaan laboratorium (bila tersedia)

- 1) Hemoglobin
- 2) Ferritin
- 3) Vitamin D

Langkah 6 – Interpretasi status gizi

Kategori hasil penilaian:

- 1) Status gizi baik
- 2) Risiko kekurangan energi kronis
- 3) Anemia postpartum
- 4) Risiko defisiensi mikronutrien

Langkah 7 – Intervensi

Intervensi dapat berupa:

- 1) Edukasi gizi ibu menyusui
- 2) Perbaikan pola makan
- 3) Suplementasi nutrisi
- 4) Rujukan ke tenaga kesehatan lain bila diperlukan.

Pendekatan algoritmik ini membantu bidan dalam melakukan pengambilan keputusan klinis yang sistematis sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

4. Kebutuhan Hidrasi

Hidrasi merupakan komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis ibu menyusui. Air merupakan komponen utama dalam air susu ibu (ASI), sehingga kecukupan cairan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, mendukung metabolisme, serta mempertahankan produksi ASI yang optimal. Produksi ASI rata-rata mencapai 700–800 ml per hari, sehingga tubuh ibu membutuhkan tambahan cairan untuk menggantikan kehilangan cairan tersebut (Malisova et al., 2024).

Selain mendukung produksi ASI, hidrasi yang adekuat juga berperan dalam menjaga fungsi fisiologis tubuh ibu seperti regulasi suhu tubuh, transport nutrisi, serta fungsi kardiovaskular. Kekurangan cairan dapat menyebabkan kelelahan, gangguan konsentrasi, sakit kepala, serta menurunkan kapasitas fisik ibu dalam merawat bayi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan cairan menjadi bagian penting dalam edukasi kesehatan pada masa nifas.

Secara umum, ibu menyusui dianjurkan untuk mengonsumsi cairan sekitar 3 liter per hari dari berbagai sumber seperti air putih, susu, sup, dan buah yang kaya kandungan air. Namun, kebutuhan cairan dapat bervariasi tergantung kondisi lingkungan, aktivitas fisik, serta kondisi kesehatan ibu.

a. Hubungan Hidrasi dan Refleks Oksitosin

Refleks oksitosin atau *let-down reflex* merupakan mekanisme fisiologis yang berperan dalam pengeluaran ASI dari alveoli payudara menuju duktus laktiferus. Refleks ini dipicu oleh rangsangan hisapan bayi pada puting yang kemudian merangsang pelepasan hormon oksitosin dari hipofisis posterior.

Hidrasi memiliki hubungan tidak langsung dengan refleks oksitosin melalui mekanisme neuroendokrin dan respons fisiologis tubuh terhadap keseimbangan cairan. Pada ibu menyusui, pelepasan oksitosin tidak hanya merangsang kontraksi sel mioepitel payudara, tetapi juga memicu sensasi haus yang merupakan respons fisiologis untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh selama proses menyusui. Penelitian menunjukkan bahwa pelepasan oksitosin selama menyusui dapat meningkatkan dorongan untuk minum sehingga membantu ibu mempertahankan hidrasi yang adekuat selama masa laktasi (Bentley, 1998).

Selain itu, faktor psikologis seperti relaksasi, kenyamanan, dan dukungan emosional juga dapat memengaruhi pelepasan oksitosin. Intervensi seperti pijat oksitosin, manajemen stres, serta dukungan keluarga terbukti dapat meningkatkan kadar oksitosin dan prolaktin pada ibu menyusui sehingga membantu meningkatkan produksi ASI (Astuti et al., 2024).

Dengan demikian, meskipun hidrasi bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi refleks oksitosin, kecukupan cairan tetap penting untuk menjaga kondisi fisiologis ibu sehingga proses menyusui dapat berlangsung secara optimal.

b. Tanda Klinis Dehidrasi Ringan–Sedang

Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan cairan lebih banyak daripada yang masuk. Pada ibu menyusui, dehidrasi dapat terjadi apabila kebutuhan cairan tidak terpenuhi, terutama pada kondisi aktivitas tinggi, iklim panas, atau kurangnya kesadaran untuk minum secara teratur.

Tanda klinis dehidrasi biasanya diklasifikasikan menjadi dehidrasi ringan, sedang, dan berat berdasarkan gejala klinis yang muncul. Secara umum, tanda dehidrasi ringan hingga sedang dapat dikenali melalui beberapa indikator klinis berikut:

Dehidrasi ringan

- 1) Rasa haus meningkat
- 2) Mulut atau bibir terasa kering
- 3) Warna urin lebih pekat
- 4) Frekuensi berkemih berkurang
- 5) Rasa lelah atau sakit kepala ringan

Dehidrasi sedang

- 1) Haus yang sangat kuat
- 2) Mulut dan mata kering
- 3) Urin sangat pekat atau jarang berkemih
- 4) Pusing saat berdiri
- 5) Denyut nadi meningkat
- 6) Penurunan turgor kulit

Pedoman klinis menunjukkan bahwa tanda dehidrasi dapat meliputi mulut kering, rasa haus berlebihan, penurunan turgor kulit, mata cekung, dan peningkatan denyut nadi sebagai respons kompensasi tubuh terhadap kekurangan cairan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Pada ibu nifas, bidan perlu melakukan pemantauan terhadap tanda-tanda dehidrasi melalui observasi klinis sederhana seperti warna urin, frekuensi berkemih, kondisi mukosa mulut, serta tingkat kelelahan ibu.

c. Edukasi Pola Minum Realistis pada Ibu Baru

Pada masa postpartum, ibu sering mengalami kelelahan, kurang tidur, serta fokus utama pada perawatan bayi sehingga kebutuhan cairan sering kali terabaikan. Oleh karena itu, edukasi mengenai pola minum yang realistis dan mudah diterapkan menjadi bagian penting dari asuhan kebidanan.

Beberapa strategi edukasi yang dapat diberikan kepada ibu menyusui antara lain:

1) Minum setiap kali selesai menyusui

Refleks oksitosin selama menyusui sering menimbulkan sensasi haus sehingga momen setelah menyusui dapat dimanfaatkan sebagai pengingat alami untuk minum.

2) Menyediakan air minum di dekat tempat menyusui

Menyimpan botol air atau gelas minum di dekat tempat menyusui membantu ibu memenuhi kebutuhan cairan tanpa harus meninggalkan bayi.

3) Mengonsumsi makanan dengan kandungan air tinggi

Buah seperti semangka, jeruk, melon, serta makanan berkuah dapat membantu meningkatkan asupan cairan harian.

4) Menggunakan indikator sederhana

Ibu dapat memantau status hidrasi melalui indikator sederhana seperti warna urin yang jernih atau kuning muda sebagai tanda hidrasi yang cukup.

5) Menetapkan target minum harian

Sebagai panduan praktis, ibu dapat menargetkan konsumsi sekitar 8–12 gelas air per hari atau sekitar 2,5–3 liter cairan selama masa menyusui.

Edukasi yang realistis dan berbasis kebiasaan sehari-hari terbukti lebih efektif dalam membantu ibu mempertahankan hidrasi yang adekuat selama masa menyusui. Oleh karena itu, bidan perlu menyesuaikan strategi edukasi dengan kondisi sosial, budaya, serta rutinitas ibu postpartum.

d. Ringkasan Praktis Hidrasi Ibu Menyusui untuk Edukasi Pasien

Hidrasi yang adekuat merupakan bagian penting dalam pemulihan ibu nifas dan keberhasilan proses menyusui. Air merupakan komponen utama dalam ASI dengan proporsi sekitar 87% dari total komposisi ASI, sehingga kebutuhan cairan ibu meningkat selama masa laktasi untuk menggantikan cairan yang hilang melalui produksi ASI (Mazur et al., 2024).

Rata-rata produksi ASI berkisar 700–780 ml per hari, sehingga ibu menyusui dianjurkan menambah asupan cairan sekitar 700 ml di atas kebutuhan normal untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh (Institute of Medicine, 2020); (Mazur et al., 2024).

Beberapa organisasi kesehatan merekomendasikan total asupan cairan ibu menyusui sekitar 2,7–3,1 liter per hari, tergantung aktivitas, iklim, serta kondisi kesehatan ibu (Malisova et al., 2024).

Dalam praktik kebidanan, bidan perlu memberikan edukasi yang mudah dipahami oleh ibu menyusui agar kebutuhan cairan dapat dipenuhi secara konsisten.

Tabel 1. 3 Ringkasan Praktis Hidrasi Ibu Menyusui untuk Edukasi Pasien

Aspek	Rekomendasi Praktis	Penjelasan Klinis
Kebutuhan cairan harian	±2,7 – 3,1 liter per hari	Menggantikan cairan yang hilang melalui produksi ASI
Tambahan cairan saat menyusui	+700 ml dari kebutuhan normal	Rata-rata volume air yang hilang melalui ASI
Frekuensi minum	8–12 gelas per hari	Dapat dibagi sepanjang hari
Waktu minum yang dianjurkan	Setelah menyusui atau saat merasa haus	Refleks oksitosin saat menyusui sering memicu rasa haus
Sumber cairan terbaik	Air putih, susu, sup, buah tinggi air	Sekitar 70–80% cairan berasal dari minuman
Indikator hidrasi cukup	Urin kuning pucat, tidak haus berlebihan, energi cukup	Warna urin merupakan indikator hidrasi yang sederhana
Tanda dehidrasi	Urin gelap, bibir kering, pusing, kelelahan	Perlu meningkatkan asupan cairan
Minuman yang perlu dibatasi	Kafein berlebihan, minuman tinggi gula	Dapat meningkatkan diuresis atau kalori kosong

Edukasi yang sederhana dan praktis seperti pada tabel di atas membantu ibu memahami kebutuhan cairan tanpa harus menghitung secara kompleks. Pemantauan hidrasi juga dapat dilakukan melalui indikator sederhana seperti warna urin dan frekuensi berkemih, yang merupakan cara mudah untuk menilai keseimbangan cairan tubuh dalam kehidupan sehari-hari.

e. Flowchart Klinis Penilaian Status Hidrasi Ibu Nifas di Pelayanan Kebidanan

Penilaian status hidrasi merupakan bagian dari asesmen klinis pada masa nifas. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi secara dini risiko dehidrasi yang dapat memengaruhi kesehatan ibu, produksi ASI, serta kemampuan ibu dalam merawat bayi.

Dehidrasi pada ibu menyusui dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya asupan cairan, aktivitas fisik berlebihan, iklim panas, atau kondisi medis seperti demam, diare, dan muntah. Gejala yang sering muncul meliputi rasa haus berlebihan, urin berwarna pekat, sakit kepala, kelelahan, dan penurunan frekuensi berkemih (MomJunction, 2024).

Pendekatan algoritmik membantu bidan melakukan penilaian secara sistematis sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran.

Gambar 1. 1 Penilaian Status Hidrasi Ibu Nifas

5. Rekomendasi Suplementasi Dasar

Masa nifas dan menyusui merupakan periode yang memerlukan perhatian khusus terhadap pemenuhan zat gizi ibu. Selama proses laktasi, tubuh ibu tidak hanya memenuhi kebutuhan metabolisme dirinya sendiri tetapi juga menyediakan nutrisi optimal bagi bayi melalui produksi air susu ibu (ASI). Oleh karena itu, pemenuhan gizi seimbang dari makanan sehari-hari sering kali perlu didukung dengan suplementasi tertentu, terutama pada kondisi ibu dengan risiko kekurangan zat gizi atau kebutuhan fisiologis yang meningkat (Koletzko et al., 2020).

Suplementasi pada ibu menyusui bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu, mendukung kualitas dan kuantitas ASI, serta mencegah terjadinya defisiensi mikronutrien yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Beberapa suplemen yang paling sering direkomendasikan pada masa menyusui antara lain zat besi, vitamin D, dan asam lemak omega-3 seperti docosahexaenoic acid (DHA) (WHO, 2023).

Namun demikian, pemberian suplementasi tidak selalu bersifat universal untuk semua ibu menyusui. Tenaga kesehatan, khususnya bidan, perlu melakukan penilaian status gizi, riwayat kesehatan ibu, pola makan, serta kondisi klinis tertentu sebelum merekomendasikan suplemen. Pendekatan ini penting untuk memastikan suplementasi diberikan secara tepat sasaran dan berbasis kebutuhan klinis (Victora et al., 2016).

a. Indikasi Suplementasi Zat Besi

Zat besi merupakan mikronutrien esensial yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin dan transport oksigen dalam tubuh. Pada masa kehamilan dan persalinan, ibu mengalami peningkatan kebutuhan zat besi serta kehilangan darah selama proses persalinan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko anemia pada masa nifas apabila cadangan zat besi tubuh tidak mencukupi.

Anemia pada ibu nifas dapat berdampak pada berbagai aspek kesehatan, termasuk kelelahan kronis, gangguan fungsi kognitif, peningkatan risiko depresi postpartum, serta penurunan kemampuan ibu dalam merawat bayi. Selain itu, anemia juga dapat mempengaruhi keberhasilan menyusui karena

ibu merasa mudah lelah dan kurang energi untuk menyusui secara optimal (Benson et al., 2024).

Organisasi kesehatan dunia merekomendasikan pemberian suplementasi zat besi pada ibu postpartum terutama pada ibu yang mengalami anemia atau berisiko tinggi mengalami anemia. Dosis yang umum direkomendasikan adalah sekitar 30–60 mg zat besi elemental per hari, yang dapat diberikan selama beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung kondisi klinis ibu (WHO, 2023).

Indikasi utama pemberian suplementasi zat besi pada ibu menyusui antara lain:

- 1) Hb < 12 g/dL setelah persalinan
- 2) Riwayat anemia selama kehamilan
- 3) Perdarahan postpartum
- 4) Asupan makanan rendah zat besi
- 5) Ibu dengan kelelahan berat atau gejala anemia

Selain suplementasi, bidan juga perlu memberikan edukasi mengenai sumber makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati, ikan, telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Konsumsi vitamin C juga dianjurkan untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan.

b. Suplementasi Vitamin D

Vitamin D memiliki peran penting dalam metabolisme kalsium dan fosfor serta dalam menjaga kesehatan tulang ibu dan bayi. Pada masa menyusui, status vitamin D ibu sangat mempengaruhi kadar vitamin D dalam ASI. Oleh karena itu, ibu dengan kadar vitamin D yang rendah berpotensi menghasilkan ASI dengan kandungan vitamin D yang juga rendah (Koletzko et al., 2020).

Defisiensi vitamin D masih menjadi masalah kesehatan global, termasuk pada ibu menyusui. Faktor risiko kekurangan vitamin D antara lain kurang paparan sinar matahari, penggunaan pakaian tertutup, obesitas, serta asupan makanan yang rendah vitamin D (Sadek, 2025).

Beberapa pedoman merekomendasikan suplementasi vitamin D pada ibu menyusui dengan dosis sekitar 600–2000 IU per hari, tergantung pada status vitamin D ibu. Pada kondisi tertentu, seperti defisiensi yang terkonfirmasi secara laboratorium, dosis yang lebih tinggi dapat diberikan di bawah pengawasan tenaga kesehatan (WHO, 2023).

Selain melalui suplementasi, vitamin D juga dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari pagi selama 10–15 menit serta konsumsi makanan seperti ikan berlemak, telur, dan produk susu yang difortifikasi.

c. Suplementasi DHA

Docosahexaenoic acid (DHA) merupakan salah satu asam lemak omega-3 yang berperan penting dalam perkembangan otak dan sistem saraf bayi. DHA merupakan komponen utama dalam membran sel otak dan retina, sehingga kecukupan DHA selama masa menyusui sangat penting untuk mendukung perkembangan kognitif dan visual bayi (Koletzko et al., 2020).

Kadar DHA dalam ASI sangat dipengaruhi oleh pola makan ibu. Ibu yang jarang mengonsumsi ikan laut atau makanan sumber omega-3 berisiko memiliki kadar DHA yang rendah dalam ASI. Oleh karena itu, suplementasi DHA sering direkomendasikan terutama pada ibu dengan asupan omega-3 yang rendah (Klatt et al., 2022).

Rekomendasi asupan DHA bagi ibu menyusui berkisar 200–300 mg per hari. Sumber alami DHA meliputi ikan laut seperti salmon, sarden, dan tuna. Apabila konsumsi ikan terbatas, suplementasi DHA dapat menjadi alternatif untuk memastikan kecukupan asupan (Koletzko et al., 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan asupan DHA pada ibu menyusui dapat meningkatkan kadar DHA dalam ASI serta memberikan manfaat terhadap perkembangan neurologis bayi, terutama pada bayi prematur (Klatt et al., 2022).

d. Kapan Perlu Rujukan Gizi Klinis

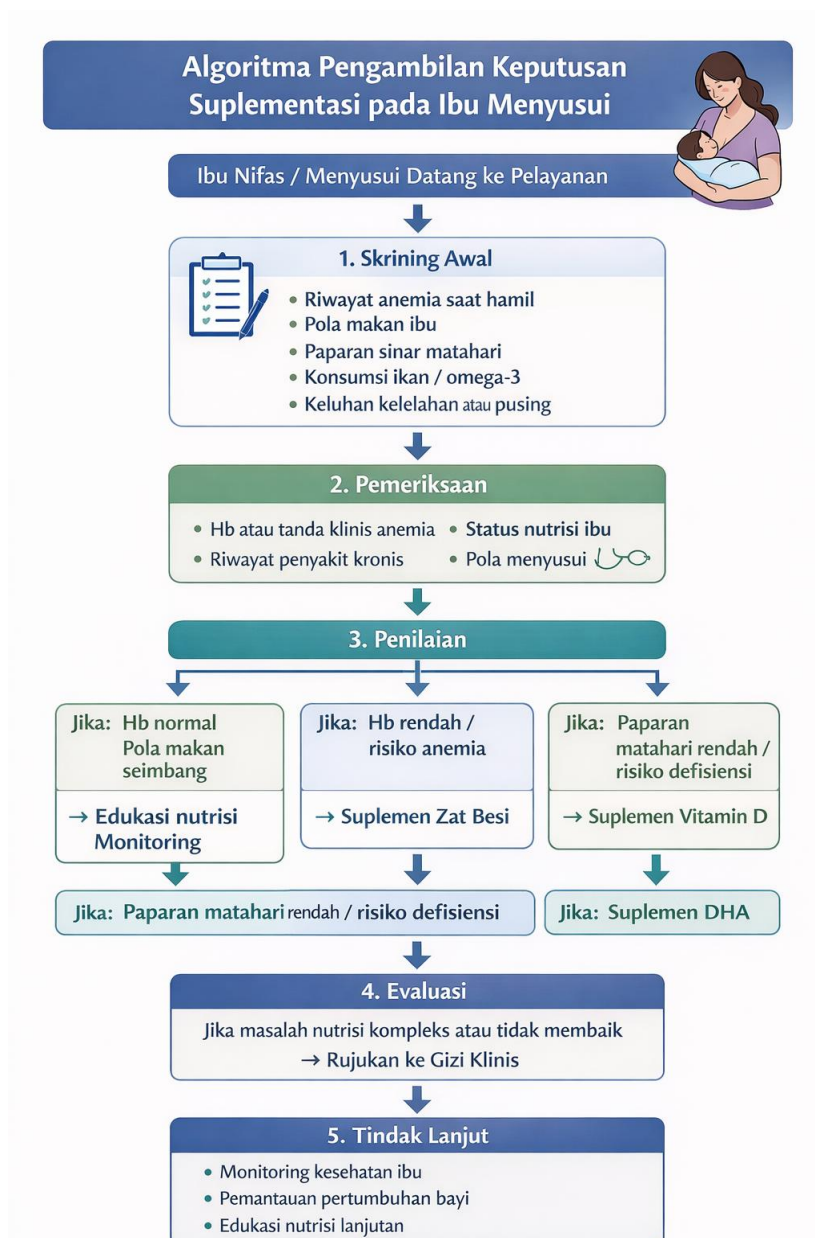
Tidak semua permasalahan gizi pada ibu menyusui dapat ditangani secara mandiri di pelayanan kebidanan primer. Pada kondisi tertentu, ibu perlu dirujuk ke tenaga gizi klinis atau dokter spesialis untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif.

Beberapa kondisi yang memerlukan rujukan gizi klinis antara lain:

- 1) Anemia berat yang tidak membaik setelah suplementasi
- 2) Penurunan berat badan ibu yang signifikan
- 3) Ibu dengan penyakit kronis (diabetes, penyakit ginjal, penyakit autoimun)
- 4) Bayi dengan pertumbuhan tidak optimal yang diduga terkait faktor nutrisi ibu

Kolaborasi antara bidan dan tenaga gizi klinis sangat penting dalam memberikan intervensi nutrisi yang tepat dan individual bagi ibu menyusui. Pendekatan multidisiplin ini terbukti meningkatkan keberhasilan menyusui serta kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan (Victora et al., 2016).

Disertai algoritma pengambilan keputusan sederhana.



Gambar 1. 2 Algoritma Pengambilan Keputusan Suplementasi

Sumber: Modifikasi penulis berdasarkan WHO (2023), Pedoman Gizi Seimbang Kemenkes RI (2024), dan berbagai literatur gizi laktasi.

Keterangan Klinis

Algoritma ini digunakan oleh bidan atau tenaga kesehatan untuk membantu menentukan kebutuhan suplementasi pada ibu menyusui secara sistematis. Penilaian dimulai dari skrining awal terhadap faktor risiko nutrisi, diikuti dengan pemeriksaan klinis dan interpretasi hasil. Berdasarkan temuan tersebut, tenaga kesehatan dapat menentukan apakah ibu memerlukan edukasi nutrisi saja atau suplementasi spesifik seperti zat besi, vitamin D, atau DHA.

Rekomendasi suplementasi pada masa postpartum umumnya mencakup zat besi sekitar 45–60 mg per hari selama beberapa bulan setelah persalinan, serta

vitamin D minimal 400–1000 IU per hari selama masa menyusui, terutama pada ibu dengan paparan sinar matahari rendah. Selain itu, asupan omega-3 terutama DHA sekitar 200–300 mg per hari dianjurkan untuk mendukung perkembangan neurologis bayi dan kualitas ASI (Koletzko et al., 2020); GAPSS Nutrition Framework, 2024).

Apabila ditemukan masalah nutrisi yang kompleks, anemia yang tidak membaik, atau kondisi medis tertentu, maka ibu perlu dirujuk ke tenaga gizi klinis untuk evaluasi dan intervensi nutrisi yang lebih komprehensif.

6. Edukasi Gizi Berbasis Bukti dan Komunikasi Terapeutik

Edukasi gizi merupakan bagian penting dalam asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Pada periode ini, ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis, psikologis, serta adaptasi terhadap peran baru sebagai ibu. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pola makan, kebutuhan nutrisi, dan praktik menyusui. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi gizi yang tidak hanya berbasis bukti ilmiah, tetapi juga disampaikan melalui komunikasi terapeutik yang empatik dan menghargai pengalaman ibu (Riordan, J., & Wambach, 2022).

Komunikasi terapeutik dalam pelayanan kebidanan bertujuan membangun hubungan saling percaya antara bidan dan ibu. Hubungan ini memungkinkan ibu untuk merasa aman dalam menyampaikan kekhawatiran, pengalaman, maupun kesulitan yang dialami selama masa menyusui. Dengan pendekatan komunikasi yang tepat, edukasi gizi dapat diterima dengan lebih baik dan meningkatkan kemungkinan perubahan perilaku yang positif (WHO, 2023).

Dalam konteks praktik kebidanan berbasis bukti (*evidence-based practice*), edukasi gizi perlu didasarkan pada informasi ilmiah yang terkini dan relevan. Tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa pesan edukasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu ibu, kondisi kesehatan, budaya lokal, serta tingkat literasi kesehatan ibu. Pendekatan ini membantu meningkatkan efektivitas edukasi dan mendukung keberhasilan menyusui secara berkelanjutan (Nowak-Szczepanska et al., 2021).

a. Prinsip Edukasi Non-Judgmental

Pendekatan non-judgmental merupakan prinsip utama dalam komunikasi terapeutik. Pendekatan ini menekankan bahwa tenaga kesehatan tidak memberikan penilaian negatif terhadap pilihan atau pengalaman ibu, tetapi berfokus pada pemahaman dan dukungan terhadap kebutuhan ibu.

Banyak ibu menyusui merasa tertekan karena berbagai informasi yang bertentangan mengenai nutrisi dan praktik menyusui. Apabila edukasi disampaikan dengan cara yang menghakimi, ibu dapat merasa bersalah atau

tidak percaya diri dalam menjalankan peran sebagai ibu. Oleh karena itu, komunikasi yang empatik dan menghargai sangat penting untuk membangun kepercayaan ibu terhadap tenaga kesehatan (Rollnick et al., 2008).

Beberapa prinsip edukasi non-judgmental dalam pelayanan kebidanan meliputi:

- 1) Mendengarkan pengalaman ibu tanpa menghakimi
- 2) Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami
- 3) Menghargai latar belakang budaya dan kebiasaan makan keluarga
- 4) Memberikan pilihan solusi yang realistis
- 5) Mendukung ibu untuk mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya dan bayinya

Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepatuhan ibu terhadap rekomendasi kesehatan serta meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif (Nowak-Szczepanska et al., 2021).

b. Menghindari Mitos Makanan Pantangan

Di banyak masyarakat, terdapat berbagai kepercayaan mengenai makanan yang dianggap tidak boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui. Beberapa pantangan makanan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah, namun tetap dipraktikkan secara turun-temurun dalam keluarga.

Contoh mitos yang sering ditemukan antara lain larangan mengonsumsi ikan, telur, atau makanan tertentu karena dianggap dapat menyebabkan bayi sakit perut atau produksi ASI menjadi berkurang. Padahal, sebagian besar makanan tersebut justru merupakan sumber nutrisi penting bagi ibu menyusui, seperti protein, zat besi, dan asam lemak omega-3 (Koletzko et al., 2020).

Tenaga kesehatan perlu menjelaskan kepada ibu bahwa sebagian besar makanan bergizi aman dikonsumsi selama masa menyusui. Yang lebih penting adalah menjaga pola makan yang seimbang dan beragam agar kebutuhan nutrisi ibu terpenuhi. Penjelasan mengenai mitos makanan sebaiknya disampaikan secara sensitif dan menghargai budaya setempat agar ibu tetap merasa dihargai (Lawrence, R. A., & Lawrence, 2022)(WHO, 2023).

Strategi edukasi yang efektif dalam mengatasi mitos makanan antara lain:

- 1) menjelaskan fakta ilmiah secara sederhana
- 2) memberikan contoh menu makanan sehat
- 3) melibatkan keluarga dalam proses edukasi
- 4) menghubungkan pesan kesehatan dengan praktik budaya yang positif

Pendekatan ini membantu ibu memahami informasi kesehatan tanpa merasa bahwa tradisi keluarga mereka disalahkan.

c. Teknik Konseling Singkat Berbasis Kebutuhan Ibu

Konseling gizi pada ibu menyusui tidak selalu memerlukan waktu yang panjang. Dalam praktik pelayanan kebidanan, bidan dapat menggunakan teknik konseling singkat berbasis kebutuhan ibu (brief counseling) yang berfokus pada masalah utama yang dialami ibu.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah model GATHER, yang meliputi:

- 1) **Greet** – menyambut ibu dengan ramah
- 2) **Ask** – menanyakan kebutuhan atau keluhan ibu
- 3) **Tell** – memberikan informasi yang relevan
- 4) **Help** – membantu ibu memilih solusi yang sesuai
- 5) **Explain** – menjelaskan langkah yang perlu dilakukan
- 6) **Return** – merencanakan tindak lanjut atau kunjungan berikutnya

Pendekatan konseling singkat ini membantu tenaga kesehatan memberikan edukasi yang fokus dan efisien tanpa mengurangi kualitas komunikasi terapeutik. Penelitian menunjukkan bahwa konseling berbasis kebutuhan ibu dapat meningkatkan pemahaman ibu mengenai nutrisi serta meningkatkan keberhasilan menyusui (Rollnick et al., 2008).

Selain itu, penggunaan pertanyaan terbuka juga sangat dianjurkan dalam konseling gizi. Pertanyaan terbuka memungkinkan ibu untuk menjelaskan pengalaman dan kebutuhannya secara lebih luas. Misalnya, bidan dapat menanyakan:

“Bagaimana pola makan ibu sejak melahirkan?”

“Apakah ada makanan yang ibu hindari selama menyusui?”

Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan memahami konteks kehidupan ibu sebelum memberikan rekomendasi nutrisi.

d. Contoh Dialog Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik dapat membantu ibu merasa didukung dan dihargai selama proses edukasi. Berikut contoh dialog sederhana antara bidan dan ibu menyusui dalam konteks edukasi gizi.

Bidan:

“Ibu, bagaimana pola makan ibu sejak melahirkan? Apakah ada makanan tertentu yang ibu hindari?”

Ibu:

“Saya tidak makan ikan karena katanya bisa membuat bayi sakit perut.”

Bidan:

“Saya memahami kekhawatiran ibu. Sebenarnya ikan justru mengandung nutrisi penting seperti protein dan omega-3 yang baik untuk perkembangan

otak bayi. Jika ibu tidak memiliki alergi, ikan aman dikonsumsi selama menyusui.”

Ibu:

“Jadi saya boleh makan ikan?”

Bidan:

“Boleh, ibu. Bahkan dianjurkan sekitar dua sampai tiga kali seminggu. Jika ibu kurang suka ikan, kita juga bisa mencari sumber nutrisi lain yang setara.”

Dialog tersebut menunjukkan pendekatan komunikasi yang empatik, informatif, dan tidak menghakimi. Pendekatan ini membantu ibu menerima informasi kesehatan dengan lebih terbuka.

e. Dokumentasi Edukasi dalam Asuhan Kebidanan

Sebagai bagian dari praktik kebidanan berbasis kompetensi, edukasi yang diberikan kepada ibu perlu didokumentasikan secara sistematis. Dokumentasi tersebut mencakup:

- 1) masalah atau kebutuhan ibu
- 2) materi edukasi yang diberikan
- 3) respons ibu terhadap edukasi
- 4) rencana tindak lanjut

Dokumentasi yang baik membantu memastikan kesinambungan pelayanan serta memudahkan tenaga kesehatan lain dalam melanjutkan asuhan yang telah diberikan. Selain itu, dokumentasi edukasi juga menjadi bagian penting dalam penilaian mutu pelayanan kebidanan dan pembelajaran berbasis kompetensi (WHO, 2023).

Tabel 1. 4 Strategi Edukasi Gizi untuk Ibu Nifas di Pelayanan Kebidanan

Situasi Klinis Ibu	Masalah Gizi yang Mungkin Terjadi	Strategi Edukasi Bidan	Contoh Pesan Edukasi kepada Ibu
Ibu nifas dengan kelelahan dan nafsu makan menurun	Asupan energi tidak mencukupi	Edukasi porsi kecil tetapi sering, pilih makanan padat gizi	“Ibu bisa makan dalam porsi kecil tapi lebih sering, misalnya 4–5 kali sehari agar energi tetap stabil.”
Ibu dengan riwayat anemia saat hamil	Kekurangan zat besi	Anjurkan konsumsi makanan tinggi zat besi dan	“Makanan seperti daging, hati, ikan, dan sayuran hijau dapat membantu

		suplemen sesuai indikasi	meningkatkan kadar zat besi ibu."
Ibu menghindari makanan tertentu karena mitos	Risiko kekurangan protein atau mikronutrien	Klarifikasi mitos makanan dengan pendekatan non-judgmental	"Beberapa makanan sebenarnya aman untuk ibu menyusui dan justru membantu meningkatkan kualitas ASI."
Ibu menyusui dengan aktivitas tinggi	Kebutuhan energi meningkat	Edukasi penambahan kalori dan camilan sehat	"Ibu menyusui membutuhkan energi tambahan, jadi camilan sehat seperti buah, kacang, atau yogurt bisa membantu."
Ibu dengan bayi prematur	Kebutuhan nutrisi ibu lebih tinggi untuk kualitas ASI	Edukasi konsumsi protein, DHA, dan cairan yang cukup	"Konsumsi ikan atau sumber omega-3 dapat membantu mendukung perkembangan otak bayi."
Ibu dengan hidrasi kurang	Risiko produksi ASI menurun	Edukasi pola minum teratur sepanjang hari	"Cobalah minum setiap kali selesai menyusui agar kebutuhan cairan tetap tercukupi."
Ibu dengan dukungan keluarga terbatas	Kesulitan mempertahankan pola makan sehat	Libatkan keluarga dalam edukasi	"Jika memungkinkan, keluarga dapat membantu menyiapkan makanan sehat agar ibu memiliki waktu cukup untuk beristirahat dan menyusui."

C. Menyusun rencana dukungan gaya hidup sehat (istirahat, aktivitas, manajemen stres, higienitas) yang realistis

1. Istirahat dan Manajemen Energi

Masa nifas merupakan periode adaptasi fisiologis dan psikologis yang signifikan bagi seorang ibu. Selain pemulihan setelah proses persalinan, ibu juga harus menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru dalam merawat bayi, termasuk aktivitas menyusui yang berlangsung sepanjang hari dan malam. Kondisi ini sering menyebabkan gangguan pola tidur serta peningkatan kelelahan fisik pada ibu. Oleh karena itu, manajemen istirahat dan energi menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan ibu serta mendukung keberhasilan menyusui (Heck, 2020).

Istirahat yang cukup berperan penting dalam proses pemulihan jaringan tubuh setelah persalinan, stabilitas hormon, serta keseimbangan emosional ibu. Kurang tidur pada masa nifas dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, depresi postpartum, serta menurunkan kemampuan ibu dalam merawat bayi dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, kelelahan yang berkepanjangan juga dapat memengaruhi produksi ASI dan keberhasilan menyusui.

Dalam praktik pelayanan kebidanan, bidan perlu memberikan edukasi kepada ibu mengenai pentingnya manajemen energi dan strategi istirahat yang realistis selama masa nifas. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada ibu, tetapi juga kepada keluarga sebagai sistem pendukung utama dalam perawatan ibu dan bayi.

a. Pola Tidur Ibu Nifas

Pola tidur ibu pada masa nifas biasanya mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan sebelum kehamilan. Bayi baru lahir memiliki pola tidur yang belum teratur dan sering terbangun setiap dua hingga tiga jam untuk menyusui. Kondisi ini menyebabkan ibu mengalami gangguan tidur berulang sepanjang malam.

Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ibu postpartum mengalami penurunan durasi tidur hingga satu hingga dua jam per malam dibandingkan sebelum melahirkan. Selain itu, kualitas tidur ibu juga cenderung menurun karena sering terbangun untuk menyusui atau merawat bayi.

Gangguan tidur pada masa nifas juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, antara lain:

- 1) nyeri perineum atau luka operasi
- 2) kecemasan terkait perawatan bayi
- 3) perubahan hormon postpartum

4) kurangnya dukungan keluarga

Apabila gangguan tidur berlangsung dalam jangka waktu yang lama, ibu berisiko mengalami kelelahan yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, pemantauan kualitas tidur ibu menjadi bagian penting dalam asuhan kebidanan pada masa nifas (Heck, 2020).

b. *Sleep Fragmentation* dan Dampaknya pada Produksi ASI

Sleep fragmentation merupakan kondisi di mana tidur seseorang sering terputus dalam waktu singkat sehingga siklus tidur tidak berlangsung secara optimal. Pada ibu menyusui, sleep fragmentation sering terjadi karena bayi perlu menyusu secara berkala pada malam hari.

Meskipun terbangun pada malam hari merupakan bagian normal dari proses menyusui, gangguan tidur yang berlebihan dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan tingkat energi ibu. Hormon prolaktin yang berperan dalam produksi ASI memiliki pola sekresi yang dipengaruhi oleh ritme sirkadian tubuh. Gangguan tidur yang berkepanjangan dapat mengganggu regulasi hormon tersebut .

Selain itu, kelelahan akibat kurang tidur dapat menyebabkan ibu merasa stres dan kurang percaya diri dalam menyusui. Kondisi psikologis tersebut dapat mempengaruhi refleks oksitosin yang berperan dalam pengeluaran ASI. Apabila refleks oksitosin terhambat, ibu mungkin merasa produksi ASI berkurang meskipun sebenarnya produksi ASI masih cukup (Victora et al., 2016).

Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa menyusui pada malam hari sebenarnya memiliki manfaat penting dalam mempertahankan produksi ASI. Hisapan bayi pada malam hari dapat merangsang peningkatan kadar prolaktin yang membantu mempertahankan produksi ASI yang optimal .

c. Strategi “Rest While Baby Sleeps”

Salah satu strategi yang sering dianjurkan kepada ibu nifas adalah prinsip “*rest while baby sleeps*”, yaitu beristirahat ketika bayi sedang tidur. Strategi ini membantu ibu memperoleh waktu istirahat tambahan meskipun pola tidur malam terganggu.

Dalam praktiknya, ibu sering mengalami kesulitan menerapkan strategi ini karena berbagai tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, bidan perlu membantu ibu dan keluarga memahami bahwa istirahat merupakan bagian penting dari proses pemulihan postpartum.

Beberapa strategi praktis yang dapat dianjurkan kepada ibu antara lain:

- 1) Beristirahat atau tidur ketika bayi tidur, terutama pada siang hari
- 2) Mengurangi aktivitas rumah tangga yang tidak mendesak

- 3) Meminta bantuan keluarga dalam pekerjaan rumah
- 4) Membatasi kunjungan tamu pada minggu-minggu awal setelah persalinan
- 5) Mengatur jadwal menyusui dan istirahat secara fleksibel

Strategi ini membantu ibu mempertahankan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas menyusui serta perawatan bayi secara optimal.

d. Edukasi Realistik untuk Keluarga

Keberhasilan manajemen istirahat pada ibu nifas sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Dalam banyak budaya, ibu sering tetap diharapkan menjalankan tugas rumah tangga meskipun baru saja melahirkan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kelelahan postpartum.

Tenaga kesehatan perlu melibatkan keluarga dalam proses edukasi mengenai kebutuhan istirahat ibu nifas. Keluarga perlu memahami bahwa pemulihan setelah persalinan membutuhkan waktu dan dukungan dari lingkungan sekitar.

Beberapa bentuk dukungan keluarga yang dapat membantu ibu nifas antara lain:

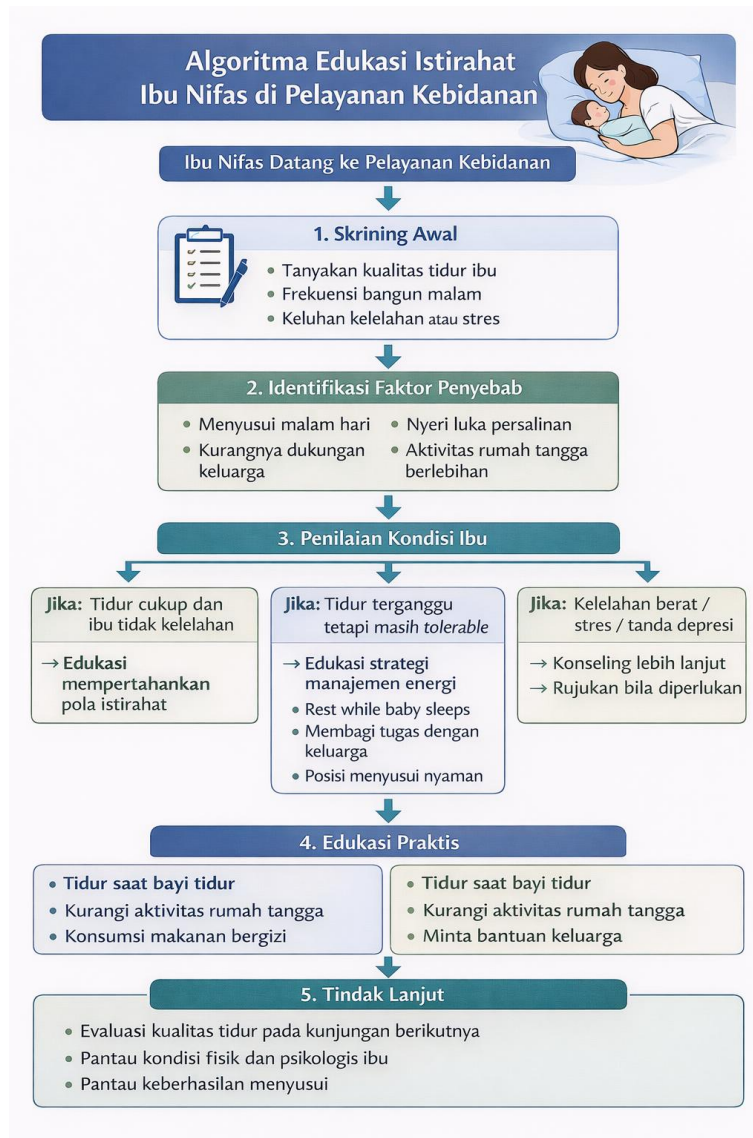
- 1) membantu pekerjaan rumah tangga
- 2) membantu merawat bayi pada waktu tertentu
- 3) memastikan ibu memiliki waktu untuk beristirahat
- 4) memberikan dukungan emosional

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang baik berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan ibu serta keberhasilan menyusui eksklusif. Oleh karena itu, edukasi mengenai manajemen energi tidak hanya ditujukan kepada ibu, tetapi juga kepada anggota keluarga sebagai bagian dari sistem pendukung utama (Nowak-Szczepanska et al., 2021).

Tabel 1. 5 Strategi Manajemen Energi Ibu Nifas di Rumah

Situasi yang Dialami Ibu	Dampak pada Energi Ibu	Strategi Manajemen Energi	Edukasi yang Dapat Disampaikan Bidan
Bayi sering terbangun pada malam hari	Gangguan tidur dan kelelahan	Anjurkan ibu tidur ketika bayi tidur	"Jika bayi tidur siang, ibu juga bisa beristirahat agar 34 nergy tetap terjaga."
Aktivitas rumah tangga berlebihan	Kelelahan fisik	Prioritaskan aktivitas penting dan tunda	"Pada minggu pertama setelah melahirkan, 34 nerg utama ibu

		pekerjaan yang tidak mendesak	adalah pemulihan dan menyusui."
Kurang dukungan keluarga	Beban perawatan bayi meningkat	Libatkan pasangan atau anggota keluarga dalam perawatan bayi	"Keluarga dapat membantu mengganti popok atau menenangkan bayi agar ibu memiliki waktu istirahat."
Pola makan tidak teratur	Energi tubuh menurun	Anjurkan makan teratur dan camilan sehat	"Camilan sehat seperti buah atau kacang dapat membantu menjaga 35energy ibu."
Stres atau kecemasan postpartum	Kelelahan mental	Ajarkan teknik relaksasi sederhana	"Menarik napas dalam dan beristirahat sejenak dapat membantu ibu merasa lebih tenang."
Menyusui sering tanpa jeda	Kelelahan fisik dan mental	Gunakan posisi menyusui yang nyaman dan dukungan bantal	"Posisi menyusui yang nyaman membantu ibu lebih rileks dan mengurangi kelelahan."
Jadwal kunjungan tamu terlalu padat	Waktu istirahat ibu berkurang	Batasi kunjungan pada minggu awal postpartum	"Ibu boleh membatasi kunjungan agar memiliki waktu cukup untuk beristirahat."



Gambar 1. 3 Algoritma Edukasi istirahat Ibu Nifas di Pelayanan Kebidanan

Sumber: Diadaptasi dan dimodifikasi oleh penulis berdasarkan WHO Recommendations on Maternal and Newborn Care for a Positive Postnatal Experience (2022), ACOG Optimizing Postpartum Care (2021), dan Murray & McKinney (2020).

2. Aktivitas Fisik Postpartum

a. Konsep Aktivitas Fisik pada Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode transisi fisiologis yang penting bagi pemulihan tubuh ibu setelah proses kehamilan dan persalinan. Pada periode ini terjadi berbagai perubahan fisiologis seperti involusi uterus, penyembuhan jaringan perineum, adaptasi hormonal, serta penyesuaian metabolisme tubuh terhadap proses laktasi. Aktivitas fisik yang dilakukan secara bertahap dan sesuai kondisi ibu dapat membantu mempercepat pemulihan fungsi tubuh, meningkatkan kesehatan kardiovaskular, memperbaiki suasana hati, serta mendukung keseimbangan energi selama menyusui (Bains et al., 2025).

Organisasi kesehatan dunia merekomendasikan bahwa ibu postpartum dapat mulai melakukan aktivitas fisik ringan secara bertahap setelah persalinan normal, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan proses pemulihan jaringan. Aktivitas fisik yang aman dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dasar panggul, memperbaiki postur tubuh, serta mengurangi risiko komplikasi seperti inkontinensia urin atau nyeri punggung (World Health Organization, 2022).

Selain manfaat fisik, aktivitas fisik juga memiliki efek positif terhadap kesehatan mental ibu nifas. Latihan ringan terbukti dapat membantu mengurangi gejala stres, kecemasan, dan risiko depresi postpartum melalui peningkatan pelepasan endorfin serta regulasi hormon stres (Kołomańska-Bogucka & Mazur-Bialy, 2019);(Bains et al., 2025). Oleh karena itu, edukasi mengenai aktivitas fisik postpartum merupakan bagian penting dari pelayanan kebidanan berbasis promotif dan preventif.

b. Waktu Aman Memulai Aktivitas Fisik

Waktu aman untuk memulai aktivitas fisik pada ibu postpartum bergantung pada jenis persalinan, kondisi kesehatan ibu, serta adanya komplikasi selama kehamilan atau persalinan.

Pada persalinan normal tanpa komplikasi, aktivitas ringan seperti berjalan santai atau latihan dasar panggul dapat dimulai dalam beberapa hari setelah persalinan, selama ibu merasa nyaman dan tidak mengalami nyeri yang signifikan. Aktivitas ini dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mencegah trombosis, serta mempercepat pemulihan otot (Kwiatkowska et al., 2024).

Pada ibu yang menjalani persalinan dengan tindakan operasi seperti *sectio caesarea*, aktivitas fisik biasanya dianjurkan dimulai secara bertahap setelah luka operasi menunjukkan proses penyembuhan yang baik, umumnya sekitar 6 minggu postpartum atau sesuai evaluasi tenaga kesehatan. Pada periode awal, ibu dianjurkan melakukan mobilisasi ringan seperti berjalan pendek untuk mencegah komplikasi imobilisasi (Kwiatkowska et al., 2024).

Penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi bahwa aktivitas fisik postpartum tidak bertujuan untuk menurunkan berat badan secara cepat, melainkan untuk memulihkan fungsi tubuh dan meningkatkan kesehatan ibu secara menyeluruh. Pendekatan ini membantu mencegah tekanan psikologis terhadap ibu yang baru melahirkan.

c. Latihan Ringan yang Direkomendasikan

Aktivitas fisik postpartum sebaiknya dimulai dengan latihan ringan yang aman bagi tubuh ibu. Beberapa jenis latihan yang direkomendasikan antara lain latihan dasar panggul (Kegel), peregangan ringan, serta aktivitas berjalan.

1) Latihan Kegel

Latihan Kegel merupakan latihan kontraksi otot dasar panggul yang bertujuan memperkuat otot yang mendukung uterus, kandung kemih, dan rektum. Latihan ini sangat penting pada masa nifas karena proses kehamilan dan persalinan dapat menyebabkan peregangan otot dasar panggul.

Latihan Kegel dilakukan dengan cara mengontraksikan otot dasar panggul selama 5–10 detik kemudian melepaskannya secara perlahan. Latihan ini dapat diulang beberapa kali dalam sehari. Penelitian menunjukkan bahwa latihan dasar panggul secara rutin dapat mengurangi risiko inkontinensia urin postpartum dan meningkatkan fungsi seksual ibu setelah persalinan (Bo et al., 2017).

2) Peregangan ringan

Peregangan ringan membantu mengurangi kekakuan otot serta meningkatkan fleksibilitas tubuh setelah persalinan. Peregangan dapat dilakukan pada otot leher, bahu, punggung, dan panggul, terutama karena aktivitas menyusui sering menyebabkan ketegangan otot pada area tersebut.

Latihan peregangan juga membantu memperbaiki postur tubuh ibu selama menyusui, sehingga dapat mencegah nyeri muskuloskeletal yang sering dialami ibu pada masa postpartum (*Bains et al., 2025*).

3) Aktivitas berjalan

Berjalan santai merupakan bentuk aktivitas fisik sederhana yang aman dilakukan pada masa nifas. Aktivitas ini dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki fungsi kardiovaskular, serta meningkatkan energi ibu secara bertahap.

Berjalan juga memiliki efek positif terhadap kesehatan mental karena membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi kelelahan psikologis yang sering dialami ibu baru (World Health Organization, 2022).

d. Kontraindikasi Aktivitas Fisik

Meskipun aktivitas fisik memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa kondisi yang memerlukan penundaan atau pembatasan aktivitas fisik pada masa nifas. Tenaga kesehatan perlu melakukan penilaian klinis sebelum memberikan rekomendasi aktivitas kepada ibu.

Beberapa kondisi yang menjadi kontraindikasi sementara aktivitas fisik antara lain:

- 1) Perdarahan postpartum yang masih aktif
- 2) Infeksi postpartum
- 3) Luka operasi yang belum sembuh
- 4) Nyeri hebat pada area perineum atau abdomen
- 5) Anemia berat
- 6) Komplikasi medis seperti preeklampsia postpartum

Pada kondisi tersebut, aktivitas fisik harus ditunda hingga kondisi ibu stabil dan mendapatkan persetujuan dari tenaga kesehatan. Edukasi mengenai tanda bahaya juga penting diberikan kepada ibu agar mereka dapat segera mencari bantuan medis apabila muncul keluhan yang tidak normal (Kwiatkowska et al., 2024).

e. Dampak Aktivitas Fisik terhadap Produksi ASI

Salah satu kekhawatiran yang sering muncul pada ibu menyusui adalah anggapan bahwa aktivitas fisik atau olahraga dapat menurunkan produksi ASI. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang tidak berdampak negatif terhadap volume maupun kualitas ASI (Larson-Meyer, 2002).

Aktivitas fisik justru dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ibu, mengurangi stres, dan memperbaiki kualitas tidur. Kondisi psikologis yang baik pada ibu dapat mendukung refleks oksitosin yang berperan dalam proses pengeluaran ASI (Bains et al., 2025).

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga tidak mengubah komposisi nutrisi utama ASI secara signifikan. Oleh karena itu, ibu menyusui tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dengan memperhatikan kecukupan hidrasi dan asupan energi (Larson-Meyer, 2002).

Tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi yang tepat kepada ibu bahwa aktivitas fisik postpartum merupakan bagian dari gaya hidup sehat yang dapat mendukung proses pemulihan tubuh sekaligus mempertahankan keberhasilan menyusui.

Tabel 1. 6 Rekomendasi Aktivitas Fisik Ibu Nifas(World Health Organization., 2022a)

Aspek	Rekomendasi Klinis	Catatan Edukasi untuk Ibu
Waktu memulai aktivitas	Aktivitas ringan dapat dimulai beberapa hari setelah persalinan normal jika kondisi ibu stabil	Mulai secara bertahap sesuai kemampuan tubuh
Aktivitas awal	Latihan dasar panggul (Kegel), peregangan ringan, berjalan santai	Aktivitas ini membantu pemulihan otot panggul dan sirkulasi darah
Durasi aktivitas	Bertahap menuju ± 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang per minggu	Contoh: berjalan 20–30 menit per hari
Intensitas aktivitas	Intensitas ringan hingga sedang	Ibu masih dapat berbicara saat beraktivitas (“talk test”)
Aktivitas yang dianjurkan	Jalan kaki, yoga ringan, peregangan, latihan dasar panggul	Aktivitas air atau yoga postpartum juga dapat dipertimbangkan
Aktivitas yang perlu dihindari	Olahraga intensitas tinggi, lompatan, atau angkat beban berat pada fase awal	Hindari aktivitas yang memberi tekanan besar pada dasar panggul
Hidrasi dan nutrisi	Pastikan hidrasi cukup sebelum dan sesudah olahraga	Penting bagi ibu menyusui untuk menjaga asupan cairan
Penghentian aktivitas	Hentikan aktivitas jika muncul nyeri, perdarahan, pusing, atau sesak	Segera konsultasi dengan tenaga kesehatan

Aktivitas fisik postpartum yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kebugaran kardiovaskular, memperbaiki suasana hati, serta menurunkan risiko depresi postpartum tanpa memengaruhi produksi ASI atau pertumbuhan bayi.

Evidence Based Practice untuk Mahasiswa

Evidence Based Practice (EBP)

Topik: Aktivitas fisik pada ibu nifas

Temuan penelitian terbaru:

- 1) Aktivitas fisik intensitas sedang setelah persalinan dapat meningkatkan kebugaran kardiovaskular ibu tanpa memengaruhi produksi ASI.
- 2) Olahraga postpartum berhubungan dengan penurunan risiko depresi postpartum serta peningkatan kesejahteraan psikologis ibu.
- 3) Latihan dasar panggul secara rutin efektif mencegah inkontinensia urin pada ibu setelah persalinan.

Implikasi praktik kebidanan

Tenaga kesehatan perlu:

- 1) Memberikan edukasi aktivitas fisik secara individual
- 2) Memulai dari aktivitas ringan
- 3) Memastikan tidak ada kontraindikasi medis
- 4) Memantau respons ibu terhadap aktivitas

D. Manajemen Stres dan Kesehatan Psikologis

1. Adaptasi Psikologis Ibu pada Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode adaptasi yang tidak hanya melibatkan perubahan fisiologis, tetapi juga perubahan psikologis yang signifikan. Setelah persalinan, ibu mengalami perubahan hormon yang cepat, tanggung jawab baru sebagai orang tua, serta penyesuaian terhadap pola tidur dan aktivitas sehari-hari. Kombinasi faktor biologis, psikologis, dan sosial tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan mental ibu pada periode postpartum (Shorey & Ng, 2020).

Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron setelah persalinan terjadi secara drastis dalam beberapa hari pertama postpartum. Perubahan hormonal ini dapat memengaruhi regulasi neurotransmitter di otak yang berperan dalam pengaturan emosi dan suasana hati. Selain itu, kurang tidur, kelelahan fisik, serta tekanan sosial dalam merawat bayi baru lahir juga dapat meningkatkan kerentanan ibu terhadap stres dan gangguan mood postpartum (Gavin et al., 2022).

Dalam praktik kebidanan, pemahaman mengenai adaptasi psikologis ini penting agar tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi secara dini tanda-tanda gangguan emosional pada ibu nifas serta memberikan dukungan yang tepat. Pendekatan yang empatik dan komunikasi terapeutik merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan mental ibu selama masa nifas.

2. Hubungan Stres dan Refleks Oksitosin

Proses menyusui tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisiologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis ibu. Hormon oksitosin memiliki peran penting dalam refleks pengeluaran ASI (let-down reflex). Ketika bayi mengisap

puting susu, impuls saraf dikirim ke hipotalamus sehingga memicu pelepasan hormon oksitosin dari kelenjar hipofisis posterior. Oksitosin kemudian merangsang kontraksi sel mioepitel di alveoli payudara sehingga ASI dapat keluar (Uvnäs-Moberg et al., 2020).

Namun, stres dan kecemasan dapat menghambat pelepasan oksitosin. Ketika ibu mengalami stres, tubuh akan meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon tersebut dapat menghambat refleksi oksitosin sehingga pengeluaran ASI menjadi lebih sulit meskipun produksi ASI sebenarnya mencukupi (Stuebe, 2020).

Kondisi psikologis yang positif seperti rasa nyaman, dukungan keluarga, dan lingkungan yang tenang dapat membantu meningkatkan pelepasan oksitosin. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan dukungan emosional kepada ibu serta membantu menciptakan kondisi menyusui yang nyaman. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keberhasilan menyusui tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi.

3. Baby Blues dan Depresi Postpartum

Gangguan suasana hati pada masa nifas dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kondisi ringan hingga gangguan yang lebih serius. Dua kondisi yang paling sering dibahas dalam kesehatan maternal adalah baby blues dan depresi postpartum.

a. Baby Blues

Baby blues merupakan gangguan emosional ringan yang umum terjadi pada ibu setelah melahirkan. Kondisi ini biasanya muncul pada hari ke-3 hingga hari ke-5 postpartum dan dapat berlangsung hingga dua minggu setelah persalinan. Gejala yang sering muncul antara lain perasaan sedih tanpa sebab yang jelas, mudah menangis, mudah tersinggung, serta perubahan suasana hati yang cepat (Shorey et al., 2018).

Baby blues umumnya bersifat sementara dan tidak memerlukan terapi medis khusus. Dukungan emosional dari keluarga serta istirahat yang cukup biasanya cukup membantu ibu melewati periode ini.

b. Depresi Postpartum

Berbeda dengan baby blues, depresi postpartum merupakan gangguan mood yang lebih serius dan berlangsung lebih lama. Kondisi ini dapat muncul dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah persalinan. Gejala depresi postpartum meliputi perasaan sedih yang menetap, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, kelelahan yang berlebihan, gangguan tidur, serta perasaan tidak mampu merawat bayi (Slomian et al., 2019).

Beberapa ibu juga dapat mengalami perasaan bersalah yang berlebihan atau bahkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayinya. Kondisi ini memerlukan penanganan profesional karena dapat berdampak pada kesehatan ibu maupun perkembangan bayi (Gavin et al., 2005).

Deteksi dini sangat penting dalam pelayanan kebidanan. Tenaga kesehatan dapat melakukan skrining menggunakan instrumen seperti *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) untuk mengidentifikasi risiko depresi postpartum.

4. Strategi Coping Sederhana bagi Ibu Nifas

Strategi coping merupakan upaya yang dilakukan individu untuk mengelola stres dan menyesuaikan diri dengan situasi yang menantang. Pada ibu nifas, strategi coping yang sederhana namun efektif dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.

Salah satu strategi yang penting adalah meningkatkan dukungan sosial. Dukungan dari pasangan, keluarga, maupun tenaga kesehatan dapat memberikan rasa aman dan membantu ibu mengatasi kelelahan dalam merawat bayi. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang baik berkaitan dengan penurunan risiko depresi postpartum (Shorey et al., 2020).

Selain itu, manajemen waktu dan energi juga penting dilakukan. Ibu dapat dianjurkan untuk beristirahat ketika bayi tidur, membagi tugas rumah tangga dengan anggota keluarga, serta menghindari tuntutan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Pendekatan ini membantu ibu menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan emosional.

Teknik relaksasi sederhana seperti pernapasan dalam, meditasi ringan, atau mendengarkan musik yang menenangkan juga dapat membantu menurunkan tingkat stres. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai atau peregangan juga terbukti dapat meningkatkan suasana hati melalui peningkatan pelepasan endorfin (Bains et al., 2025).

Tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi yang realistis dan tidak menghakimi agar ibu merasa didukung dalam proses adaptasi menjadi orang tua.

5. Indikasi Rujukan Psikologis

Meskipun sebagian besar ibu dapat menyesuaikan diri dengan baik selama masa nifas, beberapa kondisi memerlukan perhatian khusus dan rujukan ke tenaga profesional kesehatan mental.

Indikasi rujukan psikologis antara lain:

- a. Gejala depresi berlangsung lebih dari dua minggu
- b. Perasaan sedih atau putus asa yang berat
- c. Gangguan tidur yang signifikan meskipun bayi tidur

- d. Kesulitan menjalin ikatan dengan bayi
- e. Pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi

Dalam kondisi tersebut, ibu perlu dirujuk ke psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Penanganan dapat berupa konseling psikologis, terapi perilaku kognitif, atau terapi farmakologis apabila diperlukan (Gavin et al., 2005).

Deteksi dini dan rujukan yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu dan perkembangan anak. Oleh karena itu, tenaga kesehatan di pelayanan kebidanan memiliki peran strategis dalam melakukan skrining, memberikan dukungan emosional, serta memastikan ibu mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

E. Higienitas dan Perawatan Diri

Masa nifas merupakan periode pemulihan fisiologis setelah persalinan yang memerlukan perhatian khusus terhadap kebersihan diri dan perawatan tubuh. Praktik higienitas yang baik sangat penting untuk mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan luka persalinan, serta mendukung keberhasilan menyusui. Dalam pelayanan kebidanan, edukasi mengenai higienitas dan perawatan diri merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi selama masa postpartum.

Perubahan fisiologis pada masa nifas, seperti adanya luka perineum, perubahan pada jaringan payudara, serta penurunan imunitas sementara, dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi apabila kebersihan diri tidak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi yang jelas dan praktis kepada ibu mengenai cara menjaga kebersihan tubuh serta melakukan perawatan diri secara mandiri di rumah.

1. Perawatan Payudara

Perawatan payudara merupakan salah satu komponen penting dalam perawatan diri ibu nifas, terutama bagi ibu yang menyusui. Tujuan utama perawatan payudara adalah menjaga kebersihan area payudara, memperlancar produksi dan pengeluaran ASI, serta mencegah berbagai masalah menyusui seperti puting lecet, saluran ASI tersumbat, dan mastitis.

Perawatan payudara yang dilakukan secara benar dapat merangsang refleks oksitosin yang berperan dalam pengeluaran ASI serta membantu mencegah penyumbatan pada saluran susu. Selain itu, praktik breast care yang baik juga terbukti dapat meningkatkan kelancaran produksi ASI dan mengurangi risiko gangguan menyusui pada ibu postpartum (PERWIRANINGTYAS et al., 2026).

Beberapa langkah perawatan payudara yang dianjurkan pada ibu menyusui antara lain:

- a. Membersihkan payudara secara rutin dengan air bersih saat mandi.
- b. Menjaga kebersihan area puting dan areola tanpa menggunakan sabun yang dapat menyebabkan iritasi.
- c. Menggunakan bra yang bersih dan nyaman untuk menopang payudara.
- d. Melakukan pijat payudara ringan untuk membantu memperlancar aliran ASI.
- e. Memastikan teknik perlekatan bayi yang benar saat menyusui.

Perawatan payudara juga dapat membantu mengatasi berbagai masalah menyusui seperti payudara bengkak, puting lecet, dan produksi ASI yang tidak lancar. Studi menunjukkan bahwa penerapan teknik breast care secara teratur dapat meningkatkan keberhasilan menyusui serta mengurangi keluhan pada ibu postpartum (Utari, 2023).

2. Perawatan Luka Persalinan

Pada masa nifas, sebagian ibu mengalami luka pada daerah perineum akibat episiotomi atau robekan spontan saat persalinan. Selain itu, ibu yang menjalani operasi sectio caesarea juga memiliki luka operasi yang memerlukan perawatan khusus. Perawatan luka yang tepat sangat penting untuk mencegah infeksi serta mempercepat proses penyembuhan jaringan.

Beberapa prinsip dasar perawatan luka pada masa nifas meliputi:

- a. Menjaga kebersihan area luka dengan mencuci menggunakan air bersih.
- b. Mengeringkan area luka secara lembut setelah mandi atau buang air.
- c. Mengganti pembalut secara teratur untuk menjaga kebersihan daerah genital.
- d. Menghindari penggunaan pakaian dalam yang terlalu ketat.
- e. Mengamati tanda infeksi seperti nyeri meningkat, kemerahan, pembengkakan, atau keluarnya cairan berbau.

Perawatan luka yang baik dapat membantu mempercepat proses penyembuhan jaringan serta mengurangi risiko komplikasi infeksi pada masa nifas. Tenaga kesehatan juga perlu memberikan edukasi kepada ibu mengenai tanda-tanda infeksi agar ibu dapat segera mencari pertolongan medis apabila diperlukan.

3. Kebersihan Tangan dan Pencegahan Infeksi

Kebersihan tangan merupakan langkah paling sederhana namun sangat efektif dalam mencegah penyebaran infeksi pada ibu dan bayi. Pada masa nifas, ibu sering melakukan kontak langsung dengan bayi saat menyusui, mengganti popok, maupun merawat bayi. Oleh karena itu, praktik kebersihan tangan harus menjadi kebiasaan rutin dalam kehidupan sehari-hari.

Ibu dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum menyusui, sebelum memegang bayi, setelah mengganti popok, serta setelah menggunakan toilet. Praktik ini penting untuk mencegah transmisi mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada ibu maupun bayi.

Selain kebersihan tangan, kebersihan lingkungan juga perlu diperhatikan. Peralatan menyusui, pakaian bayi, serta tempat tidur bayi harus dijaga kebersihannya untuk mengurangi risiko paparan patogen. Edukasi mengenai praktik higienitas ini merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan ibu dan bayi berbasis pencegahan.

4. Pencegahan Mastitis

Mastitis merupakan peradangan pada jaringan payudara yang sering terjadi pada ibu menyusui, terutama pada beberapa minggu pertama setelah persalinan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, penyumbatan saluran ASI, atau iritasi pada jaringan payudara. Gejala mastitis biasanya meliputi nyeri pada payudara, kemerahan, pembengkakan, serta demam (Listiyorini et al., 2022).

Pencegahan mastitis dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

- a. Menyusui bayi secara teratur untuk mencegah penumpukan ASI.
- b. Memastikan perlekatan bayi yang benar saat menyusui.
- c. Mengosongkan payudara secara optimal saat menyusui.
- d. Menghindari tekanan berlebihan pada payudara, misalnya dari bra yang terlalu ketat.

Melakukan pijat payudara ringan untuk mencegah penyumbatan saluran ASI.

Teknik menyusui yang benar merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya mastitis. Posisi menyusui yang tepat serta perlekatan bayi yang efektif dapat mengurangi risiko penyumbatan saluran susu yang sering menjadi penyebab mastitis (Maharani et al., 2023).

Selain itu, deteksi dini terhadap tanda-tanda awal mastitis sangat penting. Apabila ibu mengalami nyeri payudara yang menetap, demam, atau kemerahan pada payudara, ibu perlu segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

F. Penyusunan Rencana Dukungan Gaya Hidup Individual

Masa nifas merupakan periode penting dalam pemulihan kesehatan ibu setelah kehamilan dan persalinan. Pada periode ini, ibu tidak hanya memerlukan pemulihan fisik, tetapi juga dukungan gaya hidup yang sehat agar mampu beradaptasi dengan peran barunya sebagai ibu. Pendekatan pelayanan kebidanan

modern menekankan pentingnya penyusunan rencana perawatan postpartum yang bersifat individual, komprehensif, dan berkelanjutan.

Rencana dukungan gaya hidup pada ibu nifas mencakup berbagai aspek, antara lain nutrisi, istirahat, dukungan keluarga, serta tindak lanjut pelayanan kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ibu, mendukung keberhasilan menyusui, serta mencegah komplikasi postpartum. Organisasi kesehatan global merekomendasikan bahwa perawatan postpartum tidak hanya berupa satu kali kunjungan, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pemantauan kondisi fisik, psikologis, serta kebutuhan sosial ibu (American College of Obstetricians and Gynecologists., 2021).

Selain itu, rekomendasi pelayanan pascapersalinan menekankan pentingnya edukasi mengenai nutrisi, kebersihan diri, kesehatan mental, serta perawatan bayi sebagai bagian dari intervensi kesehatan ibu dan bayi pada masa nifas (World Health Organization., 2022b).

Dalam konteks pendidikan kebidanan berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), mahasiswa perlu dilatih untuk menyusun rencana dukungan gaya hidup yang realistis dan sesuai dengan kondisi individu ibu. Keterampilan ini membantu mahasiswa memahami pendekatan pelayanan yang bersifat holistik dan berpusat pada pasien (*woman-centered care*).

1. Penyusunan Rencana Nutrisi Harian untuk Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Ibu Menyusui

Nutrisi yang adekuat sangat penting pada masa nifas karena tubuh ibu membutuhkan energi tambahan untuk pemulihan jaringan, produksi ASI, serta adaptasi metabolik setelah kehamilan. Ibu yang menyusui memerlukan tambahan energi sekitar 300–500 kilokalori per hari dibandingkan kebutuhan sebelum hamil untuk mendukung produksi ASI (Ball et al., 2022).

Pola makan ibu nifas sebaiknya terdiri dari makanan yang seimbang dan bervariasi, meliputi sumber karbohidrat kompleks, protein berkualitas, lemak sehat, vitamin, serta mineral. Komposisi nutrisi yang dianjurkan mencakup sekitar 50–60% energi dari karbohidrat, 15–20% dari protein, dan kurang dari 30% dari lemak. Selain itu, konsumsi serat dari buah, sayuran, dan biji-bijian juga penting untuk membantu mencegah konstipasi yang sering terjadi pada masa nifas.

Dalam praktik klinis, mahasiswa kebidanan dapat membantu ibu menyusun rencana nutrisi sederhana yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh rencana nutrisi harian ibu nifas antara lain:

Pagi: nasi atau roti gandum, telur, sayur, dan susu

Snack: buah segar atau yoghurt

Siang: nasi, lauk berprotein (ikan/ayam/tempe), sayuran, dan buah

Snack sore: kacang-kacangan atau buah

Malam: nasi atau sumber karbohidrat lain, lauk berprotein, dan sayuran

Selain komposisi makanan, ibu juga dianjurkan untuk menjaga hidrasi dengan minum air yang cukup, terutama bagi ibu menyusui yang membutuhkan cairan lebih banyak.

2. Penyusunan Jadwal Istirahat yang Realistis

Kelelahan merupakan keluhan yang sangat umum dialami oleh ibu pada masa nifas. Perubahan pola tidur akibat kebutuhan bayi yang sering menyusui dapat menyebabkan gangguan tidur dan penurunan energi pada ibu. Oleh karena itu, manajemen istirahat menjadi bagian penting dalam rencana gaya hidup postpartum.

Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi kepada ibu mengenai strategi istirahat yang realistis, seperti:

- a. Beristirahat ketika bayi tidur
- b. Membagi tugas rumah tangga dengan anggota keluarga
- c. Mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting
- d. Mengatur prioritas kegiatan harian

Pendekatan ini bertujuan untuk membantu ibu menjaga keseimbangan antara kebutuhan istirahat dan tanggung jawab dalam merawat bayi. Istirahat yang cukup juga berperan dalam menjaga kesehatan mental ibu serta mendukung keberhasilan menyusui.

3. Strategi Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan faktor penting yang memengaruhi kesehatan ibu selama masa nifas. Keterlibatan pasangan dan anggota keluarga dalam perawatan ibu dan bayi dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri ibu, serta meningkatkan keberhasilan pemberian ASI.

Pendekatan *Family-Centered Maternity Care* menekankan bahwa keluarga merupakan bagian integral dari sistem dukungan ibu postpartum. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi berbasis pendekatan keluarga dapat meningkatkan dukungan keluarga serta meningkatkan *self-efficacy* ibu dalam menyusui (Winarti et al., 2024).

Beberapa bentuk dukungan keluarga yang dapat dianjurkan antara lain:

- a. Membantu pekerjaan rumah tangga
- b. Memberikan dukungan emosional kepada ibu
- c. Membantu perawatan bayi
- d. Mendukung praktik menyusui
- e. Mengingat jadwal kunjungan kesehatan

Dengan adanya dukungan keluarga yang baik, ibu dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan peran dan tanggung jawab setelah persalinan.

4. Rencana Tindak Lanjut Kunjungan Nifas

Kunjungan nifas merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan ibu setelah persalinan. Tujuan kunjungan nifas adalah memantau pemulihan ibu, mendeteksi dini komplikasi, serta memberikan edukasi mengenai perawatan diri dan bayi.

Rekomendasi pelayanan kesehatan ibu postpartum menyarankan beberapa kali kunjungan selama masa nifas, yaitu:

- a. **Kunjungan pertama:** dalam 24 jam setelah persalinan
- b. **Kunjungan kedua:** hari ke-3 postpartum
- c. **Kunjungan ketiga:** hari ke-7 hingga 14 postpartum
- d. **Kunjungan keempat:** sekitar 6 minggu setelah persalinan

Selain itu, pendekatan pelayanan modern menekankan bahwa perawatan postpartum merupakan proses berkelanjutan yang dapat berlangsung hingga 12 minggu setelah persalinan sesuai kebutuhan ibu (American College of Obstetricians and Gynecologists., 2021).

Dalam setiap kunjungan nifas, tenaga kesehatan perlu melakukan:

- a. evaluasi kondisi fisik ibu
- b. pemantauan kesehatan mental
- c. konseling menyusui
- d. edukasi nutrisi dan aktivitas
- e. skrining komplikasi postpartum

Dengan adanya tindak lanjut yang terencana, komplikasi postpartum dapat dideteksi lebih dini sehingga meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

5. Format SOAP untuk Dokumentasi Edukasi

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam praktik pelayanan kebidanan karena berfungsi sebagai bukti pelayanan serta alat komunikasi antar tenaga kesehatan. Salah satu metode dokumentasi yang umum digunakan adalah format SOAP (*Subjective, Objective, Assessment, Plan*).

a. Subjective (S)

Berisi informasi yang disampaikan langsung oleh ibu, seperti keluhan, perasaan, atau pengalaman selama masa nifas.

Contoh:

"Ibu merasa lelah karena bayi sering terbangun pada malam hari."

b. Objective (O)

Berisi data hasil pemeriksaan atau observasi tenaga kesehatan.

Contoh:

Tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 36,8°C, luka perineum tampak baik, tidak ada tanda infeksi.

c. Assessment (A)

Merupakan interpretasi tenaga kesehatan terhadap kondisi ibu berdasarkan data subjektif dan objektif.

Contoh:

Ibu nifas hari ke-5 dengan kondisi umum baik, mengalami kelelahan ringan akibat kurang istirahat.

d. Plan (P)

Berisi rencana tindakan atau edukasi yang diberikan kepada ibu.

Contoh:

- 1) Edukasi nutrisi postpartum
- 2) Anjuran istirahat ketika bayi tidur
- 3) Edukasi teknik menyusui
- 4) Jadwal kunjungan nifas berikutnya

Dokumentasi SOAP membantu tenaga kesehatan dalam memantau perkembangan kondisi ibu secara sistematis serta memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan.

Aktivitas Mahasiswa (Level Bloom)

C2-Understanding (Memahami):

Menjelaskan kebutuhan gizi ibu menyusui

Aktivitas:

1. Mahasiswa menjelaskan kebutuhan energi, makronutrien, dan mikronutrien ibu menyusui dalam diskusi kelompok
2. Membuat ringkasan sederhana tentang peran nutrisi terhadap produksi ASI
3. Menyusun peta konsep (mind map) kebutuhan gizi ibu menyusui

Output:

1. Ringkasan tertulis / mind map
2. Presentasi singkat kelompok

C3– Applying (Menerapkan):

Menghitung kebutuhan kalori sederhana

Aktivitas:

1. Mahasiswa menghitung kebutuhan energi ibu menyusui berdasarkan kasus (berat badan, aktivitas)
2. Menyusun contoh menu harian sederhana sesuai kebutuhan kalori
3. Simulasi perhitungan kebutuhan cairan ibu

Output:

1. Lembar perhitungan kebutuhan kalori
2. Rencana menu harian

C4– Analyzing (Menganalisis):

Menganalisis kasus ibu dengan ASI dirasa kurang

Aktivitas:

1. Analisis studi kasus ibu dengan keluhan ASI kurang
2. Mengidentifikasi faktor penyebab (nutrisi, stres, teknik menyusui, istirahat)
3. Diskusi kelompok untuk menentukan prioritas masalah

Output:

1. Laporan analisis kasus
2. Diagram sebab-akibat (fishbone sederhana)

C5 – Evaluating (Mengevaluasi/Menyusun):

Menyusun rencana edukasi personal

Aktivitas:

1. Mahasiswa menyusun rencana edukasi individual berdasarkan kasus ibu nifas
2. Menyesuaikan edukasi dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan ibu
3. Melakukan role play komunikasi terapeutik

Output:

1. Lembar edukasi pasien (leaflet / script edukasi)

2. Video/role play konseling

C6– Creating (Mencipta):

Mendesain modul edukasi keluarga ibu nifas

Aktivitas:

1. Mahasiswa membuat modul edukasi untuk keluarga (suami/keluarga inti)
2. Mendesain media edukasi (poster, booklet, atau infografik)
3. Mengintegrasikan aspek nutrisi, istirahat, dukungan emosional, dan menyusui

Output:

1. Modul edukasi keluarga (PDF/poster)
2. Presentasi produk edukasi

Aktivitas 1 — Knows How

Mini Case: Kebutuhan Gizi Ibu Menyusui dan Dukungan Gaya Hidup Sehat

Skenario Kasus

Seorang ibu, usia 27 tahun, P1A0, hari ke-5 postpartum datang ke puskesmas untuk kontrol nifas.

Keluhan:

1. Ibu merasa ASI “tidak cukup” karena bayi sering menangis setelah menyusu
2. Ibu merasa lelah dan kurang tidur
3. Nafsu makan menurun
4. Ibu minum $\pm$ 1–1,5 liter/hari

Riwayat:

1. Persalinan normal
2. Bayi lahir cukup bulan, BB 3200 gram
3. Menyusui $\pm$ setiap 2–3 jam, namun durasi singkat ($\pm$ 5–10 menit)
4. Ibu belum yakin dengan posisi menyusui
5. Dukungan keluarga terbatas (tinggal hanya dengan suami)

Pemeriksaan:

1. TTV dalam batas normal
2. Payudara tidak bengkak
3. Luka perineum baik
4. Ibu tampak lelah

Tujuan Aktivitas

Mahasiswa mampu:

1. Menganalisis kondisi ibu nifas (CPMK-2)
2. Mengidentifikasi masalah menyusui dan gaya hidup (CPMK-5)
3. Menyusun edukasi dan rencana tindak lanjut berbasis bukti (CPMK-7)

Pertanyaan Diskusi (Knows How Level – C3–C4)

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1 (Kebutuhan Gizi Ibu Menyusui dan Dukungan Gaya Hidup Sehat)
2	Judul	Edukasi Gizi, Menyusui, dan Gaya Hidup pada Ibu Nifas
3	Kasus	Ibu kelelahan berat & Teknik Menyusui Tidak Efektif
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon Bidan yang kompeten
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang ibu usia 29 tahun, P1A0, hari ke-7 postpartum datang ke pelayanan kebidanan. dengan keluhan Ibu merasa sangat lelah, Bayi sering rewel setelah menyusui, Ibu merasa ASI "tidak cukup". Ibu Menyusui setiap 2–3 jam, durasi $\pm 5-10$ menit, Bayi sering lepas saat menyusui, Ibu tidur < 4 jam/hari, Pola makan tidak teratur, Minum ± 1 liter/hari, Dukungan keluarga minimal. Hasil Pemeriksaan TTV : T 120/80 mmHg, N 84 x/menit, S 36,5°C, RR 24 x/menit dan Ibu tampak lelah. Anda adalah bidan di pelayanan kebidanan. Lakukan asuhan pada ibu nifas dengan keluhan kelelahan dan masalah menyusui. TUGAS : Melakukan anamnesa terfokus Mengidentifikasi masalah utama Memberikan edukasi: Nutrisi ibu menyusui Hidrasi Teknik menyusui (posisi & perlekatan) Istirahat & manajemen energi Menggunakan komunikasi terapeutik Menyusun rencana tindak lanjut
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM

No.	Komponen	Isi
		1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tuliskan nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi - 2 digit jika peserta berjumlah 01–99 - 3 digit jika peserta berjumlah 100–999 - 4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional - 4 digit jika peserta berjumlah ribuan - atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Pengujitidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta lain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS · Nilai alur berpikir klinis · Perhatikan personalisasi edukasi · Evaluasi komunikasi terapeutik INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapihkan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelum nyatelah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Profil PS: Ibu nifas hari ke-7 Tampak lelah, suara pelan, sedikit cemas Instruksi: Jawab hanya jika ditanya Tunjukkan kelelahan (sering menghela napas) Jika peserta empatik → lebih terbuka Jika peserta menghakimi → defensif

No.	Komponen	Isi	
9	Dialog PS	Pertanyaan Peserta Ujian	Jawaban PS
		"Bagaimana pola makan ibu?"	"Kadang cuma 2x sehari"
		"Minum berapa liter dalam sehari bu ?"	"Sekitar 1 liter"
		"Bagaimana pola tidurnya bu ?"	"Sering bangun, capek banget"
		"Berapa lama ibu menyusui bayinya ? apakah ada kendala selama proses menyusui bu"	"Sebentar, bayi sering melepaskan payudara saat menyusu"
10	Kebutuhan manikin	boneka bayi untuk demonstrasi menyusui	
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya	
12	Kebutuhan alat	Meja & kursi Leaflet edukasi Poster menyusui Boneka bayi (opsional) Lembar penilaian	
13	Penulis	Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.	
14	Referensi	Stasiun OSCE	Sumber Utama
		Konseling kebutuhan gizi ibu menyusui	Kemenkes RI (2020), WHO (2021)
		Edukasi ASI eksklusif	UNICEF (2020), WHO (2021)
		Penilaian status nutrisi ibu menyusui	Kemenkes RI (2020), Lawrence (2021)
		Konseling suplementasi	WHO (2021), Jurnal terbaru

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan kebidanan dalam masa nifas normal: ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif

Komponen	Deskripsi	Kasus Ibu nifas dengan masalah ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinis mahasiswa saat melakukan tindakan nyata pada pasien. Penilaian dilakukan menggunakan checklist terstruktur, mencakup aspek komunikasi, keterampilan teknis, pengambilan keputusan, dan profesionalisme.	Mahasiswa diamati secara langsung saat: 1. Mengkaji kondisi ibu nifas dengan kelelahan berat 2. Menilai teknik menyusui 3. Memberikan edukasi gizi dan gaya hidup sehat Pembimbing menggunakan checklist DOPS untuk menilai performa mahasiswa secara real-time di klinik.
Tujuan penilaian	Menilai kompetensi mahasiswa secara holistik dalam: 1. Keterampilan klinis 2. Komunikasi terapeutik 3. Clinical reasoning 4. Edukasi dan konseling	Tujuan spesifik: 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab kelelahan ibu nifas 2. Mahasiswa mampu mengevaluasi teknik menyusui yang tidak efektif 3. Mahasiswa mampu memberikan edukasi gizi seimbang untuk ibu menyusui 4. Mahasiswa mampu menyarankan gaya hidup sehat untuk pemulihan ibu
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya asuhan kebidanan masa nifas normal dengan fokus kebutuhan gizi ibu menyusui dan dukungan gaya hidup sehat , pada kasus	Seorang ibu usia 29 tahun, P1A0, hari ke-7 postpartum datang ke pelayanan kebidanan. dengan keluhan Ibu merasa sangat lelah, Bayi sering rewel setelah menyusu, Ibu merasa ASI "tidak cukup". Ibu Menyusui setiap 2–3 jam, durasi ±5–10 menit, Bayi

Komponen	Deskripsi	Kasus Ibu nifas dengan masalah ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
	ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif.	sering lepas saat menyusu, Ibu tidur < 4 jam/hari, Pola makan tidak teratur, Minum ± 1 liter/hari, Dukungan keluarga minimal. Hasil Pemeriksaan TTV : T 120/80 mmHg, N 84 x/menit, S 36,5°C, RR 24 x/menit dan Ibu tampak lelah.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain melengkapi data subyektif dan obyektif dengan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sesuai kasus, dan memberikan asuhan yang tepat sesuai kebutuhan ibu	Mahasiswa melakukan: 1. Anamnesis (kelelahan, pola makan, pola tidur, frekuensi menyusui) 2. Pemeriksaan fisik sederhana 3. Observasi teknik menyusui (posisi & perlekatan) 4. Identifikasi masalah 5. Edukasi: a. Teknik menyusui yang benar b. Kebutuhan gizi ibu menyusui c. Pentingnya istirahat & dukungan keluarga 6. Evaluasi pemahaman ibu
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, kemampuan memberikan KIE, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menerapkan berpikir kritis dalam menganalisis bahwa masalah ibu merupakan masalah yang fisiologis, namun tetap harus diberikan asuhan yang tepat. Aspek yang dinilai meliputi: 1. Keterampilan komunikasi

Komponen	Deskripsi	Kasus Ibu nifas dengan masalah ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
		a. Empati terhadap ibu kelelahan b. Bahasa mudah dipahami 2. Keterampilan klinis a. Ketepatan mengkaji teknik menyusui b. Ketepatan identifikasi masalah 3. Edukasi & konseling a. Materi gizi (kalori, cairan, protein) b. Teknik menyusui efektif 4. Profesionalisme a. Sikap sabar, menghargai ibu b. Menjaga privasi 5. Clinical reasoning a. Menghubungkan kelelahan dengan produksi ASI & teknik menyusui
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Setelah melakukan pengkajian data subyektif dan obyektif mahasiswa mampu menganalisis diganosa dan masalah utama yang dialami oleh ibu, sehingga asuhan yang diberikan tepat sesuai kebutuhan.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menganalisis bahwa masalah yang dialami ibu adalah masalah fisiologis, tidak diperlukan intervensi khusus, dan mahasiswa mampu memberikan asuhan yang tepat sesuai kebutuhan Pembimbing fokus pada: 1. Apakah mahasiswa menggali penyebab

Komponen	Deskripsi	Kasus Ibu nifas dengan masalah ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
		kelelahan secara komprehensif 2. Apakah mahasiswa mampu mengoreksi teknik menyusui secara langsung 3. Apakah edukasi gizi sesuai kebutuhan ibu menyusui 4. Apakah mahasiswa melibatkan keluarga dalam edukasi 5. Apakah mahasiswa memastikan ibu memahami edukasi
Umpan balik	Feedback konstruktif yang diberikan segera setelah observasi. Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam berkomunikasi dengan ibu dan keluarga, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan materi dan langkah-langkah KIE agar lebih sistematis. Kekuatan: 1. Komunikasi baik dan empatik 2. Edukasi mudah dipahami Perbaikan: 1. Perlu lebih spesifik dalam menjelaskan posisi pelekatan bayi 2. Perlu menggali lebih dalam pola makan ibu Saran: 1. Gunakan demonstrasi langsung teknik menyusui

Komponen	Deskripsi	Kasus Ibu nifas dengan masalah ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
		2. Libatkan suami untuk dukungan ibu
Keputusan penilaian	Hasil DOPS diklasifikasikan menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial berdasarkan observasi langsung terhadap performa mahasiswa. Penilaian mencakup ketepatan prosedur, keselamatan pasien, komunikasi profesional, dan kemampuan pengambilan keputusan klinis dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas.	1. Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. 2. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. 3. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal menganalisis kebutuhan ibu, salah dalam memberikan asuhan pada ibu.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi. DOPS mendukung OBE karena menilai capaian pembelajaran berbasis performa nyata.	Pada kasus asuhan nifas dengan Ibu kelelahan berat & Teknik Menyusui Tidak Efektif, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menganalisis kebutuhan ibu, dan memberikan asuhan secara tepat dan profesional di lahan praktik. Makna OBE: 1. Mahasiswa tidak hanya "tahu", tetapi mampu melakukan 2. Capaian pembelajaran: - Memberikan asuhan nifas berbasis evidence - Melakukan edukasi efektif

Komponen	Deskripsi	Kasus Ibu nifas dengan masalah ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
		c. Mengambil keputusan klinis DOPS memastikan bahwa lulusan: 1. Siap praktik 2. Kompeten dalam menangani kasus nyata ibu nifas 3. Mampu meningkatkan kualitas kesehatan ibu & bayi

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1. 7 Portofolio pada Asuhan kebidanan dalam masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
Hakikat portofolio	Portofolio adalah kumpulan bukti autentik yang menunjukkan proses, perkembangan, dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Tidak hanya hasil akhir, tetapi juga mencerminkan proses	Mahasiswa menyusun portofolio berisi: 1. Catatan asuhan ibu nifas hari ke-3 dengan kelelahan berat 2. Dokumentasi edukasi teknik menyusui 3. Rencana intervensi gizi ibu menyusui

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
	belajar, pengalaman klinik, refleksi, dan perbaikan diri.	4. Refleksi pengalaman menangani ibu yang kelelahan 5. Portofolio menunjukkan bagaimana mahasiswa berkembang dari awal pengkajian hingga evaluasi.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan : · Menilai kompetensi secara komprehensif dan berkelanjutan · Mendorong refleksi diri · Mendokumentasikan pencapaian learning outcomes · Sebagai bukti kesiapan praktik profesional.	Tujuan spesifik: 1. Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan mengidentifikasi kelelahan ibu nifas 2. Mahasiswa mampu memberikan edukasi gizi dan menyusui yang tepat 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi keberhasilan intervensi
OSCE dan DOPS	OSCE (Objective Structured Clinical Examination): menilai keterampilan dalam situasi terstandar DOPS (Direct Observation of Procedural Skills): menilai keterampilan langsung pada pasien nyata. Keduanya menjadi bagian dari bukti dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi profession, analisa masalah yang dialami klien, dan pemberian asuhan yang tepat. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu nifas, analisis masalah yang muncul, dan asuhan tepat sesuai kebutuhan klien. OSCE: simulasi edukasi teknik menyusui dan gizi ibu DOPS: observasi langsung saat mahasiswa: a. Mengkaji ibu kelelahan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
		b. Mengoreksi perlekatan bayi c. Memberikan edukasi gizi Hasil OSCE & DOPS dimasukkan dalam portofolio sebagai bukti kompetensi.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus klinik yang ditangani mahasiswa, mencakup data subjektif, objektif, analisis, dan penatalaksanaan.	Identitas: Ibu nifas hari ke-7 Keluhan: Lelah berat Bayi sering menangis setelah menyusui Data Objektif: TTV normal ASI ada, namun perlekatan tidak efektif Analisis: Kelelahan ibu nifas Teknik menyusui tidak efektif Penatalaksanaan: Edukasi posisi dan perlekatan menyusui Edukasi kebutuhan gizi (kalori tambahan, protein, cairan) Anjuran istirahat dan dukungan keluarga
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah	Mahasiswa merefleksikan: 1. Risiko bayi kurang asupan ASI akibat teknik menyusui salah 2. Risiko ibu mengalami kelelahan berat → penurunan produksi ASI

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
	pencegahan dalam asuhan kebidanan. Refleksi terkait keselamatan pasien dalam pelayanan yang diberikan, termasuk identifikasi risiko dan upaya pencegahan.	Upaya pencegahan: - Memastikan teknik menyusui benar - Edukasi tanda cukup ASI - Menganjurkan dukungan keluarga Refleksi juga mencakup: "Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi."
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen terkait performa mahasiswa menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	Kekuatan: - Komunikasi empatik - Edukasi mudah dipahami Perlu ditingkatkan: - Demonstrasi teknik menyusui perlu lebih jelas - Pengkajian pola makan ibu lebih mendalam Tindak lanjut: - Latihan ulang teknik menyusui - Studi literatur gizi ibu menyusui
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa. Penilaian portofolio bersifat:	Penilaian tidak hanya dari: Hasil akhir asuhan tetapi juga: - Proses pengkajian - Cara komunikasi - Kemampuan refleksi - Perbaikan dari feedback

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
	1. Holistik (menilai keseluruhan kompetensi) 2. Autentik (berdasarkan kasus nyata) 3. Berkelanjutan 4. Reflektif	
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa menunjukkan bahwa kompetensi dilakukan secara berulang dan konsisten, mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda, bukan hanya sekali.	Portofolio memuat: 1. Beberapa kasus ibu nifas dengan masalah serupa 2. Dokumentasi peningkatan kemampuan mahasiswa 3. Perbandingan performa awal dan akhir Misalnya: a. Awalnya mahasiswa kurang tepat dalam koreksi teknik menyusui b. Pada kasus berikutnya sudah mampu melakukan dengan benar
Makna dalam OBE	Portofolio mendukung OBE karena: 1. Menilai capaian pembelajaran berbasis bukti nyata 2. Fokus pada hasil (kompetensi) bukan hanya proses belajar 3. Mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap	Capaian pembelajaran yang terlihat: 1. Mahasiswa mampu memberikan asuhan nifas komprehensif 2. Mahasiswa mampu melakukan edukasi gizi dan menyusui efektif 3. Mahasiswa menunjukkan sikap profesional dan empatik Makna: Portofolio memastikan lulusan:

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
		Kompeten secara klinis Siap menghadapi kasus nyata Mampu meningkatkan kualitas kesehatan ibu nifas & bayi

KESIMPULAN

Portofolio dalam kasus ini menjadi alat penting untuk:

- Mendokumentasikan asuhan pada ibu nifas dengan kelelahan dan teknik menyusui tidak efektif
- Menilai kompetensi secara nyata dan berkelanjutan
- Mengembangkan kemampuan refleksi dan patient safety
- Mendukung pencapaian pembelajaran berbasis OBE

Tabel 1. 8 case report pada asuhan kebidanan dalam masa nifas normal: dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
Hakikat case report	Case report adalah laporan ilmiah yang menggambarkan secara sistematis satu kasus klinik nyata, mulai dari pengkajian, analisis, penatalaksanaan, hingga evaluasi. Case report menekankan pada clinical reasoning , integrasi teori-praktik, serta pembelajaran dari kasus spesifik.	Mahasiswa menyusun laporan tentang: 1. Ibu nifas hari ke-7 dengan kelelahan berat 2. Masalah utama: teknik menyusui tidak efektif 3. Fokus pada hubungan antara kelelahan, nutrisi, dan keberhasilan menyusui 4. Laporan menggambarkan proses berpikir klinis mahasiswa dalam menangani kasus tersebut.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
Tujuan	Case report bertujuan : 1. Mengembangkan kemampuan analisis kasus klinik 2. Melatih pengambilan keputusan berbasis evidence 3. Meningkatkan keterampilan dokumentasi ilmiah 4. Menunjukkan kompetensi dalam asuhan kebidanan	Tujuan spesifik: 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab kelelahan ibu nifas 2. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan teknik menyusui dengan produksi ASI 3. Mahasiswa mampu merancang intervensi gizi dan gaya hidup sehat
Isi laporan	Struktur umum case report meliputi: 1. Pendahuluan 2. Tinjauan pustaka singkat 3. Deskripsi kasus 4. Pembahasan 5. Penatalaksanaan 6. Evaluasi dan follow-up 7. Kesimpulan	1. Pendahuluan: Pentingnya gizi dan teknik menyusui pada masa nifas 2. Tinjauan pustaka: a. Kebutuhan kalori ibu menyusui b. Prinsip teknik menyusui efektif 3. Deskripsi kasus: a. Ibu nifas hari ke-3, keluhan lelah berat b. Bayi sering menangis, menyusu lama 4. Pembahasan: a. Kelelahan → menurunkan energi ibu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
		b. Teknik menyusui salah → bayi tidak mendapat ASI optimal 5. Penatalaksanaan: a. Edukasi posisi dan perlekatan b. Edukasi gizi (tambahan 500 kkal/hari, protein, cairan) c. Dukungan istirahat dan peran keluarga 6. Evaluasi: Bayi mulai menyusu efektif Ibu tampak lebih segar
Fokus penilaian	Yang dinilai dalam case report: 1. Ketepatan pengkajian 2. Kedalaman analisis (clinical reasoning) 3. Kesesuaian intervensi dengan evidence 4. Kualitas pembahasan 5. Kemampuan refleksi	Penilaian difokuskan pada: 1. Apakah mahasiswa mampu menghubungkan kelelahan dengan produksi ASI 2. Apakah analisis teknik menyusui tepat 3. Apakah intervensi gizi sesuai standar ibu menyusui 4. Apakah pembahasan didukung teori
Nilai edukatif	Case report memiliki nilai edukatif tinggi karena: 1. Berbasis kasus nyata 2. Mendorong pembelajaran mendalam 3. Mengintegrasikan teori dan praktik	Mahasiswa belajar bahwa: 1. Kelelahan ibu nifas bukan hanya masalah fisik, tetapi berdampak pada menyusui

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
	4. Mengembangkan refleksi klinis	2. Teknik menyusui yang salah dapat menyebabkan bayi tidak cukup ASI 3. Edukasi sederhana namun tepat dapat memperbaiki kondisi ibu dan bayi
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa: 1. Mampu menerapkan pengetahuan dalam praktik nyata 2. Mampu berpikir kritis dan analitis 3. Mampu memberikan asuhan berbasis kompetensi	Capaian pembelajaran yang terlihat: 1. Mahasiswa mampu memberikan asuhan nifas komprehensif 2. Mahasiswa mampu melakukan edukasi gizi dan teknik menyusui 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil intervensi Makna: Case report memastikan lulusan: Tidak hanya memahami teori Tetapi mampu menangani kasus nyata secara profesional

KESIMPULAN

Case report pada kasus ini:

- Menjadi media untuk mengasah **clinical reasoning**
- Mengintegrasikan **asuhan kebidanan, gizi, dan edukasi menyusui**
- Mendukung pembelajaran berbasis **OBE (Outcome-Based Education)**
- Mempersiapkan mahasiswa menjadi bidan yang kompeten dan reflektif

Tabel 1. 9 Refleksi Patient Safety pada Asuhan kebidanan dalam masa nifas normal: dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety adalah proses berpikir kritis dan sistematis terhadap praktik klinik yang telah dilakukan, dengan menitikberatkan pada identifikasi risiko, pencegahan cedera, dan peningkatan keselamatan pasien (ibu dan bayi) . Refleksi ini membantu mahasiswa memahami kesalahan potensial maupun aktual serta memperbaiki praktik ke depan.	Mahasiswa merefleksikan pengalaman menangani ibu nifas dengan: 1. Kelelahan berat 2. Teknik menyusui tidak efektif 3. Fokus refleksi pada: 4. Apakah asuhan yang diberikan sudah aman 5. Apakah ada risiko yang belum teridentifikasi 6. Bagaimana tindakan dapat mencegah komplikasi
Tujuan	1. Meningkatkan kesadaran akan keselamatan pasien 2. Mengidentifikasi potensi risiko dalam pelayanan 3. Mengembangkan kemampuan berpikir reflektif 4. Meningkatkan kualitas asuhan kebidanan	Tujuan refleksi: 1. Mahasiswa menyadari bahwa kelelahan ibu dapat berdampak pada keberhasilan menyusui 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi risiko bayi kurang asupan ASI 3. Mahasiswa mampu memperbaiki pendekatan edukasi agar lebih efektif
Fokus refleksi	Refleksi difokuskan pada: 1. Proses asuhan (pengkajian, tindakan, evaluasi) 2. Keputusan klinis 3. Komunikasi dengan pasien	Mahasiswa merefleksikan: 1. Apakah pengkajian kelelahan ibu sudah komprehensif

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
	4. Dampak terhadap keselamatan pasien	2. Apakah teknik menyusui telah dievaluasi dengan benar 3. Apakah edukasi yang diberikan sudah dipahami ibu 4. Apakah ada aspek yang berpotensi membahayakan ibu atau bayi
Risiko yang diidentifikasi	Mengidentifikasi potensi bahaya atau kejadian tidak diharapkan (adverse events) yang dapat terjadi jika asuhan tidak optimal.	Risiko yang ditemukan: 1. Bayi tidak mendapat ASI cukup akibat teknik menyusui tidak efektif 2. Penurunan produksi ASI karena ibu kelelahan dan kurang nutrisi 3. Dehidrasi atau hipoglikemia pada bayi 4. Kelelahan berlanjut pada ibu yang dapat memicu stres atau baby blues 5. Kegagalan menyusui (laktasi) jika tidak segera ditangani
Tindakan pencegahan	Langkah-langkah untuk meminimalkan atau mencegah risiko yang telah diidentifikasi.	Tindakan yang dilakukan mahasiswa: 1. Mengoreksi posisi dan perlekatan menyusui secara langsung 2. Memberikan edukasi:

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
		a. Frekuensi menyusui yang benar b. Tanda kecukupan ASI pada bayi 3. Edukasi kebutuhan gizi ibu menyusui: a. Tambahan kalori b. Protein tinggi c. Cairan cukup 4. Menganjurkan istirahat cukup dan pembagian peran dengan keluarga 5. Melibatkan suami/keluarga sebagai support system
Pembelajaran mahasiswa	Insight atau pelajaran yang diperoleh mahasiswa setelah melakukan refleksi.	Mahasiswa belajar bahwa: 1. Kelelahan ibu nifas sangat memengaruhi keberhasilan menyusui 2. Teknik menyusui adalah keterampilan yang harus diobservasi langsung, bukan hanya ditanyakan 3. Edukasi harus: a. Sederhana

Komponen	Deskripsi	Contoh pada masa nifas normal dengan ibu kelelahan berat & teknik menyusui tidak efektif
		b. Praktis c. Disertai demonstrasi 4. Dukungan keluarga sangat penting dalam pemulihan ibu 5. Mahasiswa juga menyadari: 6. Pentingnya komunikasi empatik 7. Pentingnya memastikan pemahaman pasien (teach-back method)
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menjadi bukti bahwa mahasiswa: 1. Mampu mengevaluasi praktiknya sendiri 2. Mampu meningkatkan kualitas pelayanan 3. Memiliki sikap profesional dan tanggung jawab terhadap keselamatan pasien	Capaian pembelajaran yang terlihat: 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi risiko pada ibu dan bayi 2. Mahasiswa mampu melakukan tindakan pencegahan berbasis evidence 3. Mahasiswa menunjukkan kemampuan refleksi kritis Makna: Refleksi memastikan lulusan: Tidak hanya kompeten secara teknis Tetapi juga aman, reflektif, dan berorientasi pada patient safety

KESIMPULAN

Refleksi patient safety pada kasus ini:

- Membantu mahasiswa memahami risiko dalam asuhan nifas
- Meningkatkan kualitas edukasi dan intervensi
- Mendorong praktik kebidanan yang aman dan profesional
- Mendukung pencapaian kompetensi dalam kerangka **Outcome-Based Education (OBE)**

G. RANGKUMAN

Masa nifas merupakan periode adaptasi fisiologis dan psikologis yang sangat penting, di mana tubuh ibu mengalami pemulihan pascapersalinan sekaligus menjalankan fungsi laktasi. Proses produksi ASI dipengaruhi oleh keseimbangan hormon, terutama prolaktin dan oksitosin, serta didukung oleh kecukupan asupan energi, nutrisi, dan kondisi psikologis ibu.

Kebutuhan gizi ibu menyusui meningkat dibandingkan sebelum hamil. Ibu memerlukan tambahan energi untuk produksi ASI, serta asupan makronutrien yang adekuat, termasuk protein untuk penyembuhan jaringan, lemak esensial (terutama DHA) untuk kualitas ASI, dan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Selain itu, mikronutrien seperti zat besi, kalsium, vitamin D, asam folat, vitamin B12, iodium, dan zinc memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan mendukung pertumbuhan bayi.

Hidrasi merupakan komponen krusial dalam proses menyusui karena berhubungan dengan refleks oksitosin dan produksi ASI. Ibu dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan sekitar 2–3 liter per hari atau sesuai kebutuhan individu. Tanda klinis hidrasi perlu dipantau, seperti warna urin, frekuensi berkemih, dan kondisi mukosa tubuh.

Dalam kondisi tertentu, suplementasi diperlukan, seperti zat besi pada ibu anemia, vitamin D pada ibu dengan paparan sinar matahari rendah, serta DHA pada ibu dengan konsumsi ikan yang kurang. Penentuan suplementasi harus berbasis pada hasil skrining klinis dan kebutuhan individu ibu.

Selain aspek gizi, dukungan gaya hidup sehat berperan besar dalam keberhasilan masa nifas dan menyusui. Istirahat yang cukup menjadi tantangan utama karena adanya *sleep fragmentation* akibat pola menyusui bayi. Strategi seperti *rest while baby sleeps* dan pembagian peran dengan keluarga sangat dianjurkan untuk menjaga keseimbangan energi ibu.

Aktivitas fisik postpartum dapat dimulai secara bertahap sesuai kondisi ibu, dengan latihan ringan seperti mobilisasi dini, peregangan, dan latihan Kegel.

Aktivitas ini membantu mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan ibu tanpa mengganggu produksi ASI.

Kesehatan psikologis juga perlu diperhatikan, karena stres dapat menghambat refleks oksitosin dan memengaruhi proses menyusui. Perbedaan antara baby blues dan depresi postpartum harus dikenali sejak dini, serta diperlukan dukungan emosional, konseling, dan rujukan bila diperlukan.

Aspek higienitas dan perawatan diri, seperti kebersihan tangan, perawatan payudara, dan perawatan luka perineum, berperan penting dalam mencegah infeksi, termasuk mastitis. Edukasi yang tepat membantu ibu menjaga kesehatan dirinya dan bayinya.

Dalam praktik kebidanan berbasis OBE, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh aspek tersebut dalam bentuk asuhan komprehensif. Hal ini mencakup kemampuan menentukan kebutuhan gizi dan hidrasi, menyusun rencana gaya hidup sehat yang realistis, memberikan edukasi berbasis bukti dengan komunikasi terapeutik, serta mendokumentasikan asuhan secara sistematis dalam format SOAP.

Dengan pendekatan yang holistik dan berpusat pada ibu, asuhan masa nifas tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup ibu, keberhasilan menyusui, dan kesejahteraan ibu serta bayi secara menyeluruh.



Gambar 1. 4 Alur Asuhan Nifas Normal

Tabel 1. 10 Red Flags & Eskalasi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Kelelahan ekstrem, tidak mampu aktivitas	· Tidak sekadar lelah biasa · Bisa mengarah ke: a. Anemia postpartum b. Kurang nutrisi berat c. Risiko depresi nifas · Berdampak pada: a. Penurunan produksi ASI b. Gangguan perawatan bayi	· Kaji Hb (jika tersedia) · Evaluasi asupan nutrisi & pola tidur · Rujuk jika: Lemas berat, pingsan, atau tidak mampu aktivitas · Kolaborasi: a. Konseling gizi b. Dukungan keluarga intensif
Bayi Tidak Puas Setelah Menyusu / Rewel Terus	· Indikasi ASI tidak cukup · Penyebab: a. Teknik menyusui tidak efektif b. Produksi ASI menurun akibat kelelahan & kurang gizi	· Observasi langsung teknik menyusui · Perbaiki posisi & perlekatan · Evaluasi: a. Frekuensi BAK bayi b. Berat badan bayi · Rujuk jika: a. Tanda dehidrasi bayi b. Berat badan tidak naik
Bayi Jarang BAK / Tanda Dehidrasi	· Bayi kekurangan asupan cairan/ASI · Risiko: a. Dehidrasi b. Hipoglikemia c. Gangguan tumbuh kembang	· Hitung frekuensi BAK (<6x/hari = warning) · Segera evaluasi menyusui · Rujuk segera jika: a. Mulut kering b. Lemas c. Tidak aktif menyusu
Penurunan Produksi ASI Signifikan	Bisa disebabkan: 1. Kurang nutrisi 2. Dehidrasi	· Edukasi: a. Nutrisi tinggi kalori & protein

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
	3. Kelelahan 4. Teknik menyusui salah	b. Minum cukup · Tingkatkan frekuensi menyusui · Pertimbangkan rujukan jika: a. Tidak ada perbaikan b. Bayi tidak cukup asupan
Nyeri Payudara / Lecet / Bendungan ASI	· Tanda teknik menyusui tidak tepat · Risiko: a. Mastitis b. Abses payudara c. Ibu berhenti menyusui	· Koreksi teknik menyusui · Kompres hangat sebelum menyusui · Edukasi perawatan payudara · Rujuk jika: a. Demam b. Nyeri hebat c. Ada tanda infeksi
Ibu Tidak Nafsu Makan / Asupan Sangat Kurang	· Risiko: a. Malnutrisi b. Penurunan energi & ASI · Bisa terkait: a. Kelelahan b. Stres	· Konseling gizi praktis (makanan sederhana bergizi) · Anjurkan makan sedikit tapi sering · Libatkan keluarga · Rujuk jika: a. Penurunan berat badan drastis b. Tidak mampu makan
Gangguan Psikologis (Sedih, Menangis, Tidak Peduli Bayi)	Baby blues atau depresi postpartum Dipicu oleh: a. Kelelahan b. Kurang dukungan Dampak: a. Gangguan bonding	· Skrining kondisi psikologis · Berikan dukungan emosional · Libatkan keluarga · Rujuk jika: a. Depresi berat

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
	b. Gangguan menyusui	b. Ada pikiran menyakiti diri/bayi
Ibu Tidak Mampu Merawat Diri & Bayi	- Kelelahan berat → penurunan fungsi - Risiko: Keselamatan ibu & bayi terganggu	- Pastikan ada caregiver (suami/keluarga) - Edukasi pembagian peran - Rujuk jika kondisi memburuk

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No.	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa melakukan pengkajian kelelahan pada ibu nifas secara komprehensif	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menggali pola makan dan asupan cairan ibu menyusui	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menilai kualitas dan kecukupan istirahat ibu nifas	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengamati teknik menyusui (posisi dan perlekatan) secara langsung	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi teknik menyusui yang tidak efektif	☐	☐	
6	Saya sudah bisa menganalisis hubungan antara kelelahan ibu dengan produksi ASI	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menjelaskan kebutuhan gizi ibu menyusui (kalori, protein, cairan)	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memberikan edukasi gizi yang sederhana dan mudah dipahami ibu	☐	☐	
9	Saya sudah bisa mendemonstrasikan teknik menyusui yang benar kepada ibu	☐	☐	

No.	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
10	Saya sudah bisa membimbing ibu memperbaiki posisi dan perlekatan bayi	☐	☐	
11	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang pentingnya istirahat dan manajemen aktivitas	☐	☐	
12	Saya sudah bisa melibatkan keluarga dalam mendukung pemulihan ibu nifas	☐	☐	
13	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda kecukupan ASI pada bayi (BAK, perilaku bayi)	☐	☐	
14	Saya sudah bisa mengevaluasi keberhasilan intervensi (ibu lebih segar & bayi menyusui efektif)	☐	☐	
15	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda bahaya (red flags) dan menentukan kebutuhan rujukan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

GLOSARIUM

Istilah	Definisi
ASI (Air Susu Ibu)	Cairan biologis yang diproduksi oleh payudara ibu sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi.
Laktasi	Proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara.
Laktogenesis	Tahapan pembentukan ASI yang terdiri dari fase I (kehamilan), II (awal postpartum), dan III (pemeliharaan produksi ASI).
Prolaktin	Hormon yang berperan dalam produksi ASI.
Oksitosin	Hormon yang berperan dalam pengeluaran ASI melalui refleks let-down.
Refleks Let-Down	Mekanisme pengeluaran ASI akibat rangsangan hormon oksitosin saat bayi menyusu.
Kebutuhan Energi	Jumlah energi tambahan yang dibutuhkan ibu menyusui untuk produksi ASI dan aktivitas sehari-hari.
Makronutrien	Zat gizi utama yang dibutuhkan dalam jumlah besar, meliputi karbohidrat, protein, dan lemak.
Mikronutrien	Zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti vitamin dan mineral.
DHA (Docosahexaenoic Acid)	Asam lemak esensial omega-3 yang penting untuk perkembangan otak dan penglihatan bayi.
Zat Besi (Fe)	Mineral penting untuk pembentukan hemoglobin dan pencegahan anemia.
Anemia	Kondisi kekurangan hemoglobin dalam darah yang dapat menyebabkan lemah dan kelelahan.
Kalsium	Mineral yang penting untuk kesehatan tulang ibu dan bayi.
Vitamin D	Vitamin yang berperan dalam penyerapan kalsium dan kesehatan tulang.
Asam Folat	Vitamin B kompleks yang penting untuk pembentukan sel darah merah dan pertumbuhan jaringan.
Vitamin B12	Vitamin yang berperan dalam fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah.

Istilah	Definisi
Iodium	Mineral yang penting untuk fungsi kelenjar tiroid dan perkembangan otak bayi.
Zinc (Seng)	Mineral yang berperan dalam sistem imun dan penyembuhan luka.
Hidrasi	Status kecukupan cairan dalam tubuh untuk menjaga fungsi fisiologis.
Dehidrasi	Kondisi kekurangan cairan tubuh yang dapat mengganggu fungsi organ.
Suplementasi	Pemberian tambahan zat gizi dalam bentuk suplemen untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Sleep Fragmentation	Pola tidur yang terputus-putus, umum terjadi pada ibu nifas akibat menyusui malam hari.
Rest While Baby Sleeps	Strategi istirahat dengan tidur saat bayi tidur untuk mengurangi kelelahan ibu.
Aktivitas Fisik Postpartum	Aktivitas atau latihan fisik yang dilakukan ibu setelah melahirkan secara bertahap dan aman.
Latihan Kegel	Latihan untuk memperkuat otot dasar panggul.
Baby Blues	Perubahan emosional ringan pada ibu setelah melahirkan yang bersifat sementara.
Depresi Postpartum	Gangguan mood serius setelah melahirkan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Komunikasi Terapeutik	Komunikasi yang dilakukan tenaga kesehatan secara empatik, efektif, dan berfokus pada kebutuhan pasien.
Edukasi Berbasis Bukti	Penyampaian informasi kesehatan yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terbaru.
SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan)	Format dokumentasi asuhan kebidanan yang sistematis dan terstruktur.
Asuhan Komprehensif	Pelayanan kesehatan yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan edukasi secara menyeluruh.
Higienitas	Upaya menjaga kebersihan diri untuk mencegah infeksi.
Mastitis	Peradangan pada jaringan payudara yang dapat disebabkan oleh infeksi atau bendungan ASI.

Istilah**Bendungan ASI****Mobilisasi Dini****Definisi**

Kondisi penumpukan ASI di payudara yang menyebabkan payudara terasa penuh dan nyeri.

Aktivitas bergerak secara bertahap setelah persalinan untuk mempercepat pemulihan.

Referensi

- Agustina, R., Rianda, D., Lasepa, W., Birahmatika, F. S., Stajic, V., & Mufida, R. (2023). Nutrient intakes of pregnant and lactating women in Indonesia and Malaysia: Systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Nutrition*, 10, 1030343.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). *Optimizing postpartum care*. Obstetrics & Gynecology.
- Astuti, D., Rahfiludin, M. Z., Dwidiyanti, M., & Denny, H. M. (2024). Enhancing oxytocin and prolactin levels to address oligogalactia through emotional management and massage in working mothers. *Narra J*, 4(3), e963.
- Bains, G., Hayman, M. J., Kolker, S., & Davenport, M. H. (2025). Miles and Maternity: A Survey of Long-Duration Exercise During Pregnancy: G. Bains et al. *Sports Medicine*, 55(9), 2339–2350.
- Ball, L., de Jersey, S., Parkinson, J., Vincze, L., & Wilkinson, S. (2022). Postpartum nutrition: Guidance for general practitioners to support high-quality care. *Australian Journal of General Practice*, 51(3), 123–128.
- Benson, A. E., Lo, J. O., & Caughey, A. B. (2024). Iron deficiency and iron deficiency anemia during pregnancy—opportunities to optimize perinatal health and health equity. *JAMA Network Open*, 7(8), e2429151.
- Bentley, G. R. (1998). Hydration as a limiting factor in lactation. *American Journal of Human Biology: The Official Journal of the Human Biology Association*, 10(2), 151–161.
- Bo, K., Frawley, H. C., Haylen, B. T., Abramov, Y., Almeida, F. G., Berghmans, B., Bortolini, M., Dumoulin, C., Gomes, M., & McClurg, D. (2017). An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for the conservative and nonpharmacological management of female pelvic floor dysfunction. *International Urogynecology Journal*, 28(2), 191–213.
- Brown, J. E. (2023). *Nutrition Through the Life Cycle*. Cengage Learning.
- Butte, N. F., & King, J. C. (2022). Energy requirements during pregnancy and lactation. *Public Health Nutrition*, 25(5), 1344–1352.
- Cao Z, Huang M, Chen Y, et al. (2024). Association Between Gestational Weight Gain and Delayed Onset of Lactogenesis II: a Systematic Review and Meta-Analysis. *Breastfeeding Medicine*, 19(8), 588-598. <https://doi.org/10.1089/bfm.2024.0032>
- Carretero-Krug, A., Montero-Bravo, A., Morais-Moreno, C., Puga, A. M., Samaniego-Vaesken, M. de L., Partearroyo, T., & Varela-Moreiras, G. (2024). Nutritional status of breastfeeding mothers and impact of diet and

- dietary supplementation: a narrative review. *Nutrients*, 16(2), 301.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2022). *Williams obstetrics (26th ed.)*. McGraw-Hill.
- Deferm, N., Dinh, J., Pansari, A., Jamei, M., & Abduljalil, K. (2025). Postpartum changes in maternal physiology and milk composition: a comprehensive database for developing lactation physiologically-based pharmacokinetic models. *Frontiers in Pharmacology*, Volume 16-2025. <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1517069>
- Falize, C., Savage, M., Jeanes, Y. M., & Dyllal, S. C. (2024). Evaluating the relationship between the nutrient intake of lactating women and their breast milk nutritional profile: a systematic review and narrative synthesis. *British Journal of Nutrition*, 131(7), 1196–1224.
- Gavin, N. I., Gaynes, B. N., Lohr, K. N., Meltzer-Brody, S., Gartlehner, G., & Swinson, T. (2005). Perinatal depression: a systematic review of prevalence and incidence. *Obstetrics & Gynecology*, 106(5 Part 1), 1071–1083.
- Gomez-Casado, G., Saldaña-Garcia, N., Gonzalez-Mesa, E., & Ortega-Gomez, A. (2025). Etiology of Delayed Lactogenesis in Obesity. *Biomedicines*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/biomedicines13081848>
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of medical physiology* (14th ed). Elsevier.
- Heck, J. (2020). A Phenomenological Study of Postpartum Depression in Women Who Are Native Americans or Alaska Natives. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 49(6), S1–S2.
- Institute of Medicine. (2020). *Dietary reference intakes for water and electrolytes*.
- Kankaew, S., & Briere, C.-E. (2025). Maternal nutrition and human milk nutrients: A scoping review. *MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing*, 50(1), 9–17.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Pedoman gizi seimbang bagi ibu hamil dan menyusui*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman praktik klinis penatalaksanaan dehidrasi*.
- Klatt, K. C., McDougall, M. Q., Malysheva, O. V., Taesuwan, S., Loinard-González, A. (Alex) P., Nevins, J. E. H., Beckman, K., Bhawal, R., Anderson, E., & Zhang, S. (2022). Prenatal choline supplementation improves biomarkers of maternal docosahexaenoic acid (DHA) status among pregnant participants consuming supplemental DHA: a randomized controlled trial.

The American Journal of Clinical Nutrition, 116(3), 820–832.

- Koletzko, B., Bergmann, K., Brenna, J. T., Calder, P. C., Campoy, C., Clandinin, M. T., Colombo, J., Daly, M., Decsi, T., & Demmelmair, H. (2020). Should formula for infants provide arachidonic acid along with DHA? A position paper of the European Academy of Paediatrics and the Child Health Foundation. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 111(1), 10–16.
- Kołomańska-Bogucka, D., & Mazur-Bialy, A. I. (2019). Physical activity and the occurrence of postnatal depression—a systematic review. *Medicina*, 55(9), 560.
- Kwiatkowska, E., Kajdy, A., Sikora-Szubert, A., Karowicz-Bilinska, A., Zembron-Lacny, A., Ciechanowski, K., Krzywanski, J., Kwiatkowski, S., Kostka, T., & Sieroszewski, P. (2024). Polish Society of Gynecologists and Obstetricians (PTGiP) and Polish Society of Sports Medicine (PTMS) recommendations on physical activity during pregnancy and the postpartum period. *Ginekologia Polska*, 95(3), 218–231.
- Larson-Meyer, D. E. (2002). Effect of postpartum exercise on mothers and their offspring: a review of the literature. *Obesity Research*, 10(8), 841–853.
- Lawrence, R. A., & Lawrence, R. M. (2022). *Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession (9th ed.)*. Elsevier.
- Listiyorini, D., Lubis, U. L., Wardana, S. P., & Maulita, M. (2022). Gambaran Pengetahuan Ibu Postpartum Tentang Pencegahan Mastitis Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Jurnal Alaqoh*, 12(1).
- Maharani, H. S., Sari, F., Yogi, E. D., Muwarni, A., & Julia, J. (2023). Pengaruh massage payudara teknik menyusui terhadap risiko terjadinya mastitis. *Health Sciences and Pharmacy Journal*, 7(1), 30–35.
- Malisova, O., Apergi, K., Niaos, E., Xenaki, F., & Kapsokefalou, M. (2024). Investigating water balance as a nutritional determinant in breastfeeding: A comparative study of water consumption patterns and influencing factors. *Nutrients*, 16(13), 2157.
- Mazur, D., Rekowski, A. K., Grunwald, A., Bień, K., Kimber-Trojan, Ż., & Leszczyńska-Gorzela, B. (2024). Impact of maternal body composition, hydration, and metabolic health on breastfeeding success: A comprehensive review. *Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research*, 30, e945591.
- MomJunction. (2024). *Dehydration while breastfeeding: Causes, symptoms, and treatment*.
- Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2020). *Foundations of maternal-newborn and women's health nursing (7th ed.)*. Elsevier.
- Neville, M. C., Morton, J., & Umemura, S. (2012). Lactogenesis: The transition from

- pregnancy to lactation. *Pediatric Clinics of North America*, 48(1), 35–52.
- Nowak-Szczepanska, N., Gomula, A., Chakraborty, R., & Koziel, S. (2021). Nutritional and weight status of Indian mother-child dyads experienced by a natural disaster. *Maternal & Child Nutrition*, 17(3), e13164.
- PERWIRANINGTYAS, P., Inya, T. Y., Mesa, V. R., Yelnita, Y., & Bili, Y. (2026). PERAWATAN PAYUDARA SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PRODUKSI DAN PENGELUARAN ASI PADA MASA NIFAS: BREAST CARE AS AN EFFORT TO OPTIMIZE MILK PRODUCTION AND SECRETION DURING THE POSTPARTUM PERIOD. *Jurnal Abdimas Pamenang*, 4(1), 20–27.
- Pillay, J., & Davis, T. J. (2021). Delayed onset of lactogenesis II. *Journal of Human Lactation*, 37(3), 537–544.
- Riordan, J., & Wambach, K. (2022). *Breastfeeding and Human Lactation (6th ed.)*. (Jones & Bartlett Learning. (ed.)).
- Rios-Leyvraz, M., & Yao, Q. (2023). Calcium, zinc, and vitamin D in breast milk: a systematic review and meta-analysis. *International Breastfeeding Journal*, 18(1), 27.
- Rollnick, S., Miller, W. R., Butler, C. C., & Aloia, M. S. (2008). *Motivational interviewing in health care: helping patients change behavior*. Taylor & Francis.
- Sadek, A. M. (2025). ASSOCIATIONS BETWEEN VITAMIN D DEFICIENCY AND SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS, LIFESTYLE BEHAVIORS, AND METABOLIC CONDITIONS: A CROSS-SECTIONAL STUDY FROM THE HNNHS IN GREECE.
- Shorey, S., Chee, C. Y. I., Ng, E. D., Chan, Y. H., San Tam, W. W., & Chong, Y. S. (2018). Prevalence and incidence of postpartum depression among healthy mothers: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Psychiatric Research*, 104, 235–248.
- Shorey, S., Ng, E. D., Haugan, G., & Law, E. (2020). The parenting experiences and needs of Asian primary caregivers of children with autism: A meta-synthesis. *Autism*, 24(3), 591–604.
- Sizer, F., & Whitney, E. (2024). *Nutrition: Concepts and Controversies*. Cengage Learning.
- Slomian, J., Honvo, G., Emonts, P., Reginster, J.-Y., & Bruyère, O. (2019). Consequences of maternal postpartum depression: A systematic review of maternal and infant outcomes. *Women's Health*, 15, 1745506519844044.
- Tschann, J. M., Martinez, S. M., Penilla, C., Gregorich, S. E., Pasch, L. A., de Groat, C. L., Flores, E., Deardorff, J., Greenspan, L. C., & Butte, N. F. (2015). Parental feeding practices and child weight status in Mexican American families: a

- longitudinal analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.1186/s12966-015-0224-2>
- UNICEF. (2022). *Pakistan Maternal Nutrition Strategy*.
- Utari, I. S. (2023). *Implementasi breastcare pada ny. r postpartum spontan dengan menyusui tidak efektif*. UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA.
- Uvnäs-Moberg, K., Ekström-Bergström, A., Buckley, S., et al. (2020). Maternal plasma levels of oxytocin during breastfeeding. *Acta Paediatrica*, 109(5), 897–906.
- Victora C, Christian P, V. L. et al. (2021). Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries: variable progress towards an unfinished agenda. *The Lancet*, 397, 1388–1399.
- Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J. D., França, G. V. A., Horton, S., Krasevec, J., Murch, S., Sankar, M. J., Walker, N., & Rollins, N. C. (2016). Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *The Lancet*, 387(10017), 475–490.
- WHO. (2023). *Breastfeeding recommendations and maternal nutrition*.
- William, W. W., Bukhari, N. H. B. M., & Abdul, N. A. A. (2025). Optimising Breastfeeding with Functional Foods: A Mini Review. *International Journal*, 2(2), 16–30.
- Winarti, G., Nasution, S. Z., & Siregar, F. L. S. (2024). Efektifitas Edukasi Berbasis Family Centered Maternity Care terhadap Dukungan Keluarga dan Self Efficacy pada Ibu Postpartum dalam Pemberian Asi. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 6(1), 1415–1423.
- World Health Organization. (2021). *Guideline on maternal nutrition and breastfeeding*.
- World Health Organization. (2022a). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*.
- World Health Organization. (2022b). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. WHO.
- World Health Organization. (2022). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. WHO.

BAB 2

INFEKSI MASA NIFAS: ENDOMETRITIS, INFEKSI LUKA, DAN TATALAKSANA AWAL

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab hukum dalam pemberian asuhan nifas dan menyusui.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi interprofesional dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam seluruh rangkaian pelayanan nifas–menyusui.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-4	Melakukan clinical reasoning untuk mengkaji, menafsirkan, dan menyimpulkan status kesehatan ibu nifas dan menyusui.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan keterampilan asuhan nifas dan menyusui secara aman dan bermutu, termasuk stabilisasi awal dan rujukan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Menghasilkan dokumentasi asuhan, edukasi/konseling, dan penggunaan bukti ilmiah dasar untuk peningkatan mutu.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep, ruang lingkup, standar, dan alur pelayanan asuhan nifas dan menyusui berbasis keselamatan pasien.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis–psikologis nifas dan fisiologi laktasi untuk menafsirkan parameter klinis.
CPMK-3	Merancang dan melaksanakan asuhan esensial segera setelah persalinan (kala IV) termasuk pencegahan perdarahan dan keselamatan ibu.
CPMK-4	Melaksanakan pemantauan nifas terjadwal serta manajemen masalah umum (perineum/luka, nyeri, eliminasi) dengan clinical reasoning.
CPMK-5	Mengoptimalkan menyusui melalui teknik menyusui, perlekatan efektif, konseling, dan pemecahan masalah laktasi umum.
CPMK-6	Mengidentifikasi dan melakukan tatalaksana awal komplikasi/kegawatdaruratan nifas (perdarahan, infeksi, kesehatan mental) serta menetapkan kriteria rujukan dan kolaborasi.
CPMK-7	Menyusun edukasi, rencana tindak lanjut, dan dokumentasi asuhan nifas–menyusui berbasis bukti dengan komunikasi terapeutik.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Infeksi Masa Nifas: Endometritis, Infeksi Luka, dan Tatalaksana Awal	2.1 Mengidentifikasi tanda infeksi nifas (endometritis, infeksi luka) dan faktor risiko melalui anamnesis dan pemeriksaan.	2.2 Melaksanakan tatalaksana awal dan pencegahan PPI serta menentukan kebutuhan rujukan sesuai kriteria.	CPMK-6	CPMK-4; CPMK-7

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	OSCE kunjungan nifas & perawatan; Laporan praktik mini-case	Pengkajian terjadwal dan deteksi dini risiko akurat ($\geq 85\%$ keputusan tepat); Teknik perawatan/perencanaan tindak lanjut sesuai SOP (error kritis = 0)	20	Checklist OSCE; laporan mini-case; catatan asuhan
CPMK-6	Simulasi skenario kegawatdaruratan; Ujian tulis skenario	Pengenalan tanda bahaya cepat dan tepat (≤ 2 menit pada simulasi); Stabilisasi awal sesuai prioritas dan aman; Keputusan rujukan/kolaborasi sesuai kriteria	15	Lembar penilaian simulasi; jawaban skenario
CPMK-7	Portofolio (dokumentasi & edukasi); Presentasi singkat	Dokumentasi lengkap-akurat-terstruktur ($\geq 90\%$ komponen); Materi edukasi jelas sesuai literasi; Menggunakan ≥ 2 sumber bukti ilmiah; Rencana tindak lanjut spesifik dan realistis	10	Portofolio; leaflet/lembar edukasi; slide/presentasi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Akurasi konsep/terminologi dan standar	Banyak konsep inti keliru; istilah tidak konsisten; standar tidak jelas.	Konsep dasar cukup benar namun ada kekeliruan penting; standar disebut terbatas.	Mayoritas konsep benar; kekeliruan minor; standar relevan digunakan.	Konsep sangat akurat; istilah konsisten; standar digunakan tepat dan menyeluruh.
1.2 Kesesuaian alur pelayanan dengan keselamatan pasien	Alur tidak runtut; langkah kritis keselamatan terlewat.	Alur cukup runtut namun ada langkah kritis yang belum lengkap.	Alur runtut; langkah kritis terpenuhi; risiko utama dikenali.	Alur runtut dan efisien; prioritas jelas; mitigasi risiko & eskalasi dirumuskan tepat.

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter fisiologis nifas & laktasi	Salah menafsirkan data; tidak dapat membedakan normal–abnormal.	Menafsirkan sebagian data namun ada salah simpulan pada temuan penting.	Menafsirkan data dengan benar; membedakan normal–abnormal dengan tepat.	Interpretasi sangat tepat; mengaitkan pola data dan prioritas masalah secara tajam.
2.2 Analisis perubahan emosi & faktor risiko psikologis	Tidak mengenali pola gejala; faktor risiko tidak relevan.	Mengenali gejala umum namun analisis risiko dangkal/tidak lengkap.	Analisis gejala dan risiko memadai; menyusun kebutuhan dukungan awal.	Analisis komprehensif; mempertimbangkan konteks keluarga/sosial; rekomendasi dukungan sangat tepat.

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Pengkajian kala IV dan penetapan status risiko	Pengkajian tidak lengkap; banyak data penting terlewat; risiko tidak tepat.	Pengkajian cukup namun masih ada data penting kurang; risiko sebagian tepat.	Pengkajian lengkap sesuai urutan; status risiko tepat.	Pengkajian sangat sistematis; cepat; risiko diprioritaskan dan dikomunikasikan jelas.
3.2 Intervensi pencegahan perdarahan & keselamatan ibu	Tindakan tidak sesuai prioritas; berisiko/menyalahi prosedur.	Tindakan sebagian tepat namun urutan/prioritas belum konsisten.	Tindakan tepat dan aman; prioritas sesuai protokol.	Tindakan sangat tepat; antisipasi komplikasi; koordinasi tim dan keselamatan optimal.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Pengkajian kunjungan nifas & deteksi dini risiko	Pengkajian tidak terstruktur; tanda risiko sering terlewat.	Pengkajian cukup terstruktur namun deteksi risiko belum konsisten.	Pengkajian terstruktur; risiko terdeteksi tepat; keputusan tindak lanjut sesuai.	Pengkajian sangat komprehensif; mengaitkan tren; rencana tindak lanjut proaktif dan tepat.
4.2 Manajemen masalah umum (luka/nyeri/eliminasi) & rencana tindak lanjut	Intervensi tidak tepat/tidak aman; edukasi minim; tindak lanjut tidak jelas.	Intervensi cukup tepat namun rasional/edukasi kurang lengkap.	Intervensi tepat dan aman; edukasi memadai; tindak lanjut jelas.	Intervensi sangat tepat; personalisasi edukasi; evaluasi respons dan eskalasi direncanakan matang.

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Teknik menyusui & perlekatan efektif	Posisi/perlekatan salah; tidak dapat menunjukkan tanda efektif.	Posisi/perlekatan cukup namun masih ada kesalahan yang mengganggu efektivitas.	Posisi/perlekatan benar; menunjukkan tanda efektivitas menyusui.	Teknik sangat tepat; mampu mengoreksi kesalahan; evaluasi kecukupan menyusui sangat baik.
5.2 Konseling & pemecahan masalah laktasi	Tidak mampu mengidentifikasi penyebab; solusi tidak sesuai.	Identifikasi penyebab sebagian; solusi umum dan kurang spesifik.	Identifikasi penyebab tepat; solusi sesuai dan realistis; komunikasi empatik.	Analisis masalah tajam; solusi bertahap sesuai keparahan; dukungan/kolaborasi direncanakan optimal.

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi cepat komplikasi/kegawatdaruratan	Terlambat mengenali; salah menentukan prioritas; tanda bahaya terlewat.	Mengenali tanda bahaya utama namun belum cepat/kurang lengkap.	Mengenali tanda bahaya dengan cepat; prioritas masalah tepat.	Sangat cepat dan akurat; menilai derajat/keparahan secara sistematis.
6.2 Stabilisasi awal & keputusan rujukan/kolaborasi	Tindakan awal tidak sesuai/berisiko; rujukan tidak tepat.	Tindakan awal sebagian tepat; rujukan/kolaborasi belum jelas.	Stabilisasi awal tepat dan aman; rujukan/kolaborasi sesuai kriteria.	Stabilisasi sangat tepat; koordinasi tim efektif; rujukan disertai informasi klinis lengkap dan tepat waktu.

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Dokumentasi asuhan (lengkap, akurat, terstruktur)	Banyak komponen hilang; data tidak akurat; format tidak runtut.	Komponen utama ada namun masih kurang detail/ada inkonsistensi.	Dokumentasi lengkap dan akurat; format runtut; rencana jelas.	Dokumentasi sangat lengkap; analitis; mudah ditelusuri; mendukung kesinambungan asuhan.
7.2 Edukasi, rencana tindak lanjut, dan penggunaan bukti	Edukasi tidak jelas/tidak sesuai; tindak lanjut tidak spesifik; tanpa rujukan bukti.	Edukasi cukup jelas namun belum sesuai literasi; tindak lanjut umum; bukti minimal.	Edukasi jelas sesuai literasi; tindak lanjut spesifik; menggunakan bukti relevan.	Edukasi sangat jelas dan terpersonalisasi; tindak lanjut terukur; bukti kuat dan diintegrasikan tepat.

Pendahuluan

Masa nifas (puerperium) adalah periode yang dimulai setelah persalinan hingga 6 minggu postpartum, di mana tubuh ibu mengalami pemulihan fisiologis termasuk involusi uterus, pemulihan luka, serta adaptasi terhadap perubahan hormonal. Periode ini merupakan fase yang sangat rentan terhadap komplikasi, terutama infeksi, karena adanya luka pada jalan lahir dan penurunan daya tahan tubuh ibu setelah persalinan (WHO, 2015; Cunningham et al., 2018).

Infeksi masa nifas (puerperal sepsis) didefinisikan sebagai infeksi bakteri pada traktus genital yang terjadi setelah persalinan, ditandai dengan demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ yang muncul dalam 10 hari pertama postpartum (kecuali 24 jam pertama) disertai dengan nyeri pelvis, lochia berbau, atau subinvolusi uterus. Infeksi ini masih menjadi penyebab utama kematian ibu di dunia, terutama di negara berkembang dengan akses pelayanan kesehatan yang terbatas (WHO, 2017; Kemenkes RI, 2020).

Salah satu bentuk infeksi yang paling sering terjadi adalah endometritis, yaitu infeksi pada lapisan endometrium uterus yang biasanya disebabkan oleh invasi bakteri setelah persalinan, terutama pada kasus persalinan dengan tindakan (operatif) atau ketuban pecah lama. Kondisi ini dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti sepsis jika tidak ditangani secara cepat dan tepat (Williams Obstetrics, 2018; NICE, 2021).

Selain itu, infeksi luka pada masa nifas juga sering ditemukan, baik pada luka perineum akibat episiotomi/ruptur maupun luka operasi sectio caesarea. Infeksi luka terjadi akibat kontaminasi bakteri, teknik aseptik yang kurang optimal, atau perawatan luka yang tidak adekuat. Tanda-tandanya meliputi kemerahan, nyeri, pembengkakan, keluarnya nanah, dan demam (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2018).

Faktor risiko infeksi masa nifas antara lain adalah anemia, malnutrisi, persalinan lama, ketuban pecah dini, pemeriksaan vaginal berulang, tindakan invasif, serta kondisi sosial ekonomi yang rendah. Pencegahan infeksi dapat dilakukan melalui praktik higiene yang baik, penggunaan teknik aseptik, serta pemantauan ketat selama masa nifas (Fraser & Cooper, 2019; WHO, 2015).

Oleh karena itu, tenaga kesehatan khususnya bidan harus memiliki kompetensi dalam melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal, serta rujukan yang tepat terhadap kasus infeksi masa nifas untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan menurunkan angka kematian ibu (Kemenkes RI, 2020; IBI, 2021).

Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan infeksi, khususnya endometritis dan

infeksi luka, serta mampu melakukan tatalaksana awal secara tepat sesuai standar pelayanan kebidanan.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

1. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:
2. Menjelaskan pengertian infeksi masa nifas
3. Mengidentifikasi faktor risiko infeksi masa nifas
4. Menjelaskan patofisiologi endometritis
5. Mengidentifikasi tanda dan gejala endometritis
6. Menjelaskan konsep infeksi luka perineum dan luka operasi
7. Mengidentifikasi tanda dan gejala infeksi luka
8. Melakukan deteksi dini infeksi masa nifas
9. Menjelaskan prinsip tatalaksana awal infeksi masa nifas
10. Menentukan indikasi rujukan pada infeksi masa nifas
11. Memberikan edukasi pencegahan infeksi pada ibu nifas

Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)

Capaian pembelajaran pada Bab 3 ini mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), khususnya kemampuan mahasiswa dalam mengelola konsep asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan infeksi.

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi tanda infeksi nifas (endometritis, infeksi luka) dan faktor risiko melalui anamnesis dan pemeriksaan. Melaksanakan pemantauan nifas terjadwal serta manajemen masalah umum (perineum/luka, nyeri, eliminasi) dengan clinical reasoning.
2. Melaksanakan tatalaksana awal dan pencegahan PPI serta menentukan kebutuhan rujukan sesuai kriteria.

Uraian Materi :

A. Pengertian Infeksi Masa Nifas

Infeksi nifas adalah semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya bakteri atau kuman ke dalam organ genital pada saat persalinan dan masa nifas. Infeksi nifas adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia yang terjadi setelah melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu sampai 38°C atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan, dengan mengecualikan 24 jam pertama. Infeksi nifas dapat disebabkan oleh transmisi masuknya bakteri ke dalam organ reproduksi, baik bakteri yang masuk dari dalam tubuh ibu sendiri, dari jalan lahir maupun bakteri dari luar yang sering menyebabkan infeksi.

Infeksi pada masa nifas merupakan salah satu menjadi penyebab masih tingginya AKI dan angka kesakitan (Morbiditas) yang masih tinggi. Infeksi puerperalis adalah keadaan yang mencakup semua peradangan alat-alat genitalia dalam masa post partum. Jadi yang dimaksud dengan infeksi puerperalis adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia yang terjadi setelah melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu 38°C. Infeksi post partum/puerperalis ialah infeksi klinis pada saluran genital yang terjadi dalam 28 hari setelah persalinan.

Adapun gejala umum yang ditunjukkan pada kasus infeksi pada masa postpartum adalah tanda-tanda infeksi seperti demam, dan tanda-tanda vital yang menurun atau keadaan umum ibu yang tidak baik. Beberapa faktor predisposisi infeksi masa nifas:

1. Kurang gizi atau malnutrisi

Nutrisi yang harus didapatkan oleh ibu nifas makan-makanan yang bernutrisi baik, karena ibu nifas membutuhkan nutrisi atau gizi yang dapat mendukung proses penyembuhannya, dan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan gizi untuk meningkatkan produksi ASI nya.

2. Anemia

Anemia bukan hanya terjadi pada ibu hamil tetapi anemia juga sering terjadi pada ibu masa nifas atau pasca salin dimana ini bukan hanya terjadi pada ibu nifas yang melahirkan normal tetapi juga memungkinkan juga terjadi pada ibu yang bersalin dengan metode operatif/Section Caesaria (SC). Oleh sebab itu pemberian tablet Fe atau tablet zat besi juga harus diberikan pada masa nifas.

3. Higiene

Personal hygiene atau kebersihan diri juga harus diperhatikan oleh ibu, karena ibu nifas yang baru saja melahirkan rentan sekali terkena infeksi jika ibu nifas tersebut tidak bersih dan melakukan personal hygiene.

4. Kelelahan

Ibu nifas yang baru saja melahirkan dan melalui proses persalinan yang Panjang membutuhkan power atau kekuatan untuk mendukung proses penyembuhannya.

B. Etiologi

Penyebab infeksi puerperalis ini melibatkan mikroorganisme anaerob dan aerob patogen yang merupakan flora normal serviks dan jalan lahir atau mungkin juga dari luar. Penyebab yang terbanyak dan lebih dari 50% adalah Streptococcus anaerob yang sebenarnya tidak patogen sebagai penghuni normal jalan lahir. Kuman-kuman yang sering menyebabkan infeksi puerperalis antara lain :

1. Streptococcus haematilicus aerobis

Masuknya secara eksogen dan menyebabkan infeksi berat yang ditularkan dari penderita lain, alat - alat yang tidak steril, tangan penolong dan sebagainya.

2. Staphylococcus aureus

Masuk secara eksogen, infeksi sedang, banyak ditemukan sebagai penyebab infeksi di rumah sakit.

3. Escherichia coli

Sering berasal dari kandung kemih dan rectum menyebabkan infeksi terbatas.

4. Clostridium welchii

Kuman anaerobik yang sangat berbahaya, sering ditemukan pada abortus kriminalis dan partus yang ditolong dukun dari luar rumah sakit.

C. Manifestasi Klinis

Tanda dan gejala yang timbul pada infeksi post partum antara lain demam, nyeri di daerah infeksi, terdapat tanda kemerahan pada daerah yang terinfeksi, fungsi organ terganggu. Gambaran klinis infeksi post partum adalah sebagai berikut:

1. Infeksi lokal

2. Warna kulit berubah, timbul nanah, bengkak pada luka, lokea bercampur nanah, mobilitas terbatas, suhu tubuh meningkat.

3. Infeksi umum

4. Sakit dan lemah, suhu badan meningkat, tekanan darah menurun, nadi meningkat, pernafasan meningkat dan sesak, penurunan kesadaran hingga koma, gangguan involusi uteri, lokea berbau, bernanah dan kotor.

D. Patofisiologi

Setelah kala III, daerah bekas insersio plasenta merupakan sebuah luka dengan diameter kira-kira 4 cm. Permukaannya tidak rata, terdapat benjolan-benjolan karena banyak vena yang ditutupi trombus. Daerah ini merupakan tempat yang baik untuk tumbuhnya kuman - kuman dan masuknya jenis-jenis yang patogen dalam tubuh wanita. Serviks sering mengalami perlukaan pada persalinan, demikian juga vulva, vagina dan perineum yang semuanya merupakan tempat masuknya kuman - kuman patogen. Proses radang dapat terbatas pada luka - luka tersebut atau menyebar di luar luka asalnya. Adapun infeksi dapat terjadi sebagai berikut :

1. Tangan pemeriksa atau penolong yang tertutup sarung tangan pada pemeriksaan dalam atau operasi membawa bakteri yang sudah ada dalam vagina ke dalam uterus. Kemungkinan lain ialah bahwa sarung tangan atau alat-alat yang dimasukkan ke dalam jalan lahir tidak sepenuhnya bebas dari kuman-kuman.
2. Droplet infeksi. Sarung tangan atau alat-alat terkena kontaminasi bakteri yang berasal dari hidung atau tenggorokan dokter atau petugas kesehatan lainnya yang berada di ruang tersebut. Oleh karena itu, hidung dan mulut petugas yang bekerja di kamar bersalin harus ditutup dengan masker dan penderita infeksi saluran pernapasan dilarang memasuki kamar bersalin.
3. Dalam rumah sakit terlalu banyak kuman-kuman patogen, berasal dari penderita-penderita dengan berbagai jenis infeksi. Kuman-kuman ini bisa dibawa oleh aliran udara kemana-mana, antara lain ke handuk, kain-kain yang tidak steril, dan alat-alat yang digunakan untuk merawat wanita dalam persalinan atau pada waktu post partum.
4. Koitus pada akhir kehamilan tidak merupakan sebab infeksi penting, apabila mengakibatkan pecahnya ketuban.
5. Infeksi intrapartum sudah dapat memperlihatkan gejala-gejala pada waktu berlangsungnya persalinan. Infeksi intra partum biasanya berlangsung pada waktu partus lama, apalagi jika ketuban sudah lama pecah dan beberapa kali dilakukan pemeriksaan dalam.
 - a. Gejala-gejalanya antara lain, kenaikan suhu tubuh
 - b. biasanya disertai dengan leukositosis dan takikardi,
 - c. denyut jantung janin dapat meningkat pula. Air
 - d. ketuban biasanya menjadi keruh dan berbau. Pada
 - e. infeksi intra partum kuman-kuman memasuki dinding
 - f. uterus pada waktu persalinan, dan dengan melewati
 - g. amnion dapat menimbulkan infeksi pula pada janin.

E. Jenis – jenis Infeksi

Kolonisasi merupakan proses ketika mikroorganisme menjadi flora normal. Pada keadaan ini mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang, tetapi tidak menyebabkan penyakit. Infeksi terjadi apabila mikroorganisme yang bery terbentuk yang berhasil menginvasi bagian tubuh. Ketika mekanisme pertahanan tubuh inang tidak inefektif dan pathogen tersebut menyebabkan kerusakan jaringan. Infeksi dapat menjadi penyakit ketika tanda dan gejala infeksi sangat unik dan dapat dibedakan dari kondisi lainnya. Adapun jenis infeksi yaitu:

1. Infeksi Rahim

a. Endometritis

Endometritis adalah infeksi pada endometrium (lapisan dalam dari rahim). Infeksi ini dapat terjadi sebagai kelanjutan infeksi pada serviks atau infeksi tersendiri dan terdapat benda asing dalam rahim. Endometritis adalah infeksi yang berhubungan dengan kelahiran anak, jarang terjadi pada wanita yang mendapatkan perawatan medis yang baik dan telah mengalami persalinan melalui vagina yang tidak berkomplikasi. Infeksi paska persalinan yang paling sering terjadi adalah endometritis yaitu infeksi pada endometrium atau pelapis rahim yang menjadi peka setelah lepasnya plasenta, lebih sering terjadi pada proses kelahiran caesar, setelah proses persalinan yang terlalu lama atau pecahnya membran yang terlalu dini. Infeksi ini juga sering terjadi bila ada plasenta yang tertinggal di dalam rahim, mungkin pula terjadi infeksi dari luka pada leher rahim, vagina atau vulva.

Tanda dan gejalanya akan berbeda bergantung dari asal infeksi, yaitu sedikit demam, nyeri yang samar-samar pada perut bagian bawah dan kadang - kadang keluar nanah dari vagina dengan berbau khas yang tidak enak, menunjukkan adanya infeksi pada endometrium. Infeksi karena luka biasanya terdapat nyeri tekan pada daerah luka, kadang berbau busuk, pengeluaran kental, nyeri pada perut, susah buang air kecil. Kadang-kadang tidak terdapat tanda yang jelas kecuali peningkatan suhu tubuh. Maka dari itu setiap perubahan suhu tubuh paska persalinan harus segera dilakukan pemeriksaan.

Infeksi endometrium dalam bentuk akut dengan gejala klinis yaitu nyeri abdomen bagian bawah, mengeluarkan keputihan, kadang-kadang terdapat perdarahan, dapat terjadi penyebaran seperti meometritis (infeksi otot rahim), parametritis (infeksi sekitar rahim), salpingitis (infeksi saluran tuba), ooforitis (infeksi indung telur), dapat terjadi sepsis (infeksi menyebar), pembentukan pernanahan sehingga terjadi abses pada tuba atau indung telur (Anonym, 2008).

Terjadinya infeksi endometrium pada saat persalinan, dimana bekas implantasi plasenta masih terbuka, terutama pada persalinan terlantar dan persalinan dengan tindakan terjadinya keguguran, saat pemasangan alat rahim yang kurang legeartis.

Kadang-kadang lokea tertahan oleh darah, sisa-sisa plasenta dan selaput ketuban. Keadaan ini dinamakan lokeametra dan dapat menyebabkan kenaikan suhu tubuh. Uterus pada endometritis akan terlihat membesar, serta nyeri pada perabaan dan teraba lembek.

Pada endometritis yang tidak meluas, penderita merasa kurang sehat dan nyeri perut pada hari-hari pertama. Mulai hari ke-3 suhu tubuh meningkat, nadi menjadi cepat, akan tetapi dalam beberapa hari suhu dan nadi menurun dan kurang lebih dalam satu minggu keadaan sudah Kembali normal. Loeka pada endometritis biasanya bertambah dan kadang-kadang berbau. Hal ini tidak boleh dianggap infeksi berat. Malahan infeksi berat kadang-kadang disertai oleh loeka yang sedikit dan tidak berbau. Untuk mengatasinya biasanya dilakukan pemberian antibiotik dengan sesegera mungkin agar hasilnya efektif. Dapat pula dilakukan biakkan untuk menentukan jenis bakteri, sehingga dapat diberikan antibiotik yang tepat.

b. Miometritis (infeksi otot rahim)

Miometritis adalah radang miometrium. Miometrium adalah tunika muskularis uterus. Gejalanya berupa demam, nyeri tekan pada uterus, perdarahan pada vagina dan nyeri perut bagian bawah, loeka berbau.

c. Parametritis (infeksi daerah di sekitar rahim)

Parametritis atau disebut juga sellulitis pelvika adalah radang yang terjadi pada parametrium yang disebabkan oleh invasi kuman. Penjalaran kuman sampai ke parametrium terjadi pada infeksi yang lebih berat. Infeksi menyebar ke parametrium lewat pembuluh limfe atau melalui jaringan di antara kedua lembar ligamentum latum. Parametrium dapat juga terjadi melalui salpingo-ooforitis. Parametritis umumnya merupakan komplikasi yang berbahaya dan merupakan sepertiga dari sebab kematian karena kasus infeksi.

Penyebab parametritis yaitu kuman-kuman memasuki endometrium (biasanya pada luka insersio plasenta) dalam waktu singkat dan menyebar ke seluruh endometrium. Pada infeksi setempat, radang terbatas pada endometrium. Jaringan desidua Bersama bekuan darah menjadi nekrosis dan mengeluarkan

getah berbau yang terdiri atas keping-keping nekrotis dan cairan. Pada infeksi yang lebih berat batas endometrium dapat dilampaui dan terjadilah penjalaran.

2. Syok bakteremia

Infeksi kritis, terutama yang disebabkan oleh bakteri yang melepaskan endotoksin, bisa mempresipitasi syok bakteremia (septik). Ibu hamil, terutama mereka yang menderita diabetes mellitus atau ibu yang memakai obat immunosupresan, berada pada tingkat resiko tinggi, demikian juga mereka yang menderita endometritis selama periode post partum.

Temuan laboratorium menunjukkan bukti-bukti infeksi. Biakan darah menunjukkan bakteremia, biasanya konsisten dengan hasil enterik gram negatif. Pemeriksaan tambahan dapat menunjukkan hemokonsentrasi, asidosis, dan koagulopati. Perubahan EKG menunjukkan adanya perubahan yang mengindikasikan insufisiensi miokard, bukti-bukti hipoksia jantung, paru-paru, ginjal dan neurologis bisa ditemukan. Demam yang tinggi dan menggigil adalah bukti patofisiologi sepsis yang serius. Ibu yang cemas dapat bersikap apatis. Suhu tubuh sering kali sedikit menurun menjadi subnormal, kulit teraba dingin dan lembab, warna kulit menjadi pucat dan denyut nadi menjadi cepat, hipotensi berat dan sianosis peripheral bisa terjadi, begitu juga oliguria. Penatalaksanaan terpusat pada antimikrobal, demikian juga dukungan oksigen untuk menghilangkan hipoksia jaringan dan dukungan sirkulasi untuk mencegah kolaps vaskular. Fungsi jantung, usaha pernafasan, dan fungsi ginjal dipantau dengan ketat. Pengobatan yang cepat terhadap syok bakteremia membuat prognosis menjadi baik. Morbiditas dan mortalitas maternal diturunkan dengan mengendalikan distresses pernafasan, hipotensi.

3. Peritonitis

Peritonitis post partum bisa terjadi karena meluasnya endometritis, tetapi dapat juga ditemukan bersama-sama dengan salpingo-ooforitis dan sellulitis pelviks. Kemungkinan bahwa abses pada sellulitis pelviks mengeluarkan nanah ke rongga peritoneum dan menyebabkan peritonitis. Peritonitis yang bukan peritonitis umum, terbatas pada daerah pelvis. Gejala - gejalanya antara lain penderita mengalami demam, nyeri pada perut bagian bawah, tetapi keadaan umum tetap baik, namun gejala-gejalanya tidak seberapa berat seperti pada peritonitis umum. Peritonitis umum disebabkan oleh kuman yang sangat patogen dan merupakan penyakit berat. Tanda dan gejalanya antara lain, suhu tubuh meningkat menjadi tinggi, nadi cepat dan terlihat kecil, perut kembung dan nyeri. Muka penderita yang mula-mula kemerah-merahan menjadi pucat, mata cekung, kulit di daerah wajah teraba dingin. Mortalitas peritonitis umum tinggi.

4. Infeksi saluran kemih

Infeksi saluran kemih (ISK) terjadi pada sekitar 10% wanita hamil, kebanyakan terjadi pada masa prenatal. Mereka yang sebelumnya mengalami ISK memiliki kecenderungan mengidap ISK lagi sewaktu hamil. Servitis, vaginitis, obstruksi ureter yang flaksid, refluks vesikoureteral, dan trauma lahir mempredisposisi wanita hamil untuk menderita ISK, biasanya dari *Escherichia coli*. Wanita dengan PMS kronis, terutama gonore dan klamidia juga memiliki resiko ISK. Bakteriuria asimtomatik terjadi pada sekitar 5% sampai 15% wanita hamil. Jika tidak diobati akan terjadi pielonefritis kira-kira 30% pada wanita hamil. Kelahiran dan persalinan prematur juga dapat lebih sering terjadi. Biakan dan tes sensitivitas urine harus dilakukan di awal kehamilan, lebih bagus pada kunjungan pertama, spesimen diambil dari urin yang diperoleh dengan cara bersih. Jika didiagnosis adanya infeksi, pengobatan akan dilakukan dengan memberikan antibiotik yang sesuai selama dua

sampai tiga minggu, disertai peningkatan asupan air dan obat antispasmodik traktus urinarius.

5. Septikemia dan piemia

Infeksi nifas yang penyebarannya melalui pembuluh darah adalah septikemia piemia dan tromboflebitis. Infeksi ini merupakan infeksi umum yang disebabkan oleh kuman patogen *Streptococcus Hemolitikus* Golongan A. Infeksi ini sangat berbahaya dan merupakan 50% dari semua kematian karena infeksi nifas. Pada septikemia kuman-kuman yang ada di uterus, langsung masuk ke peredaran darah dan menyebabkan infeksi. Adanya septikemia dapat dibuktikan dengan jalan pembiakan kuman-kuman

dari darah. Pada piemia terdapat dahulu tromboflebitis pada vena-vena di uterus serta sinus-sinus pada bekas tempat plasenta. Tromboflebitis ini menjalar ke vena uteri, vena hipogastrika, dan vena ovary (tromboflebitis pelvika). Dari tempat-tempat thrombus itu embolus kecil yang mengandung kuman-kuman dilepaskan. Tiap kali dilepaskan, embolus masuk ke peredaran darah umum dan dibawa oleh aliran darah ke tempat-tempat lain, antaranya ke paru-paru, ginjal, otak, jantung, dan sebagainya mengakibatkan terjadinya abses-abses di tempat-tempat tersebut.

Keadaan ini dinamakan piemia. Kedua-duanya merupakan infeksi berat namun gejala-gejala septikemia lebih mendadak dari piemia. Pada septikemia, dari permulaan penderita sudah sakit dan lemah. Sampai tiga hari post partum suhu tubuh meningkat dengan cepat, biasanya disertai rasa menggigil. Suhu tubuh berkisar antara 39 – 40°C, keadaan umum cepat memburuk, nadi menjadi cepat (140 – 160X/menit atau lebih). Penderita meninggal dalam enam sampai

tujuh hari post partum. Jika ia hidup terus, gejala-gejala menjadi seperti piemia. Pada piemia, penderita post partum sudah merasa sakit, nyeri perut, dan suhu agak meningkat. Akan tetapi gejala-gejala infeksi umum dengan suhu tinggi serta menggigil terjadi setelah kuman-kuman dengan embolus memasuki peredaran darah. Suatu ciri khusus pada piemia ialah berulang-ulang suhu meningkat dengan cepat disertai menggigil, kemudian diikuti oleh turunnya suhu. Ini terjadi pada saat dilepaskannya embolus dari tromboflebitis pelvika. Lambat laun timbul gejala abses pada paru-paru, pneumonia dan pleuritis. Embolus dapat pula menyebabkan abses-abses di beberapa tempat lain.

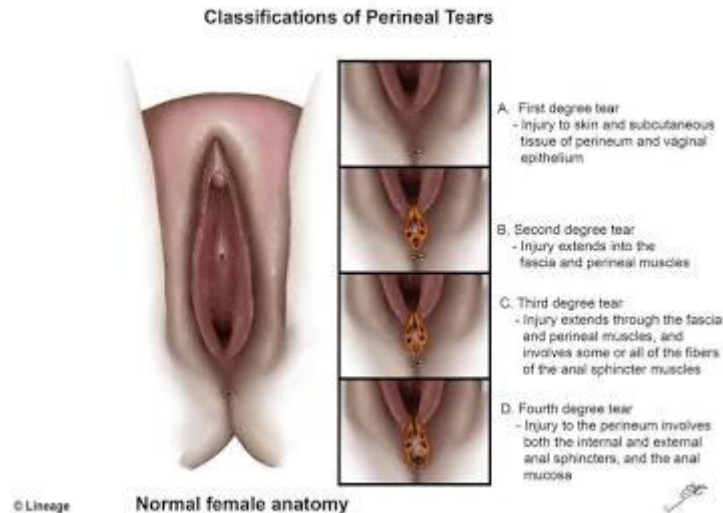
F. Infeksi Luka

1. Luka Perineum

Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit, yang membentang antara komisura posterior dan anus. Panjangnya rata-rata 4 cm perineum adalah otot, kulit, dan jaringan yang ada diantara kelamin dan anus. Secara anatomis, perineum berbentuk seperti belah ketupat (diamond-shaped) yang dibagi menjadi dua segitiga: segitiga urogenital (depan) dan segitiga anal (belakang). Di sinilah jaringan kulit dan otot saling berinteraksi.

Berdasarkan kedalaman jaringan kulit dan otot yang terlibat, luka perineum dibagi menjadi 4 derajat:

- a. Derajat 1: Luka hanya mengenai kulit perineum dan mukosa vagina. Otot masih utuh.
- b. Derajat 2: Luka meluas mengenai kulit dan otot-otot perineum (seperti *M. transversus perinei*), tetapi belum mencapai sfingter ani.
- c. Derajat 3: Luka robek telah mencapai otot sfingter ani externus (robekan parsial atau total).
- d. Derajat 4: Luka paling berat, robekan menembus otot sfingter ani hingga mengenai mukosa rektum (jalan kotor).



Gambar 2. 1 Derajat Keparahan Luka Robekan Perineum.
Sumber: Medbullets Step 2

2. Episiotomi

Episiotomi adalah suatu tindakan insisi pada perineum yang menyebabkan terpotongnya selaput lendir vagina, cincin selaput dara, jaringan pada septum rektovaginal, otot-otot dan fascia perineum dan kulit sebelah depan perineum. Episiotomi dilakukan bila terjadi perengangan perineum yang berlebihan sehingga ditakuti akan terjadi robekan perineum, umpama pada primipara, persalinan sungsang, persalinan dengan cunam, ekstrasi vakum dan anak besar. Tujuan episiotomi :

- Facilitas untuk persalinan dengan tindakan atau menggunakan instrument
- Mencegah robekan perineum yang baku atau diperkirakan tidak mampu beradaptasi terhadap regangan yang berlebihan (misalnya bayi yang sangat besar atau makrosomia)
- Mencegah kerusakan jaringan pada ibu dan bayi pada kasus presentase upnormal (bokong, muka, ubun-ubun kecil di belakang) dengan menyediakan tempat lebih luas untuk persalinan yang aman

G. Ruptur

Robekan pada perineum umumnya terjadi pada persalinan di mana kepala janin terlalu cepat lahir; persalinan tidak dipimpin sebagaimana mestinya; sebelumnya pada perineum terdapat banyak jaringan parut; dan pada persalinan dengan distorsia bahu. Bentuk rupture biasanya tidak teratur sehingga jaringan yang robek sulit dilakukan penjahitan.

Berdasarkan tingkat keparahannya trauma perineum dibagi menjadi derajat satu hingga empat. Trauma derajat satu ditandai adanya luka pada lapisan kulit dan

lapisan mukosa saluran vagina dengan atau tanpa mengenai kuit perineum. Perdarahannya biasanya sedikit. Trauma derajat dua luka sudah mencapai otot perinei transversalis, tetapi tidak mengenai otot sfingter ani. Trauma derajat tiga robekan mengenai perineum sampai dengan otot sfingter ani. Pada trauma derajat empat telah mencapai otot sfingter ani dan mukosa rektum sehingga perdarahannya pun lebih banyak.

H. Infeksi Luka

Wanita dianggap menderita infeksi perperium jika terjadi demam pada suhu 38°C (100,4 °F) atau lebih setelah 24 jam pertama setelah melahirkan dan demam bertahan paling tidak 2 hari dalam 10 hari pertama paska melahirkan (Joyce Y , 2010). Infeksi puerperium adalah infeksi bakteri yang berasal dari saluran reproduksi saluran reproduksi selama persalinan atau puerperium.

1. Vulvalitis

Pada luka infeksi bekas sayatan episiotomi atau luka perineum, jaringan sekitarnya membengkak, tepi luka menjadi merah dan bengkak, jahitan mudah terlepas, luka yang terbuka menjadi ulkus dan mengeluarkan pus.

2. Vaginitis

Infeksi pada vagina yang dapat terjadi secara langsung pada luka vagina atau melalui luka perineum. Permukaan mukosa membengkak dan kemerahan terjadi ulkus, serta getah mengandung nanah dan keluar dari daerah ulkus tersebut.

3. Servitis

Infeksi servik sering terjadi , akan tetapi biasanya tidak menimbulkan banyak gejala. Luka serviks yang dalam , luas dan langsung ke dasar ligamentum latum dapat menyebabkan infeksi yang menjalar ke parametrium. Adapun tanda dan gejalanya yaitu rasa nyeri dan panas pada area yang terinfeksi, kadang-kadang perih bila kencing, nadi dibawah 100x/menit, getah radang dapat keluar, suhu sekitar 38°C-40°C.

4. Septicemia

Infeksi ini merupakan infeksi yang umum yang disebabkan oleh kuman - kuman yang sangat pathogen. Infeksi ini sangat berbahaya dan tergolong 50% penyebab kematian karena infeksi nifas. Septicemia adalah infeksi yang terjadi akibat kuman-kuman langsung masuk keperedaran darah umum dan menyebabkan infeksi umum. Adanya septicemia dapat diartikan bahwa merupakan jalan pembiakan kuman-kuman dari darah. Adapun tanda dan gejala antara lain permulaan penderita sudah sakit dan lemah, samapi hari ke- 3 post

partum, suhu meningkat dengan cepat dan menggigil, selanjutnya suhu berkisar antara 39°C - 40°C, ku memburuk, nadi cepat (140-160x/menit)

5. Peritonitis

Peritonitis adalah peradangan atau infeksi yang terjadi pada peritoneum(selaput dinding perut). Pada masa nifas peritonitis terjadi akibat menyebarnya atau meluasnya infeksi yang terjadi pada uterus melalui pembuluh darah limfe. Manifestasi klinisnya dapat terjadi peningkatan suhu tubuh, nyeri perut bagian bawah, nadi cepat dan kecil, perut kembung, muka pucat, mata cekung, kulit muka dan akral dingin.

6. Mastitis

Merupakan peradangan atau infeksi yang terjadi pada payudara atau mammae. Dalam masa nifas dapat terjadi infeksi dan peradangan pada mammae. Penyebab infeksi paling sering adalah staphylococcus aureus. Tanda dan gejalanya yaitu rasa panas dingin disertai dengan peningkatan suhu tubuh, lesu dan tidak ada nafsu makan, mammae membesar, kulit memerah dan nyeri pada perabaan.

7. Thrombophlebitis

Adalah penjaralan infeksi melalui vena. Hal ini terjadi pada masa nifas karena terbukanya vena-vena selama proses persalinan sehingga memudahkan mikroorganisme pathogen.

8. Infeksi luka perineum

Infeksi ini terjadi akibat masuknya mikroorganisme ke dalam luka perineum. Luka ini terjadi akibat episiotomi atau rupture/robek pada saat proses persalinan. Tanda dan gejalanya yaitu terasa nyeri, merah dan bengkak. Bila tidak segera ditangani akan melebar, terbuka dan mengeluarkan getah bening.

I. Tatalaksana Awal

1. Strategi Pengendalian Infeksi

- a. Gunakan teknik aseptik ketat ketika melakukan semua prosedur invasive (misalnya memasang jarum atau kateter intravena, melakukan pengisapan jalan napas, dan memasang kateter urine) dan ketika mengganti balutan bedah.
- b. Kelola jarum dan spuit secara berhati-hati untuk menghindari infeksi
- c. Ganti slang intravena dan wadah larutan sesuai kebijakan rumah sakit
- d. Cek tanggal kadaluwarsa dan keutuhan kemasan semua perlengkapan steril.
- e. Cegah infeksi selauran kemih dengan mempertahankan system drainase urine tertutup dengan aliran urine kearah bawah jangan melakukan irigasi kateter,

- kecuali diprogramkan, lakukan perawatan kateter teratur, dan pertahankan kantong drainase dan klep kantong drainase agar tidak menyentuh lantai
- f. Implementasikan tindakan untuk mencegah kerusakan integritas kulit dan mencegah akumulasi secret di paru.

2. Pencegahan Infeksi

- a. Mencuci tangan dengan cara dan waktu yang tepat , antara lain:
- 1) Sebelum kontak dengan pasien
 - 2) Sebelum tindakan aseptik
 - 3) Setelah terkena cairan tubuh pasien
 - 4) Setelah kontak dengan pasien
 - 5) Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien
- b. Menempatkan pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau pengidap yang berpotensi untuk menularkan penyakit di ruang isolasi.
- c. Menggunakan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti alat bantu nafas atau kateter urine, serta melakukan tindakan medis lainnya sesuai dengan indikasi.
- d. Mengikuti Standart Operasional Prosedur setiap melakukan Tindakan dengan menggunakan pelindung tangan standar (sarung tangan , masker, atau perlengkapan lainnya) yang dianjurkan.
- e. Menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit dengan menggunakan cairan pembersih atau desinfektan dengan frekuensi 2-3 kali per hari untuk lantai dan 2 minggu sekali untuk dinding.

Perawat mengajarkan klien dan anggota keluarga untuk :

- 1) Mencuci tangan sebelum mengolah makanan, sebelum makan, setelah berkemih, sebelum dan sesudah melakukan tindakan kebersihan rumah, dan setelah kontak dengan semua cairan tubuh.
- 2) Mempertahankan kuku jari tetap pendek, bersih dan terawat sehingga tidak terdapat ujung kuku kasar atau bintil kuku, yang dapat menjadi tempat berkembang baik mikroorganisme
- 3) Tidak berbagi alat-alat perawatan diri : sikat gigi, waslap, dan handuk
- 4) Mencuci buah dan sayuran mentah sebelum memakannya
- 5) Menyimpan semua makanan yang telah dibuka dan makanan yang tidak berkemasan di dalam lemari es
- 6) Membersihkan peralatan yang digunakan dengan sabun dan air, dan desinfeksi peralatan tersebut dengan larutan klorin
- 7) Meletakkan balutan yang telah terkontaminasi dan benda sekali pakai, lain yang mengandung cairan tubuh dalam kantong plastik kedap air

- 8) Membersihkan linen yang telah terkontaminasi secara terpisah dengan cucian lain. Merendamnya dalam air dingin, mencuci menggunakan air panas, jika mungkin dan menambahkan satu tutup botol pemutih dalam rendaman.
 - 9) Tidak batuk, bersin, atau menyemburkan napas langsung dihadapan orang lain serta menutup mulut dan hidung untuk mencegah penyebaran mikroorganisme
 - 10) Mewaspadai semua tanda dan gejala infeksi dan segera semua tanda dan gejala tersebut kepada pemberi pelayanan kesehatan
 - 11) Mempertahankan asupan cairan yang adekuat untuk meningkatkan produksi dan haluaran urine. Tindakan ini membasuh kandung kemih dan uretra dari mikroorganisme.
3. Perawatan Luka Perineum
- a. Cuci tangan dengan air mengalir. Berguna untuk mengurangi risiko infeksi dengan menghilangkan mikroorganisme.
 - b. Lepas pembalut yang digunakan dari depan ke belakang. Pembalut hendaknya diganti setiap 4-6 jam setiap sehari atau setiap berkemih, defekasi dan mandi. Bila pembalut yang dipakai ibu bukan pembalut habis pakai, pembalut dapat dipakai dengan dicuci dan dijemur dibawah sinar matahari.
 - c. Cebok dari arah depan ke belakang.
 - d. Mencuci daerah genital dengan air bersih atau matang dan sabun setiap kali habis BAK atau BAB.
 - e. Waslap dibasahi dan buat busa sabun lalu gosokkan perlahan waslap yang sudah ada busa sabun tersebut ke seluruh lokasi luka jahitan. Jangan takut dengan rasa nyeri, bila tidak dibersihkan dengan benar maka darah kotor akan menempel pada luka jahitan dan menjadi tempat kuman berkembang biak.
 - f. Bilas dengan air hangat dan ulangi sekali lagi sampai yakin bahwa luka benar – benar bersih. Bila perlu lihat dengan cermin kecil.
 - g. Keringkan dengan handuk kering atau tissue toilet dari depan ke belakang dengan cara ditepuk.
 - h. Kenakan pembalut baru yang bersih dan nyaman dan celana dalam yang bersih dari bahan katun. Pasang pembalut perineum baru dari depan ke belakang, jangan menyentuh bagian permukaan dalam pembalut
 - i. Cuci tangan dengan air mengalir. Berguna untuk mengurangi risiko infeksi dengan menghilangkan mikroorganisme.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis

Seorang perempuan, usia 28 tahun, P2A0, hari ke-4 postpartum, datang ke BPM dengan keluhan demam sejak 2 hari terakhir. Ibu juga mengeluh nyeri pada perut bagian bawah dan keluar cairan dari vagina yang berbau tidak sedap. Riwayat persalinan normal dengan ketuban pecah ± 18 jam sebelum persalinan. Hasil pemeriksaan didapatkan TD 110/70 mmHg, N 96 x/menit, P 20 x/menit, S 38,5°C, Uterus teraba lembek dan nyeri tekan, Lochia berbau, warna kecoklatan.

Pertanyaan diskusi :

1. Apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus di atas?
2. Jelaskan definisi dari kondisi tersebut!
3. Apa saja faktor risiko yang ditemukan pada kasus ini?
4. Jelaskan patofisiologi terjadinya kondisi tersebut!
5. Sebutkan tanda dan gejala khas yang mendukung diagnosis!
6. Pemeriksaan apa yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis?
7. Bagaimana tatalaksana awal yang dapat dilakukan oleh bidan?
8. Kapan pasien harus dirujuk? Jelaskan alasannya!
9. Edukasi apa yang harus diberikan kepada ibu dan keluarga?

SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Infeksi masa nifas
3	Kasus	Infeksi Luka Jahitan Post Partum, Tindakan awal
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam: Pencegahan Infeksi
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 21 tahun, P1A0, post partum 3 hari yang lalu datang ke Puskesmas PONED dengan keluhan nyeri pada luka pirenium, sulit duduk. Hasil anamnesis: Terdapat luka dan cairan dijahitan. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, N 104 x/menit, P 24 x/menit, S 36,8°C. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 3. Lakukan Pemeriksaan Kesehatan terkait kasus diatas.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta

No.	Komponen	Isi
		b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 3. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: PS berperan sebagai ibu post partum. PS tampak cemas, sesekali meringis memegang perut bawah, dan berbicara terputus saat nyeri datang. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.

No.	Komponen	Isi
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya merasakan nyeri di luka vagina. Peserta: Apakah luka berubah warna, berbau, bernanah? PS: Iya, Bu. Peserta: Apakah rutin membersihkan luka jahitan? PS: Rutin bu setelah mandi. Peserta: Saya akan melakukan pemeriksaan ya bu. PS: Iya, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Phantom panggul/ contoh luka robekan pirenium
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan lembar balik dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom panggul/serviks — 1 3. Kain penutup/selimut — 1 4. Alas dan Perlak — 1 5. Celana dalam — 1 6. Pembalut — 1 7. Kantong plastik — 1 8. Handscoon — 1 9. Botol cebok — 1 10. Pispot — 1

No.	Komponen	Isi
		11. Kapas — 1 12. Kassa Steril — 1 13. Betadine — 1 14. Bengkok — 1 15. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 16. Pena — 1
13	Penulis	Rizka Fatmawati, S.SiT., M.Kes., M.Keb
14	Referensi	Selvianti D, Widyaningsih S. (2022). Personal hygiene sebagai upaya pencegahan infeksi masa nifas. <i>Jurnal Midwifery</i>. Idyawati S, Afrida BR, Aryani NP, Annisa NH. (2022). Faktor penyebab infeksi masa nifas. <i>Jurnal Kesehatan</i>. Karlina E, Ciptiasrini U, Gaidha G. (2023). Efektivitas daun sirih terhadap penyembuhan luka perineum postpartum. <i>Jurnal Riset Kebidanan</i>. Suryani I, Sari F, Riyanti R, et al. (2024). Asuhan kebidanan masa nifas fisiologis untuk pencegahan infeksi. <i>VitaMedica</i>. Prawirohardjo S. (2018). <i>Ilmu Kebidanan</i>. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Ciselia D, Oktari V. (2021). <i>Asuhan Kebidanan Masa Nifas</i>. Surabaya: CV Jakad Media. Hidayat AAA. (2018). <i>Keterampilan Dasar Praktik Klinik Kebidanan</i>. Jakarta: Salemba Medika.

BAB 3

GANGGUAN ELIMINASI DAN KOMPLIKASI LAIN : RETENSI URINE, KONSTIPASI DAN HEMOROID

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab hukum dalam pemberian asuhan nifas dan menyusui.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi interprofesional dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam seluruh rangkaian pelayanan nifas–menyusui.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6
CPL-4	Melakukan clinical reasoning untuk mengkaji, menafsirkan, dan menyimpulkan status kesehatan ibu nifas dan menyusui.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan keterampilan asuhan nifas dan menyusui secara aman dan bermutu, termasuk stabilisasi awal dan rujukan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Menghasilkan dokumentasi asuhan, edukasi/konseling, dan penggunaan bukti ilmiah dasar untuk peningkatan mutu.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menganalisis konsep, ruang lingkup, standar, dan alur pelayanan asuhan nifas dan menyusui berbasis keselamatan pasien.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis–psikologis nifas dan fisiologi laktasi untuk menafsirkan parameter klinis.
CPMK-3	Merancang dan melaksanakan asuhan esensial segera setelah persalinan (kala IV) termasuk pencegahan perdarahan dan keselamatan ibu.
CPMK-4	Melaksanakan pemantauan nifas terjadwal serta manajemen masalah umum (perineum/luka, nyeri, eliminasi) dengan clinical reasoning.
CPMK-5	Mengoptimalkan menyusui melalui teknik menyusui, perlekatan efektif, konseling, dan pemecahan masalah laktasi umum.
CPMK-6	Mengidentifikasi dan melakukan tatalaksana awal komplikasi/kegawatdaruratan nifas (perdarahan, infeksi, kesehatan mental) serta menetapkan kriteria rujukan dan kolaborasi.
CPMK-7	Menyusun edukasi, rencana tindak lanjut, dan dokumentasi asuhan nifas–menyusui berbasis bukti dengan komunikasi terapeutik.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Gangguan Eliminasi dan Komplikasi Lain: Retensi Urine, Konstipasi, dan Hemoroid	3.1 Melakukan penatalaksanaan awal gangguan eliminasi (retensi urine, konstipasi, hemoroid) berdasarkan pengkajian.	3.2 Memantau respons, memberikan edukasi pencegahan, dan menentukan tindak lanjut bila tidak membaik.	CPMK-4	CPMK-7; CPMK-6

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	OSCE kunjungan nifas & perawatan; Laporan praktik mini-case	Pengkajian terjadwal dan deteksi dini risiko akurat ($\geq 85\%$ keputusan tepat); Teknik perawatan/perencanaan tindak lanjut sesuai SOP (error kritis = 0)	20	Checklist OSCE; laporan mini-case; catatan asuhan
CPMK-6	Simulasi skenario kegawatdaruratan; Ujian tulis skenario	Pengenalan tanda bahaya cepat dan tepat (≤ 2 menit pada simulasi); Stabilisasi awal sesuai prioritas dan aman; Keputusan rujukan/kolaborasi sesuai kriteria	15	Lembar penilaian simulasi; jawaban skenario
CPMK-7	Portofolio (dokumentasi & edukasi); Presentasi singkat	Dokumentasi lengkap-akurat-terstruktur ($\geq 90\%$ komponen); Materi edukasi jelas sesuai literasi; Menggunakan ≥ 2 sumber bukti ilmiah; Rencana tindak lanjut spesifik dan realistis	10	Portofolio; leaflet/lembar edukasi; slide/presentasi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Akurasi konsep/terminologi dan standar	Banyak konsep inti keliru; istilah tidak konsisten; standar tidak jelas.	Konsep dasar cukup benar namun ada kekeliruan penting; standar disebut terbatas.	Mayoritas konsep benar; kekeliruan minor; standar relevan digunakan.	Konsep sangat akurat; istilah konsisten; standar digunakan tepat dan menyeluruh.
1.2 Kesesuaian alur pelayanan dengan keselamatan pasien	Alur tidak runtut; langkah kritis keselamatan terlewat.	Alur cukup runtut namun ada langkah kritis yang belum lengkap.	Alur runtut; langkah kritis terpenuhi; risiko utama dikenali.	Alur runtut dan efisien; prioritas jelas; mitigasi risiko & eskalasi dirumuskan tepat.

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter fisiologis nifas & laktasi	Salah menafsirkan data; tidak dapat membedakan normal–abnormal.	Menafsirkan sebagian data namun ada salah simpulan pada temuan penting.	Menafsirkan data dengan benar; membedakan normal–abnormal dengan tepat.	Interpretasi sangat tepat; mengaitkan pola data dan prioritas masalah secara tajam.
2.2 Analisis perubahan emosi & faktor risiko psikologis	Tidak mengenali pola gejala; faktor risiko tidak relevan.	Mengenali gejala umum namun analisis risiko dangkal/tidak lengkap.	Analisis gejala dan risiko memadai; menyusun kebutuhan dukungan awal.	Analisis komprehensif; mempertimbangkan konteks keluarga/sosial; rekomendasi dukungan sangat tepat.

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Pengkajian kala IV dan penetapan status risiko	Pengkajian tidak lengkap; banyak data penting terlewat; risiko tidak tepat.	Pengkajian cukup namun masih ada data penting kurang; risiko sebagian tepat.	Pengkajian lengkap sesuai urutan; status risiko tepat.	Pengkajian sangat sistematis; cepat; risiko diprioritaskan dan dikomunikasikan jelas.
3.2 Intervensi pencegahan perdarahan & keselamatan ibu	Tindakan tidak sesuai prioritas; berisiko/menyalahi prosedur.	Tindakan sebagian tepat namun urutan/prioritas belum konsisten.	Tindakan tepat dan aman; prioritas sesuai protokol.	Tindakan sangat tepat; antisipasi komplikasi; koordinasi tim dan keselamatan optimal.

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Pengkajian kunjungan nifas & deteksi dini risiko	Pengkajian tidak terstruktur; tanda risiko sering terlewat.	Pengkajian cukup terstruktur namun deteksi risiko belum konsisten.	Pengkajian terstruktur; risiko terdeteksi tepat; keputusan tindak lanjut sesuai.	Pengkajian sangat komprehensif; mengaitkan tren; rencana tindak lanjut proaktif dan tepat.
4.2 Manajemen masalah umum (luka/nyeri/eliminasi) & rencana tindak lanjut	Intervensi tidak tepat/tidak aman; edukasi minim; tindak lanjut tidak jelas.	Intervensi cukup tepat namun rasional/edukasi kurang lengkap.	Intervensi tepat dan aman; edukasi memadai; tindak lanjut jelas.	Intervensi sangat tepat; personalisasi edukasi; evaluasi respons dan eskalasi direncanakan matang.

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Teknik menyusui & perlekatan efektif	Posisi/perlekatan salah; tidak dapat menunjukkan tanda efektif.	Posisi/perlekatan cukup namun masih ada kesalahan yang mengganggu efektivitas.	Posisi/perlekatan benar; menunjukkan tanda efektivitas menyusui.	Teknik sangat tepat; mampu mengoreksi kesalahan; evaluasi kecukupan menyusui sangat baik.
5.2 Konseling & pemecahan masalah laktasi	Tidak mampu mengidentifikasi penyebab; solusi tidak sesuai.	Identifikasi penyebab sebagian; solusi umum dan kurang spesifik.	Identifikasi penyebab tepat; solusi sesuai dan realistis; komunikasi empatik.	Analisis masalah tajam; solusi bertahap sesuai keparahan; dukungan/kolaborasi direncanakan optimal.

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi cepat komplikasi/kegawatdaruratan	Terlambat mengenali; salah menentukan prioritas; tanda bahaya terlewat.	Mengenali tanda bahaya utama namun belum cepat/kurang lengkap.	Mengenali tanda bahaya dengan cepat; prioritas masalah tepat.	Sangat cepat dan akurat; menilai derajat/keparahan secara sistematis.
6.2 Stabilisasi awal & keputusan rujukan/kolaborasi	Tindakan awal tidak sesuai/berisiko; rujukan tidak tepat.	Tindakan awal sebagian tepat; rujukan/kolaborasi belum jelas.	Stabilisasi awal tepat dan aman; rujukan/kolaborasi sesuai kriteria.	Stabilisasi sangat tepat; koordinasi tim efektif; rujukan disertai informasi klinis lengkap dan tepat waktu.

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Dokumentasi asuhan (lengkap, akurat, terstruktur)	Banyak komponen hilang; data tidak akurat; format tidak runtut.	Komponen utama ada namun masih kurang detail/ada inkonsistensi.	Dokumentasi lengkap dan akurat; format runtut; rencana jelas.	Dokumentasi sangat lengkap; analitis; mudah ditelusuri; mendukung kesinambungan asuhan.
7.2 Edukasi, rencana tindak lanjut, dan penggunaan bukti	Edukasi tidak jelas/tidak sesuai; tindak lanjut tidak spesifik; tanpa rujukan bukti.	Edukasi cukup jelas namun belum sesuai literasi; tindak lanjut umum; bukti minimal.	Edukasi jelas sesuai literasi; tindak lanjut spesifik; menggunakan bukti relevan.	Edukasi sangat jelas dan terpersonalisasi; tindak lanjut terukur; bukti kuat dan diintegrasikan tepat.

Pendahuluan

Masa nifas adalah masa pemulihan tubuh ibu setelah melahirkan, yang berlangsung sekitar enam minggu, di mana tubuh mengalami perubahan-perubahan untuk kembali seperti semula sebelum hamil. Pada masa ini, banyak terjadi gangguan yang mengganggu proses pengeluaran dan bisa memengaruhi kenyamanan serta kesehatan ibu. Beberapa gangguan yang terjadi saat proses eliminasi, seperti retensi urine, konstipasi dan Hemoroid sering dialami oleh orang-orang. Gangguan ini tidak hanya membuat tidak nyaman, tetapi juga bisa menyebabkan masalah yang lebih serius jika tidak diatasi dengan benar. Oleh karena itu, memahami berbagai faktor risiko, cara mencegah, serta tindakan penanganan yang lengkap sangat penting bagi para tenaga kesehatan, terutama bidan, dalam memberikan perawatan yang terbaik bagi ibu nifas. Pendekatan yang tepat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup ibu dan mencegah terjadinya masalah kesehatan yang lebih serius.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai definisi, faktor risiko, tanda dan gejala, serta penatalaksanaan gangguan eliminasi pada masa nifas. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tenaga kesehatan, khususnya bidan, mampu memberikan asuhan yang efektif, aman, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup ibu nifas.

Uraian Materi

A. Retensi Urine

Retensi urine pada masa nifas atau postpartum urinary retention (PPUR) merupakan salah satu gangguan berkemih yang dapat terjadi setelah proses persalinan. Kondisi ini berarti ibu tidak bisa mengosongkan kandung kemih sendirinya. Retensi urine pada masa nifas dapat terjadi baik pada persalinan normal maupun persalinan dengan tindakan, dan biasanya bersifat sementara, namun dalam beberapa kasus dapat menimbulkan komplikasi apabila tidak dikenali dan ditangani secara tepat.

Secara klinis, retensi urine setelah melahirkan didefinisikan sebagai kemampuan ibu yang tidak bisa berkemih sendiri dalam waktu 6 jam setelah melahirkan melalui vagina atau 6 jam setelah kateter dikeluarkan setelah melahirkan secara SC. Selain itu, retensi urine bisa terjadi jika ibu masih merasakan ada sisa urine yang banyak di dalam kandung kemih meski sudah berkemih. Sisa urine tersebut biasanya disebut *post-void residual urine* (PVR) dan dianggap jumlahnya mencapai 150 hingga 200 ml atau lebih. Kondisi ini dapat dideteksi melalui kateterisasi atau pemeriksaan menggunakan *bladder scan*.

Retensi urine pada masa nifas memerlukan perhatian khusus karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi jika tidak diatasi secara tepat. Kandung kemih yang terlalu penuh bisa menyebabkan pembengkakan yang lama dan mungkin merusak kemampuan otot detrusor bekerja. Selain itu, penahanan urine juga bisa membuat risiko infeksi saluran kemih meningkat karena urine yang tertumpuk di dalam kandung kemih. Oleh karena itu, pemantauan fungsi berkemih pada ibu setelah melahirkan merupakan bagian penting dalam perawatan masa nifas untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius.

1. Etiologi

Secara umum, penyebab terjadinya retensi urine masa nifas memiliki beberapa faktor, yaitu faktor mekanis, saraf, fungsi tubuh, serta faktor yang terkait dengan proses melahirkan. Proses persalinan yang terlalu lama, trauma pada jaringan panggul, penggunaan anestesi daerah tertentu, serta pembesaran kandung kemih selama melahirkan bisa menyebabkan gangguan pada kemampuan buang air kecil setelah melahirkan. Gangguan ini biasanya bersifat sementara, namun dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi gangguan berkemih yang lebih lama apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Salah satu penyebab utama retensi urine pada masa nifas adalah trauma jaringan panggul yang terjadi selama proses persalinan. Persalinan pervaginam dapat menyebabkan peregangan yang signifikan pada jaringan panggul, termasuk otot dasar panggul, uretra, dan kandung kemih. Peregangan tersebut terjadi karena tekanan kepala bayi yang melewati jalan lahir. Trauma ini bisa membuat jaringan di sekitar uretra dan kandung kemih mengembang atau membengkak, sehingga mengganggu aliran urine. Selain itu, tindakan obstetri seperti episiotomi dan terjadinya luka pada daerah perineum juga dapat meningkatkan risiko terjadinya retensi urine pada masa nifas. Nyeri yang muncul karena luka di daerah perineum sering membuat ibu merasa tidak nyaman sehingga menahan keinginan untuk berkemih. Akibatnya, kandung kemih menjadi penuh dan terjadi pembengkakan.

Selain kerusakan pada jaringan, gangguan pada saraf di daerah panggul juga merupakan penyebab penting dari keadaan sulit berkemih setelah melahirkan. Selama proses melahirkan, terutama jika prosesnya lama, kepala bayi dapat menekan dengan kuat saraf-saraf di daerah pinggul dan saraf pudendal. Tekanan tersebut dapat menyebabkan gangguan sementara pada fungsi saraf yang mengatur refleks miksi. Saraf pudendal berperan penting dalam mengatur otot siput uretra luar dan juga memberikan perasaan di bagian perineum. Jika saraf ini mengalami peregangan atau tekanan selama proses melahirkan, maka refleks berkemih bisa terganggu, sehingga ibu mengalami kesulitan untuk

mengosongkan kandung kemih secara normal setelah melahirkan. Kondisi ini umumnya hanya sementara, tapi bisa terjadi beberapa hari sampai fungsi saraf kembali seperti semula.

Pengaruh anestesi dan analgesia selama proses melahirkan juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan retensi urine setelah melahirkan. Anestesi regional seperti spinal atau epidural sering digunakan saat proses melahirkan untuk membuat ibu tidak merasa sakit. Namun, anestesi ini bisa membuat sensasi pada kandung kemih berkurang dan mengganggu refleks untuk membuang air kencing. Anestesi regional bekerja dengan menghambat transmisi impuls saraf pada daerah tertentu, termasuk saraf yang mengatur kontraksi otot detrusor dan sensasi kandung kemih. Akibatnya, ibu mungkin tidak merasa ingin buang air kencing meskipun kandung kemih sudah penuh. Kondisi ini bisa membuat kandung kemih terlalu mengembang jika tidak segera dibersihkan.

Faktor risiko lain yang sering terkait dengan retensi urine setelah melahirkan adalah persalinan pertama. Ibu yang pertama kali melahirkan memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kesulitan untuk mengeluarkan urine setelah melahirkan dibandingkan ibu yang sudah punya anak sebelumnya. Ini kemungkinan terkait dengan kelenturan jaringan panggul yang masih kaku dan waktu persalinan yang biasanya lebih lama pada ibu yang melahirkan pertama kali. Selain itu, bayi yang lahir dengan berat badan besar dapat memberi tekanan pada jaringan panggul selama proses persalinan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya trauma jaringan dan gangguan fungsi kandung kemih.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa rasa sakit setelah melahirkan bisa menyebabkan masalah mengeluarkan urine pada masa nifas. Nyeri di area perineum, khususnya episiotomi atau luka robek pada perineum, bisa membuat ibu merasa enggan untuk berkemih. Penundaan ini bisa membuat kandung kemih terlalu penuh, sehingga menyebabkan overdistensi. Selain itu, rasa takut atau merasa tidak nyaman saat berusaha berkemih bisa membuat ibu tidak mengosongkan kandung kemih secara maksimal.

Selain faktor-faktor itu, kemudahan bergerak yang tidak cukup setelah melahirkan juga bisa memperbesar kemungkinan terjadinya retensi urine setelah melahirkan. Mobilisasi dini setelah melahirkan dapat membantu meningkatkan fungsi kandung kemih serta merangsang refleks miksi. Sebaliknya, ibu yang terlalu lama berbaring di tempat tidur mungkin mengalami kesulitan untuk berkemih karena perubahan posisi tubuh dapat memengaruhi refleks berkemih.

2. faktor risiko

Retensi urine pada masa nifas atau postpartum urinary retention (PPUR) merupakan komplikasi yang sering terjadi setelah melahirkan, dengan penyebab yang bersifat multifaktor. Penelitian-penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa faktor-faktor risiko PPUR sangat berkaitan dengan kondisi ibu, cara proses persalinan, serta tindakan-tindakan yang dilakukan dalam bidang obstetric

Insiden retensi urine setelah melahirkan dilaporkan berada dalam rentang 1,7% hingga 17,9%, dan di Indonesia tercatat sekitar 14,8%. Hal ini membuat masalah ini menjadi cukup penting dalam pelayanan bidan. Retensi urine dapat terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang saling berkaitan, seperti faktor dari ibu, faktor selama proses kelahiran, serta faktor dari tindakan medis yang dilakukan.

a. Faktor Maternal (Karakteristik Ibu)

1) Usia Ibu

Usia merupakan faktor penting yang memengaruhi fungsi fisiologis sistem kemih. Ibu yang usianya terlalu muda atau terlalu tua memiliki kemungkinan lebih besar mengalami masalah saat membuang air kencing. Setelah usia 35 tahun, jaringan dan fungsi saraf mulai mengalami penurunan, termasuk saraf-saraf yang mengendalikan kontraksi kandung kemih. Hal ini menyebabkan proses berkemih menjadi kurang efektif. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa usia memiliki hubungan signifikan dengan terjadinya retensi urine.

2) Paritas

Paritas juga berpengaruh terhadap risiko retensi urine. Ibu primipara lebih rentan mengalami retensi urine karena kurangnya pengalaman dalam proses persalinan, sehingga rentan mengalami trauma jaringan dan kecemasan. Sebaliknya, multipara juga bisa mengalami risiko karena kelemahan otot dasar panggul yang terjadi setelah melahirkan beberapa kali. Penelitian menunjukkan bahwa masalah buang air kecil setelah melahirkan sering terjadi pada ibu yang sudah melahirkan lebih dari sekali, karena otot panggunya lemah.

3) kondisi psikologisnya.

Kecemasan, stres, dan rasa takut setelah melahirkan bisa mengganggu refleks untuk berkemih. Aktivitas sistem saraf simpatis meningkat, sehingga menyebabkan kontraksi kandung kemih menjadi lebih kuat dan menghambat relaksasi otot sfingter uretra.

b. Faktor Persalinan

1) Lama Persalinan (Partus Lama)

Persalinan yang berlangsung terlalu lama, terutama ketika masa persalinan pertama lebih dari 12 jam atau masa persalinan kedua terlalu panjang, merupakan faktor risiko utama terjadinya retensi urine. Tekanan kepala janin yang terus-menerus pada dasar panggul bisa menyebabkan:

- a) Edema jaringan perineum
- b) Trauma saraf pudendal
- c) Penurunan sensitivitas kandung kemih

2) Persalinan dengan Tindakan (Operatif)

Persalinan dengan menggunakan alat seperti vakum atau forceps dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami retensi urine. Hal ini disebabkan oleh:

- a) Trauma jaringan lunak
- b) Kerusakan saraf
- c) Nyeri perineum yang berat

Selain itu, tindakan operasi seperti sectio caesarea juga berkontribusi terhadap retensi urine akibat efek anestesi dan imobilisasi pasca operasi.

3) Berat Badan Bayi

Bayi yang lahir dengan berat lebih besar dari 3800 gram dapat memberi tekanan tambahan pada kandung kemih dan area panggul selama proses melahirkan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya cedera saraf dan masalah pada fungsi berkemih.

c. Faktor Trauma Jalan Lahir

1) Laserasi Perineum

Robekan di daerah perineum, baik yang terjadi sendiri maupun karena episiotomi, adalah faktor yang meningkatkan risiko terjadinya retensi urine. Nyeri yang muncul dapat menyebabkan ibu sulit untuk berkemih. Selain itu, trauma jaringan juga menyebabkan:

- a) Edema
- b) Gangguan refleks miksi
- c) Spasme otot dasar panggul

2) Episiotomi

Episiotomi bisa membuat ibu merasa sakit dan tidak nyaman, sehingga cenderung menunda untuk buang air kecil. Hal ini bisa membuat kandung kemih lebih mengembang dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penumpukan urine.

d. Faktor Neurologis dan Fisiologis

1) Trauma Saraf

Selama proses melahirkan, saraf yang mengatur kandung kemih bisa terkena tekanan atau cedera, terutama saraf pudendal. Trauma ini menyebabkan:

- a) Penurunan sensasi ingin berkemih
- b) Gangguan kontraksi detrusor

2) Perubahan Hormonal

Perubahan hormon setelah melahirkan dapat mengubah cara otot kandung kemih berfungsi. Penurunan hormon estrogen dapat menyebabkan:

- a) Penurunan kekuatan otot dasar panggul
- b) Gangguan kontrol berkemih

Selain itu, perubahan respons kontraktile kandung kemih juga berperan dalam terjadinya retensi urine.

e. Faktor Anestesi dan Tindakan Medis

1) Anestesi Epidural/Spinal

Penggunaan anestesi epidural atau spinal selama proses melahirkan bisa menghalangi refleks berkemih karena:

- a) Blokade saraf sensorik
- b) Penurunan kontraksi detrusor

Akibatnya, ibu tidak merasa ingin berkemih meskipun kandung kemihnya sudah penuh.

2) Kateterisasi

Penggunaan kateter selama persalinan atau operasi dapat menimbulkan:

- a) Penurunan sensitivitas kandung kemih
- b) Gangguan refleks berkemih setelah kateter dilepas

Jika tidak ada pemantauan, kondisi ini bisa berlanjut menjadi retensi urine.

f. Faktor Nyeri

Nyeri setelah melahirkan adalah salah satu penyebab utama yang menyebabkan keinginan untuk menahan kencing.

Nyeri dapat berasal dari:

- 1) Luka perineum
- 2) Episiotomi
- 3) Operasi caesar

Nyeri menyebabkan ibu:

- 1) Menahan berkemih
- 2) Mengurangi kontraksi kandung kemih
- 3) Menghambat relaksasi sfingter

g. Faktor Mobilisasi Dini

Kurangnya mobilisasi setelah melahirkan dapat meningkatkan risiko retensi urine.

Mobilisasi membantu:

- 1) Merangsang refleks berkemih
- 2) Meningkatkan sirkulasi darah
- 3) Mengurangi edema

h. Faktor Cairan dan Distensi Kandung Kemih

Keseimbangan cairan juga berperan penting. Penumpukan urine di dalam kandung kemih tanpa dibuang dapat menyebabkan:

- 1) Overdistensi kandung kemih
- 2) Penurunan kontraktilitas otot detrusor

i. Faktor Infeksi dan Komplikasi

Infeksi saluran kemih bisa membuat kandung kemih terinflamasi, sehingga proses berkemih menjadi tidak nyaman. Selain itu, retensi urine yang tidak diatasi juga dapat memperparah risiko infeksi.

3. Patofisiologi dan Tanda Gejala

Secara fisiologis, proses berkemih (miksi) merupakan hasil koordinasi kompleks antara sistem saraf pusat, saraf perifer, otot detrusor kandung kemih, serta sfingter uretra internal dan eksternal. Dalam kondisi biasa, proses pengisian kandung kemih diatur oleh saraf simpatis yang membuat otot detrusor rileks dan otot sfingter uretra mengkerut, sehingga urine bisa tersimpan di dalam kandung kemih. Sebaliknya, fase pengosongan dikendalikan oleh sistem saraf parasimpatis yang memicu otot detrusor berkontraksi dan otot sfingter rileks, sehingga urine bisa dikeluarkan dengan baik. Gangguan pada satu atau beberapa komponen tersebut akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam mekanisme miksi dan akhirnya menyebabkan penumpukan urine.

Patofisiologi retensi urine pada masa nifas bersifat multifaktorial dan melibatkan interaksi antara faktor mekanik, neurologis, hormonal, dan psikologis. Salah satu mekanisme utama adalah gangguan kemampuan otot detrusor untuk berkontraksi. Selama proses melahirkan, khususnya pada melahirkan yang sudah lama berlangsung, kandung kemih bisa mengalami peregangan berlebih karena urine menumpuk dan tidak segera dikeluarkan. Overdistensi ini menyebabkan peregangan serabut otot detrusor sehingga menurunkan kemampuan kontraksinya. Selain itu, peregangan berlebihan juga dapat mengurangi sensitivitas reseptor regangan pada dinding kandung kemih, sehingga ibu tidak merasa ingin berkemih meskipun volume urine sudah tinggi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan kemampuan otot detrusor untuk berkontraksi

adalah salah satu penyebab utama terjadinya penahanan urine setelah melahirkan, khususnya pada ibu yang melahirkan dengan durasi persalinan yang lama atau menggunakan anestesi regional

Gejala klinis pada retensi urine dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan jenis retensi yang dialami. Pada retensi urine akut, gejala yang paling umum adalah tidak bisa berkemih dalam jangka waktu tertentu setelah melahirkan, biasanya lebih dari 6 jam. Ibu akan merasakan sakit di area di atas kemaluan karena kandung kemih mengembang. Kandungan air seni yang penuh dapat dirasakan sebagai beban di daerah perut bawah, dan sering disertai rasa tidak nyaman atau tekanan yang kuat. Selain itu, ibu mungkin merasa perlu buang air kecil, tetapi tidak bisa mengeluarkan urine. Kondisi ini adalah situasi darurat yang perlu ditangani segera agar tidak terjadi masalah lebih serius.

Secara umum, proses penyebabnya terjadinya penumpukan urine setelah melahirkan terjadi karena adanya interaksi yang rumit antara kelainan kemampuan otot dinding kandung kemih untuk berkontraksi, kerusakan saraf, pembengkakan jaringan, pengaruh anestesi, perubahan hormon, serta faktor psikologis. Gejala klinis dapat berupa kesulitan berkemih, pembengkakan kandung kemih, nyeri di daerah suprapubik, hingga gangguan fungsi berkemih yang sering tidak terdeteksi. Memahami dengan baik mekanisme dan tanda-tanda retensi urine sangat penting bagi para tenaga kesehatan agar bisa mendeteksi lebih awal dan memberikan penanganan yang tepat, sehingga mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat pada ibu yang baru melahirkan.

4. Klasifikasi

Dari segi klinis, retensi urine setelah melahirkan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan gejala yang muncul dan tingkat keparahannya. Klasifikasi ini penting untuk menentukan diagnosa dan penanganan yang tepat.

a. Retensi Urine Overt (Retensi Nyata / Akut)

Retensi urine overt adalah kondisi di mana ibu tidak dapat berkemih sama sekali dalam jangka tertentu setelah melahirkan. Secara umum, kondisi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk berkemih yang terganggu selama ≥ 6 jam setelah persalinan normal atau setelah dilepasnya kateter pada persalinan dengan tindakan.

Pada situasi ini, kandung kemih mengalami pembesaran yang nyata dan bisa terasa saat melakukan pemeriksaan fisik. Ibu sering merasa nyeri di bagian atas perut bawah, merasa penuh di perut bagian bawah, dan terus menerus menginginkan ke kamar kecil, tetapi tidak bisa berkemih. Retensi urine overt adalah jenis yang paling mudah terlihat karena gejalanya jelas dan biasanya menyebabkan ketidaknyamanan yang cukup berarti.

b. Retensi Urine Covert (Retensi Tersembunyi / Subklinis)

Retensi urine covert adalah kondisi di mana ibu masih mampu berkemih secara spontan, namun tidak dapat mengosongkan kandung kemih secara tuntas. Kondisi ini biasanya didiagnosis dengan adanya residu urine (sisa urine) $\geq 150\text{--}200$ ml setelah berkemih, yang diukur menggunakan kateterisasi atau ultrasonografi. Retensi jenis ini biasanya tidak diperhatikan karena tidak menyebabkan gejala yang terlihat. Ibu mungkin hanya merasakan:

- 1) Berkemih tidak tuntas
- 2) Frekuensi berkemih meningkat
- 3) Pancaran urine lemah

Meskipun gejalanya tidak terlalu berat, retensi covert tetap bisa berbahaya karena bisa berkembang menjadi retensi yang berlangsung lama atau menyebabkan infeksi pada saluran kemih jika tidak segera ditangani.

5. pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang dalam kasus retensi urine bertujuan untuk mengetahui penyebabnya, membedakan apakah retensi tersebut bersifat akut atau kronis, serta menemukan penyebab yang sebenarnya. Selain itu, pemeriksaan ini juga penting untuk menilai tingkat keparahan dan mencegah komplikasi lebih lanjut seperti infeksi saluran kemih atau gangguan fungsi ginjal. Dalam kasus retensi urine, terutama pada ibu yang baru melahirkan, pemeriksaan tambahan dilakukan setelah proses wawancara dan pemeriksaan fisik menunjukkan keraguan adanya kesulitan dalam berkemih.

a. Residual Urine (post-void residual/PVR).

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak urine yang masih tertinggal di dalam kandung kemih setelah pasien selesai buang air kecil. Pengukuran PVR dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu kateterisasi dan ultrasonografi (USG) kandung kemih. Kateterisasi dianggap cara yang paling tepat karena urine keluar langsung dan volume urine bisa diukur dengan jelas. Namun, metode ini dianggap invasif dan bisa berisiko menyebabkan infeksi. Oleh karena itu, USG kandung kemih lebih sering digunakan karena cara pemeriksaannya tidak menyakitkan, aman, dan bisa dilakukan berkali-kali. Nilai residual $\geq 150\text{--}200$ ml umumnya menunjukkan adanya retensi urin yang signifikan.

b. Ultrasonografi (USG)

Sistem urinaria juga dipakai untuk mengetahui kondisi struktur kandung kemih, ureter, dan ginjal. Pemeriksaan ini bisa menemukan adanya perbesaran kandung kemih, penipisan dinding kandung kemih, serta masalah lain seperti hidronefrosis yang disebabkan oleh tekanan balik urin ke ginjal. Pada ibu

postpartum, USG juga membantu menilai adanya faktor mekanik seperti sisa pembesaran uterus yang menekan kandung kemih.

c. Uroflowmetri

yaitu pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui cara dan kecepatan aliran urine saat seseorang berkemih. Uroflowmetri dapat memberikan informasi mengenai kekuatan kontraksi otot dinding kandung kemih dan adanya hambatan pada saluran kemih. Dalam proses penahanan urine, hasil uroflowmetri sering kali menunjukkan aliran urine yang tidak kuat atau terputus-putus. Pemeriksaan ini tidak menyakitkan dan sering digunakan sebagai pemeriksaan awal untuk mendeteksi gangguan berkemih.

d. Urodinamik

yang merupakan pemeriksaan lanjutan untuk mengevaluasi fungsi kandung kemih dan uretra secara menyeluruh. Pemeriksaan ini mencakup pengukuran tekanan pada kandung kemih, kemampuan kandung kemih untuk menampung urine, serta keharmonisan kerja antara otot detrusor dan sfingter uretra. Urodinamik biasanya dilakukan jika seseorang mengalami kesulitan buang air kecil yang berlangsung lama atau terus-menerus, agar dapat menemukan penyebab yang lebih jelas, seperti gangguan saraf atau masalah pada otot detrusor.

e. Urinalisis

Pemeriksaan ini juga penting dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi saluran kemih yang sering menjadi komplikasi dari retensi urine. Dalam pemeriksaan urin, bisa ditemukan leukosit, nitrit, atau bakteri yang menunjukkan terjadinya infeksi. Jika diperlukan, proses dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan urine untuk mengetahui jenis bakteri yang menyebabkan infeksi serta tingkat respons bakteri terhadap antibiotik.

f. Pemeriksaan fungsi ginjal

Pemeriksaan ini seperti kadar ureum dan kreatinin dalam darah dapat dilakukan, terutama pada kasus retensi urine yang berlangsung lama. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada gangguan pada fungsi ginjal yang disebabkan oleh tekanan yang terjadi karena kandung kemih yang penuh.

6. komplikasi

Retensi urine setelah melahirkan merupakan kondisi yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius apabila tidak segera ditangani. Kondisi ini terjadi karena kandung kemih tidak bisa mengosongkan urine dengan baik, sehingga urine terus berada di dalam kandung kemih dan tekanan di dalamnya semakin meningkat. Pada ibu yang sedang periode pasca melahirkan, komplikasi

ini tidak hanya mengganggu sistem kemih, tetapi juga bisa menghambat proses penyembuhan dan mengurangi kualitas hidup ibu secara menyeluruh.

Salah satu komplikasi utama adalah infeksi saluran kemih (ISK). Penyimpanan urine terlalu lama menyebabkan urine stagnan di dalam kandung kemih, yang menjadi tempat yang cocok bagi pertumbuhan bakteri. Akibatnya, bakteri bisa tumbuh dan menyebabkan infeksi pada kandung kemih, yaitu sistitis, serta bisa menyebar ke ginjal, yang disebut pielonefritis.

Komplikasi selanjutnya adalah overdistensi kandung kemih. Kandung kemih yang selalu berisi tanpa dibuang akan mengalami peregangan yang berlebihan. Kondisi ini bisa merusak otot detrusor, sehingga membuat otot tersebut kurang mampu berkontraksi dengan baik saat kandung kemih perlu dikeluarkan. Akibatnya, ibu dapat mengalami gangguan berkemih yang menetap bahkan setelah masa nifas.

Selain itu, retensi urine juga dapat menyebabkan inkontinensia urine tipe overflow. Kondisi ini terjadi ketika kandung kemih terlalu penuh, sehingga tekanan di dalam kandung kemih meningkat dan membuat urine keluar tanpa bisa dikontrol. Meskipun terlihat seperti masalah inkontinensia biasa, kondisi ini justru menunjukkan adanya retensi urine yang belum didiagnosis.

Komplikasi yang lebih parah adalah gangguan pada fungsi ginjal. Tekanan yang terlalu tinggi di dalam kandung kemih bisa menyebabkan urine mengalir kembali ke ureter dan ginjal, kondisi ini disebut refluks vesikoureter. Hal ini dapat menyebabkan hidronefrosis, yaitu pelebaran pelvis ginjal akibat penumpukan urine. Jika kondisi ini terus berlangsung, bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal dan akhirnya memicu terjadinya gagal ginjal.

Selain komplikasi fisik, retensi urine postpartum juga dapat menimbulkan gangguan psikologis. Ibu yang kesulitan untuk berkemih biasanya merasa sakit, tidak nyaman, serta cemas. Kondisi ini dapat menghambat mobilisasi dini, memperlambat proses pemulihan, serta memengaruhi kemampuan ibu dalam merawat bayi. Dalam beberapa situasi, retensi urine yang terus-menerus bisa menyebabkan masalah pada fungsi kandung kemih yang terus-menerus, sehingga dibutuhkan penanganan seperti penggunaan kateter secara berkala atau terapi penguatan otot kandung kemih.

7. penatalaksanaan

Kondisi urine yang tertahan pada masa nifas atau postpartum urinary retention (PPUR) memerlukan penanganan yang cepat dan benar agar bisa mencegah terjadinya komplikasi seperti infeksi saluran kemih dan kerusakan pada kandung kemih. Penanganan retensi urine setelah melahirkan umumnya mencakup pendekatan tanpa obat, penggunaan obat, serta tindakan invasif jika

diperlukan, dengan tujuan utama untuk memulihkan fungsi berkemih secara normal.

Langkah pertama dalam penanganan adalah mendeteksi sejak dini dan mengamati fungsi berkemih. Tenaga kesehatan harus memastikan apakah ibu bisa berkemih sendiri dalam waktu sekitar 6 jam setelah melahirkan. Jika ibu belum bisa berkemih, dilakukan pemeriksaan terhadap kandung kemih dengan cara disentuh atau menggunakan alat seperti USG untuk mengetahui apakah kandung kemih membesar. Deteksi dini sangat penting agar terhindar dari overdistensi yang bisa merusak otot detrusor.

Jika ibu tidak bisa buang air kecil sendiri, langkah utama yang dilakukan adalah memasukkan kateter ke dalam kandung kemih. Kateterisasi bisa dilakukan sementara atau permanen (kateter tetap) sesuai dengan keadaan pasien. Tindakan ini dilakukan agar kandung kemih tidak terlalu penuh dan menghindari terjadinya pembengkakan yang berlebihan. Selain itu, kateterisasi juga sering dijalankan bersamaan dengan pengukuran volume urine untuk mengevaluasi fungsi kandung kemih. Selain metode invasif, pengelolaannya juga mencakup terapi yang tidak menggunakan obat. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah latihan kebiasaan buang air kecil, yaitu cara untuk memulihkan pola buang air kecil yang normal. Latihan mengosongkan kandung kemih dilakukan dengan cara mengajak ibu untuk buang air kecil secara teratur, misalnya setiap 2 hingga 3 jam, serta memberikan rangsangan seperti suara air mengalir atau kompres hangat di area suprapubik. Metode ini sudah terbukti bisa membantu meningkatkan refleks miksi dan mempercepat proses pemulihan fungsi kandung kemih.

Intervensi non-farmakologis lainnya meliputi pemeriksaan dini dan latihan otot panggul dasar seperti senam Kegel. Mobilisasi segera setelah melahirkan bisa membantu membangun kembali fungsi kandung kemih dan meningkatkan aliran darah di daerah panggul. Latihan Kegel bertujuan untuk memperkuat otot-otot di bagian bawah panggul agar dapat mendukung proses berkemih secara normal. Latihan ini juga membantu mencegah masalah buang air kecil selama masa nifas.

Dalam beberapa situasi, pengobatan juga bisa mencakup penggunaan obat-obatan. Obat-obatan seperti parasimpatomimetik bisa diberikan untuk memicu otot detrusor berkontraksi, sedangkan antibiotik digunakan jika ada gejala infeksi saluran kemih. Selain itu, dianjurkan untuk memberikan cairan secukupnya (sekitar 2–3 liter per hari) agar dapat membantu menghasilkan urine dan menjaga kinerja ginjal tetap baik.

Penanganan yang menyeluruh juga meliputi memberikan pendidikan kepada ibu. Ibu perlu tahu pentingnya buang air kecil secara teratur setelah melahirkan, jangan menahan diri untuk buang air kecil, dan selalu menjaga kebersihan bagian genital agar tidak terjadi infeksi. Edukasi ini penting agar ibu lebih memahami dan mengikuti terapi dengan baik, sehingga bisa mencegah terjadinya kekambuhan.

Secara umum, penanganan retensi urine setelah melahirkan mencakup beberapa cara seperti pengamatan, penggunaan kateter, serta pengobatan tanpa obat dan dengan obat. Pendekatan yang tepat dan tepat waktu sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi serta membantu mempercepat proses pemulihan fungsi kandung kemih. Dengan penanganan yang tepat, kebanyakan kasus retensi urine yang terjadi saat masa nifas bisa sembuh dalam beberapa hari dan tidak menyebabkan masalah dalam jangka waktu yang lama.

8. Asuhan kebidanan

Asuhan kebidanan untuk mencegah retensi urine setelah melahirkan adalah upaya yang mencakup berbagai langkah untuk membantu ibu yang baru melahirkan kembali memiliki fungsi berkemih secara normal dan menghindari terjadinya masalah kesehatan yang mungkin terjadi. Asuhan kebidanan dilakukan dengan pendekatan manajemen Varney dan dicatat menggunakan format SOAP/SOAPIE. Pada tahap pemeriksaan, bidan mengumpulkan informasi dari pasien (Subjective (S)), seperti keluhan tidak bisa berkemih, perasaan terasa penuh di bagian bawah perut, dan rasa sakit. Data objektif (O) mencakup kandung kemih yang teraba penuh, nyeri saat tekan di daerah suprapubik, serta adanya penurunan atau tidak adanya keluarnya urine. Pemeriksaan juga meliputi pengukuran tanda vital dan kondisi rahim untuk mencegah terjadinya komplikasi.

Berdasarkan data tersebut, ditegakkan diagnosis kebidanan (*Assessment* (A)), yaitu ibu nifas dengan retensi urine. Bidan juga harus mempersiapkan kemungkinan diagnosa seperti infeksi saluran kemih, atonia rahim, dan gangguan kerja kandung kemih.

Dalam bagian Planning (P), ditulis rencana tindakan yang akan dikerjakan, termasuk intervensi nonfarmakologis dan yang dilakukan bersama. Intervensi nonfarmakologis meliputi peregangan dini, kompres hangat, peningkatan minum cairan, serta latihan kandung kemih untuk membangkitkan refleks berkemih. Jika diperlukan, dilakukan kateterisasi urin secara bersama-sama dengan tujuan untuk mengosongkan kandung kemih.

Tahap implementasi (I) dilakukan sesuai dengan rencana, misalnya membantu ibu dalam posisi berkemih yang nyaman, mengamati jumlah dan warna urine, serta melakukan kateterisasi jika diperlukan. Bidan juga mengamati

kontraksi rahim dan perdarahan setelah melahirkan agar dapat mencegah masalah yang lebih parah.

Pada fase evaluasi (E), tanda keberhasilan asuhan adalah ibu dapat berkemih secara spontan, tidak ada pembengkakan pada kandung kemih, serta tidak ada gejala infeksi atau komplikasi lainnya. Asuhan yang tepat dan cepat terbukti efektif dalam menangani retensi urine dan membantu ibu nifas pulih lebih cepat. Oleh karena itu, pelayanan kebidanan harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan didasarkan pada bukti ilmiah agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu setelah melahirkan.

9. Red flags & rujukan

Tanda-tanda bahaya serta penanganan masalah retensi urine setelah melahirkan merupakan hal penting dalam pelayanan kebidanan karena kondisi ini bisa menjadi komplikasi berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat.

a. Red Flags Retensi Urine Postpartum

Beberapa gejala bahaya yang perlu diwaspadai pada ibu yang sedang menyusui dan mengalami retensi urine meliputi:

1) Tidak dapat berkemih > 6–8 jam postpartum

Ini adalah tanda penting yang menunjukkan adanya retensi urine, dan memerlukan pengecekan segera karena kandung kemih yang penuh bisa mengganggu gerakan otot rahim.

2) Distensi kandung kemih (bladder penuh)

Teraba penuh saat diperiksa di daerah suprapubik dan disertai rasa nyeri saat tekan. Kondisi ini bisa menyebabkan rahim tidak berkontraksi dengan baik dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pendarahan setelah melahirkan.

3) Nyeri hebat pada perut bawah/suprapubik

Menunjukkan tekanan berlebih di kandung kemih karena penumpukan urine.

4) Tidak ada atau hampir tidak ada air kencing yang dikeluarkan oleh tubuh (oliguria atau anuria).

Menunjukkan gangguan dalam proses buang air kecil yang serius dan bisa menyebabkan kerusakan pada kandung kemih.

5) Tanda infeksi saluran kemih

Seperti gejala demam, urine yang keruh atau berbau, serta nyeri saat buang air kecil. Retensi urine yang tidak diatasi bisa meningkatkan kemungkinan terkena infeksi.

6) Gangguan involusi uterus

Kandung kemih yang penuh bisa menekan rahim, sehingga menyulitkan kontraksi rahim dan meningkatkan risiko perdarahan setelah melahirkan.

7) Retensi urine persisten (>24–48 jam)

Menunjukkan gangguan pada fungsi kandung kemih yang lebih parah dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

b. Kriteria dan Indikasi Rujukan

Rujukan harus dilakukan segera jika kondisi sebagai berikut:

- 1) Ibu tidak bisa berkemih setelah dilakukan langkah-langkah awal seperti pemindahan posisi, kompres hangat, dan pelatihan kandung kemih (bladder training).
- 2) Distensi kandung kemih berat dan nyeri hebat
- 3) Volume urine yang tidak normal disertai gejala infeksi seperti demam, nyeri, atau urine yang tidak biasa.
- 4) Terjadi masalah seperti perdarahan setelah melahirkan atau kelemahan rahim setelah melahirkan.
- 5) Retensi urine menetap atau berulang setelah kateterisasi
- 6) Dicurigai adanya gangguan saraf atau luka pada saluran kemih yang disebabkan oleh proses melahirkan.

c. Prinsip Rujukan

Dalam melakukan rujukan, bidan harus memperhatikan prinsip berikut:

- 1) Stabilisasi kondisi ibu dengan mengosongkan kandung kemih menggunakan kateter jika diperlukan.
- 2) Komunikasi efektif dengan fasilitas rujukan
- 3) Pendokumentasian lengkap (SOAP)
- 4) Pendampingan selama rujukan untuk mencegah komplikasi
- 5) Penanganan di fasilitas rujukan umumnya mencakup pemeriksaan tambahan seperti USG, pengecekan residu urine, serta terapi medis atau tindakan urologi jika diperlukan.

B. Konstipasi

Konstipasi setelah melahirkan, atau yang disebut juga konstipasi postpartum, adalah salah satu masalah pada sistem pencernaan yang sering dialami oleh ibu selama masa nifas. Kondisi ini ditunjukkan dengan sulitnya buang air besar, frekuensi buang air besar berkurang, serta perubahan tekstur tinja menjadi lebih keras dan kering, sehingga proses keluarnya tinja terasa tidak nyaman atau bahkan menyakitkan. Secara umum, konstipasi pada ibu yang sedang menyusui

didefinisikan sebagai kebiasaan BAB kurang dari tiga kali dalam seminggu dan disertai sulitnya mengeluarkan feses.

Pada masa nifas, konstipasi sering terjadi dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan. Ini berhubungan dengan perubahan di tubuh, pikiran, serta kondisi fisik ibu setelah melahirkan. Beberapa ibu mengalami buang air besar yang tertunda hingga lebih dari tiga hari setelah melahirkan, yang menunjukkan adanya masalah pada fungsi usus yang membutuhkan perhatian. Selain itu, tanda konstipasi juga bisa berupa perasaan belum selesai setelah buang air besar, usaha mengejan yang terlalu keras, serta rasa tidak nyaman di perut.

Konstipasi yang terjadi masa nifas bukanlah penyakit yang muncul sendiri, melainkan kondisi yang terjadi karena fungsi tubuh yang tidak normal, dan bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Secara fisiologis, setelah melahirkan terjadi penurunan kekuatan otot usus karena kelelahan selama proses melahirkan dan perubahan hormon yang terjadi. Selain itu, hormon progesteron yang masih berpengaruh selama kehamilan dapat membuat otot usus bekerja lebih lambat, sehingga menyebabkan feses menumpuk di dalam kolon. Kondisi ini semakin memburuk karena adanya rasa sakit di area perineum akibat episiotomi atau luka sobek, sehingga ibu merasa takut untuk mengejan saat buang air besar.

1. Etiologi dan Faktor Resiko

Konstipasi setelah melahirkan atau disebut juga konstipasi postpartum adalah kondisi yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor fisiologis, mekanik, farmakologis, dan psikologis yang terjadi selama masa kehamilan dan terus berlanjut hingga masa nifas. Penelitian internasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kombinasi beberapa faktor dapat menyebabkan pergerakan usus berkurang dan mengganggu proses buang air besar.

Salah satu alasan utama adalah perubahan hormon, terutama karena pengaruh hormon progesteron yang masih tinggi di awal masa nifas. Progesteron dapat membuat otot polos, termasuk otot usus, menjadi lebih rileks, sehingga mengurangi gerakan peristaltik usus. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk melewati feses di kolon menjadi lebih lama, sehingga air kembali diserap oleh kolon dan feses menjadi keras serta sulit dikeluarkan. Kondisi ini adalah mekanisme alami tubuh yang menjelaskan mengapa sembelit sering terjadi terus-menerus dari masa kehamilan sampai setelah melahirkan.

Faktor lain yang dapat menyebabkan konstipasi diantaranya:

a. rasa sakit dan cedera

Rasa sakit dan cedera diarea perineum akibat episiotomi, luka sobek, atau proses melahirkan secara vagina juga memainkan peran penting. Rasa sakit saat duduk atau mengejan membuat ibu enggan buang air besar karena takut

lukanya terbuka atau jadi lebih buruk. Penundaan buang air besar ini membuat tinja menjadi lebih keras dan memperparah sembelit. Nyeri yang disebabkan oleh hemoroid yang sering terjadi setelah melahirkan bisa menjadi faktor tambahan yang memperburuk kondisi tersebut.

b. Penggunaan obat-obatan selama proses melahirkan,

Penggunaan obat – obatan tersebut terutama analgesik dan opioid. Obat-obatan ini bisa membuat gerak usus melambat karena mengganggu kerja saraf di usus, sehingga proses buang air besar memakan waktu lebih lama dan mungkin menyebabkan sulit buang air besar. Selain itu, obat-obatan lain seperti suplemen zat besi yang biasa diberikan kepada ibu yang telah melahirkan juga membuat tinja menjadi lebih kering.

c. Dehidrasi dan perubahan cara makan

Selama proses melahirkan, ibu biasanya terbatas dalam mengonsumsi minuman dan makanan, terutama saat proses melahirkan yang berlangsung lama. Kondisi ini membuat tubuh kekurangan cairan, sehingga tinja menjadi lebih kering dan sulit untuk dikeluarkan. Selain itu, kurangnya asupan serat setelah melahirkan juga bisa memperparah masalah sembelit.

d. Lemahnya otot di dasar panggul dan perubahan struktur tubuh setelah melahirkan.

Selama melahirkan, otot levator ani dan struktur panggul bisa meregang atau cidera, sehingga mengganggu kerja sama otot saat buang air besar.

e. Kurangnya bergerak (aktivitas fisik)

Ibu yang baru melahirkan sering merasa lelah dan dianjurkan untuk istirahat cukup, sehingga membuat aktivitas fisiknya terbatas. Penurunan aktivitas ini bisa menyebabkan usus bergerak lebih lambat dan meningkatkan kemungkinan terjadinya sembelit.

f. Faktor psikologis

Perasaan cemas, stres, atau tidak nyaman setelah melahirkan bisa membuat kebiasaan buang air besar berubah. Beberapa ibu merasa takut untuk mengejan karena takut sakit atau luka jahitan rusak, sehingga menunda buang air besar.

2. Patofisiologi

Konstipasi setelah melahirkan terjadi karena berbagai perubahan dalam tubuh seperti perubahan fisiologis, hormonal, dan mekanik yang memengaruhi cara kerja sistem pencernaan secara normal. Dari segi penyebabnya, konstipasi terjadi karena usus bergerak lebih lambat, kolon menyerap lebih banyak air, dan ada hambatan saat proses BAB terjadi.

Setelah melahirkan, tubuh ibu masih terpengaruh oleh hormon progesteron yang meningkat selama masa kehamilan. Progesteron membuat otot polos, termasuk otot usus, lebih rileks sehingga menyebabkan usus bergerak lebih lambat. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan feses untuk berada di dalam kolon menjadi lebih lama. Feses yang tinggal terlalu lama di kolon akan menyerap air berlebihan, sehingga menjadi kering dan sulit dikeluarkan.

Selain karena hormon, kelelahan tubuh setelah melahirkan juga membuat otot usus menjadi kendor. Penurunan tonus ini membuat kontraksi usus tidak bekerja dengan baik dalam mendorong tinja menuju rektum. Di sisi lain, perubahan mekanik pada dasar panggul yang terjadi karena proses melahirkan, seperti tarikan atau kerusakan pada otot levator ani, bisa mengganggu kerja sama dalam proses BAB. Hal ini membuat sulit bagi sfingter ani untuk rileks saat proses buang air besar terjadi.

3. Klasifikasi

Konstipasi setelah melahirkan umumnya dibagi berdasarkan mekanisme penyebabnya dan ciri-ciri gangguan buang air besar. Konstipasi Fungsional (Functional Constipation) diantaranya:

a. Konstipasi fungsional

Pada ibu yang sedang nifas, konstipasi seperti ini umumnya disebabkan oleh perubahan hormon, kurangnya gerak tubuh, dan konsumsi serat serta cairan yang tidak cukup. Gejalanya mencakup frekuensi buang air besar yang berkurang, tinja kering, serta kesulitan saat BAB.

b. Konstipasi Transit Lambat (Slow Transit Constipation)

Jenis ini terjadi karena gerakan buang air besar di dalam usus lambung menjadi lebih lambat. Pada masa nifas, kondisi ini terjadi karena pengaruh hormon progesteron yang membuat otot polos usus rileks, sehingga kemampuan usus untuk bergerak berkurang. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk melewati feses di saluran pencernaan menjadi lebih lama, sehingga lebih banyak air diserap dan feses menjadi kering dan sulit dikeluarkan. Tipe konstipasi ini biasanya ditunjukkan dengan frekuensi BAB yang sedikit dan tidak ada dorongan yang kuat untuk BAB.

c. Konstipasi Tipe Outlet atau Gangguan Evakuasi (Evakuasi Terhambat)

Konstipasi jenis ini terjadi karena gangguan pada proses keluarnya tinja dari rektum. Setelah melahirkan, ibu sering mengalami kondisi ini karena trauma yang terjadi saat persalinan, seperti tarikan atau cedera pada otot dasar panggul serta sfingter ani.

d. Konstipasi Sekunder

Konstipasi sekunder adalah konstipasi yang terjadi karena faktor di luar tubuh atau karena adanya kondisi kesehatan tertentu. Pada ibu yang sedang nifas, faktor-faktor yang sering memengaruhi antara lain penggunaan obat-obatan seperti analgesik opioid dan suplemen zat besi, kekurangan cairan atau dehidrasi, serta kebiasaan makan yang tidak sehat.

4. Tanda-gejala

Tanda dan gejala konstipasi yang dialami ibu setelah melahirkan antara lain:

a. Frekuensi BAB berkurang

Ibu mengalami BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu atau tidak BAB selama 2–3 hari setelah melahirkan. Kondisi ini sering terjadi karena motilitas usus menurun setelah melahirkan.

b. Kesulitan saat BAB (straining)

Ibu harus mengejan kuat untuk mengeluarkan feses. Hal ini sering terjadi karena ketakutan akan rasa sakit saat memperbaiki luka episiotomi atau jahitan perineum.

c. Feses keras dan kering

Feses menjadi padat, keras, dan sulit dikeluarkan. Ini adalah salah satu tanda utama dari konstipasi, yaitu penyerapan air yang terlalu banyak di usus besar.

d. Rasa tidak tuntas setelah BAB

Ibu merasa masih ada sisa tinja di dalam rektum meskipun sudah buang air besar, sehingga merasa tidak nyaman terus-menerus.

e. Nyeri atau ketidaknyamanan perut

Perut terasa begitu penuh, membengkak, atau sakit karena feses menumpuk di usus besar.

f. Nyeri pada daerah anus atau perineum

Secara khusus, pada ibu yang mengalami luka episiotomi, sembelit dapat memperparah rasa sakit saat BAB. Bahkan dapat meningkatkan risiko hemoroid.

g. Perut kembung dan penurunan nafsu makan

Gangguan eliminasi menyebabkan rasa tidak nyaman di saluran cerna, yang membuat seseorang kehilangan nafsu makan.

h. Perdarahan ringan saat BAB

Tinja yang keras bisa menyebabkan luka kecil di sekitar anus (fisura ani) sehingga muncul darah segar.

Pada kasus Konstipasi yang berlanjut bisa menyebabkan masalah seperti hemoroid, fisura pada dubur, serta hambatan dalam penyembuhan luka di daerah perineum.

5. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang untuk konstipasi setelah melahirkan bertujuan agar diagnosis lebih tepat, mengetahui tingkat keparahan kondisi, serta memastikan tidak ada komplikasi atau penyebab lain yang mungkin terjadi. Pada ibu yang sedang nifas, sebagian besar kasus sembelit tergolong fungsional, tetapi tetap perlu dilakukan pemeriksaan penunjang jika gejala terus-menerus atau cukup parah.

Beberapa pemeriksaan penunjang konstipasi Setelah Melahirkan

a. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mengevaluasi kondisi umum serta faktor penyebab tidak langsung, seperti: Hemoglobin (Hb) digunakan untuk mendeteksi anemia setelah melahirkan yang bisa memperparah kelelahan dan fungsi pencernaan. Elektrolit seperti natrium (Na), kalium (K), dan kalsium (Ca) bisa mempengaruhi gerakan usus karena ketidakseimbangan dalam jumlah elektrolit tersebut. Fungsi kelenjar tiroid (TSH) bisa menjadi penyebab konstipasi jika diduga ada hipotiroid. Pemeriksaan seperti ini umumnya dilakukan jika sembelit berlangsung cukup lama atau tidak membaik meski sudah diberi pengobatan secara konservatif.

b. Pemeriksaan Feses

Analisis feses bertujuan untuk:

- 1) Menilai konsistensi dan bentuk feses
- 2) Mendeteksi adanya darah tersembunyi yang bisa menunjukkan adanya fisura ani atau hemoroid.
- 3) Menilai kemungkinan infeksi atau gangguan pencernaan lain

c. Pemeriksaan Digital Rectal Examination/DRE

Pemeriksaan ini penting untuk:

- 1) Menilai adanya impaksi feses
- 2) Mengetahui tonus sfingter ani
- 3) Mengidentifikasi hemoroid, fisura ani, atau nyeri lokal

Pada ibu yang sedang nifas, pemeriksaan ini juga berguna untuk mengetahui pengaruh cedera di daerah perineum yang terjadi selama proses melahirkan.

d. Pemeriksaan Radiologi (Jika Diperlukan)

Pemeriksaan ini dilakukan pada kasus konstipasi kronis atau berat. Foto abdomen yang bersih (X-ray) untuk memeriksa adanya penumpukan buang air besar di kolon. Jika ada kecurigaan adanya sumbatan atau kelainan pada struktur, maka dilakukan CT scan atau MRI. Tetapi, pemeriksaan ini biasanya

tidak dilakukan pada kasus postpartum biasa dan hanya dilakukan jika ada tanda-tanda tertentu.

e. Pemeriksaan Transit Kolon

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat feces bergerak di dalam usus besar dengan menggunakan marker yang dapat dilihat menggunakan radiasi. Tujuannya adalah membedakan:

- 1) Konstipasi akibat slow transit
- 2) Konstipasi akibat gangguan defekasi (obstruktif)

f. Anorectal Manometry

Pemeriksaan ini mengecek tekanan dan kerja otot rektum serta sfingter ani. Bermanfaat untuk:

- 1) Menilai gangguan koordinasi otot saat defekasi
- 2) Mengidentifikasi disfungsi dasar panggul

g. Defekografi

Merupakan pemeriksaan radiologis khusus yang digunakan untuk menilai proses buang air besar secara langsung. Digunakan pada kasus:

- 1) Konstipasi kronis
- 2) Dugaan prolaps rektum atau disfungsi dasar panggul

6. Komplikasi

Konstipasi membuat ibu perlu mengejan keras saat BAB, yang berdampak pada peningkatan tekanan pada pembuluh darah vena di sekitar area rektum dan anus. Akibatnya, pembuluh darah mengalami pembengkakan yang menyebabkan rasa sakit, perdarahan, dan ketidaknyamanan. Kondisi ini juga bisa menjadi lebih buruk karena trauma dari proses melahirkan, seperti episiotomi.

Selain itu, konstipasi bisa menyebabkan fisura ani, yaitu luka kecil di bagian dalam lubang bokong yang terjadi karena tumpukan feces yang kering dan keras. Fisura ani didampangi rasa sakit yang tajam ketika buang air besar dan terkadang juga ada sedikit perdarahan. Jika tidak diatasi, situasi ini bisa membuat ibu sulit buang air besar karena takut sakit, yang justru memperburuk sembelit.

Komplikasi lainnya adalah rasa sakit di daerah perineum yang terus-menerus terasa. Pada ibu yang mengalami episiotomi atau robekan pada daerah perineum, konstipasi bisa membuat tekanan semakin besar saat berusaha mengejan, sehingga mengganggu proses penyembuhan luka tersebut. Ini bisa menyebabkan peradangan, bengkak, bahkan berisiko terkena infeksi pada luka. Penelitian menunjukkan bahwa konstipasi dapat menyebabkan kenaikan rasa sakit di daerah episiotomi.

Konstipasi bisa menyebabkan impaksi feces, yaitu situasi di mana tinja mengumpul dan menjadi keras di dalam rektum, sehingga sulit dikeluarkan

seperti biasanya. Impaksi feses bisa menyebabkan rasa sakit yang parah, perut mengembang, dan membutuhkan pertolongan medis seperti pengeluaran manual buang air besar atau pemberian enema. Selanjutnya, komplikasi yang lebih besar adalah gangguan pada fungsi dasar panggul. Mengejan terus-menerus secara berlebihan dapat melemahkan otot dasar panggul, yang bisa menyebabkan masalah seperti mengalami inkontinensia urin atau bahkan prolaps organ panggul. Pada masa nifas, kondisi ini perlu diperhatikan karena otot panggul masih sedang pulih setelah proses melahirkan.

Dari segi sistem pencernaan, konstipasi bisa menyebabkan perut kembung, rasa sakit di perut, serta menurunkan hasrat makan. Kondisi ini bisa mengganggu pemasukan gizi ibu, meskipun kebutuhan gizi saat masa nifas sangat besar untuk pemulihan tubuh dan produksi ASI. Selanjutnya, sembelit juga memengaruhi penurunan kualitas hidup ibu yang sedang menyusui. Perasaan tidak nyaman, rasa sakit saat buang air besar, serta perasaan cemas untuk BAB bisa membuat stres dan terasa lelah. Dalam beberapa situasi, kondisi ini justru bisa menghambat keseluruhan proses pemulihan setelah melahirkan.

7. penatalaksanaan

Penanganan konstipasi setelah melahirkan bertujuan agar fungsi buang air tinja kembali normal, mencegah terjadinya masalah tambahan, serta membuat ibu yang baru melahirkan merasa lebih nyaman. Penanganan dilakukan secara menyeluruh, mencakup terapi nonfarmakologis dan farmakologis, dengan pendekatan yang meliputi promosi, pencegahan, dan pengobatan.

Penatalaksanaan Konstipasi Setelah Melahirkan

a. Terapi Nonfarmakologis (Utama)

Pendekatan pertama yang disarankan adalah intervensi nonfarmakologis karena cara ini aman dan efektif untuk ibu yang sedang menyusui.

1) Peningkatan asupan serat

Ibu disarankan untuk mengonsumsi makanan yang kaya serat, seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Serat membantu memperbesar ukuran tinja dan mendorong gerakan usus. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya serat dalam diet menjadi salah satu penyebab utama sembelit setelah melahirkan.

2) Peningkatan asupan cairan

Minum air minimal 8 hingga 10 gelas setiap hari sangat penting agar tinja menjadi lembut dan memudahkan proses buang air besar. Asupan cairan yang cukup terbukti membantu mencegah feses keras pada ibu yang baru melahirkan.

3) Mobilisasi dini (ambulasi)

Ibu disarankan untuk segera melakukan kegiatan ringan setelah melahirkan. Mobilisasi dini bisa mendorong kerja usus dan membantu mempercepat pemulihan fungsi sistem pencernaan.

4) Kebiasaan BAB yang baik

Ibu sebaiknya tidak menunda keinginan BAB dan terbiasa melakukan BAB pada waktu yang rutin. Menunda BAB dapat memperburuk konstipasi.

5) Latihan fisik ringan

Senam nifas atau kegiatan santai seperti jalan kaki bisa membantu menggerakkan usus dan mempercepat proses penyembuhan tubuh.

6) Manajemen nyeri perineum

Nyeri karena episiotomi sering membuat ibu merasa takut saat mengejan. Oleh karena itu, merawat luka perineum dan mengelola rasa sakit sangat penting agar ibu tidak kesulitan saat buang air besar.

b. Terapi Farmakologis

1) Laksatif berbentuk bubuk (misalnya psyllium) untuk meningkatkan volume tinja.

2) Laksatif osmotik seperti laktulosa berfungsi untuk menarik air ke dalam usus.

3) Stool softener untuk melunakkan feses

Penggunaan obat harus memperhatikan keamanan bagi ibu yang sedang menyusui dan harus dilakukan sesuai anjuran tenaga kesehatan.

c. Edukasi dan Konseling

Edukasi merupakan bagian penting dalam penatalaksanaan, meliputi:

1) Pentingnya nutrisi seimbang dan cairan cukup

2) Anjuran mobilisasi dini

3) Cara BAB yang benar tanpa mengejan berlebihan

4) Tanda-tanda bahaya seperti tidak buang air besar lebih dari 3–4 hari, nyeri yang sangat mengganggu, atau ada perdarahan.

5) Pendekatan berupa pengajaran terbukti membantu ibu lebih mematuhi cara mencegah dan menangani konstipasi setelah melahirkan.

8. Asuhan kebidanan dan Dokumentasi

Asuhan kebidanan kepada ibu yang baru melahirkan dan mengalami sembelit merupakan bagian yang penting dalam layanan postpartum. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah buang air besar, mencegah terjadinya komplikasi, serta membuat ibu merasa lebih nyaman. Pendekatan yang digunakan biasanya adalah manajemen kebidanan dengan metode SOAP (Subjektif, Objektif, Evaluasi, Perencanaan) secara terus menerus. Asuhan Kebidanan Konstipasi Setelah Melahirkan :

- a. Pengkajian (Data Subjektif dan Objektif). Pada tahap ini bidan mengumpulkan data secara lengkap, meliputi:

Data subjektif: Ibu mengeluh sulit buang air besar, tinja keras, ada rasa sakit saat BAB, belum BAB lebih dari 3 hari, serta merasa takut mengejan karena ada luka di daerah perineum.

Data objektif menunjukkan kondisi umum yang baik, perut terasa keras atau mengembang, terdapat luka episiotomi, serta tanda vital berada dalam rentang normal.
- b. Diagnosa Kebidanan (Assessment). Diagnosa yang dapat ditegakkan adalah: Ibu nifas dengan konstipasi berhubungan dengan:
 - 1) Penurunan motilitas usus
 - 2) Nyeri luka perineum
 - 3) Kurangnya asupan serat dan cairan
- c. Perencanaan (Planning)

Rencana asuhan difokuskan pada peningkatan cara buang air besar dan kecil serta memberikan penjelasan kepada ibu, meliputi:

 - 1) Menganjurkan mengonsumsi makanan yang kaya akan serat, seperti buah, sayur, dan pepaya.
 - 2) Meningkatkan asupan cairan minimal 2 liter/hari
 - 3) Menganjurkan mobilisasi dini atau aktivitas ringan
 - 4) Memberikan penjelasan tentang cara BAB yang benar tanpa mengedan terlalu keras.
 - 5) Memberikan dukungan psikologis untuk mengurangi ketakutan BAB
 - 6) Pendidikan kesehatan ternyata sangat membantu ibu-ibu mengatasi sembelit setelah melahirkan.
- d. Implementasi
Pelaksanaan dilakukan sesuai rencana, antara lain:
 - 1) Memberikan konseling nutrisi dan cairan
 - 2) Mengajarkan senam nifas untuk merangsang peristaltik usus
 - 3) Melakukan perawatan luka perineum
 - 4) Kolaborasi pemberian laksatif jika diperlukan
- e. Evaluasi
Evaluasi dilakukan secara rutin untuk mengecek sejauh mana hasil asuhan tersebut berhasil.
 - 1) Ibu sudah dapat BAB dengan lancar
 - 2) Tidak ada nyeri saat BAB
 - 3) Feses lebih lunak
 - 4) Ibu memahami cara pencegahan konstipasi

9. Red flags & Rujukan

Tanda-tanda bahaya pada sembelit setelah melahirkan perlu diperhatikan dengan serius karena bisa menunjukkan adanya komplikasi yang berbahaya. Deteksi dini sangat penting agar ibu dapat segera mendapatkan penanganan atau direferensikan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

a. Red Flags Konstipasi Setelah Melahirkan

Beberapa gejala bahaya yang perlu diwaspadai pada ibu yang baru melahirkan dan mengalami sembelit adalah:

- 1) Tidak BAB lebih dari 3 hingga 5 hari dengan rasa sakit yang sangat parah.
Kondisi ini bisa menyebabkan sembelit atau penyumbatan usus, terutama jika disertai perut membengkak dan muntah.
- 2) Perdarahan saat BAB dalam jumlah banyak
Meskipun pendarahan sedikit bisa terjadi akibat hemoroid atau fisura ani, pendarahan yang banyak perlu diwaspadai karena bisa menjadi tanda komplikasi serius pada bagian bawah saluran cerna.
- 3) Nyeri abdomen berat dan distensi perut
Nyeri yang sangat kuat dan terus-menerus bisa menunjukkan adanya masalah serius seperti ileus atau penyumbatan pada usus.
- 4) Muntah berulang dan tidak bisa makan
Gejala ini bisa menunjukkan adanya gangguan pada pencernaan yang lebih parah dan perlu diperiksa oleh dokter secepat mungkin.
- 5) Demam atau tanda infeksi
Demam yang dialami ibu setelah bersalin jika disertai sembelit bisa menunjukkan adanya infeksi, seperti infeksi pada luka perineum atau komplikasi lainnya.
- 6) Tidak mampu BAB meskipun sudah diberikan terapi
Jika masalah sembelit tidak sembuh setelah mencoba pengobatan nonfarmakologis dan farmakologis, maka perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut.
- 7) Nyeri hebat pada area anus atau perineum
Dapat menunjukkan adanya fisura ani yang parah, abses, atau komplikasi dari luka episiotomi.

b. Indikasi Rujukan

Rujukan diperlukan ketika terdapat tanda-tanda bahaya atau kondisi yang tidak bisa ditangani di fasilitas pelayanan dasar. Indikasi rujukan meliputi:

- 1) Dugaan yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut akibat feses.
- 2) Perdarahan rektal yang signifikan
- 3) Nyeri abdomen berat yang mencurigakan obstruksi usus

- 4) Konstipasi yang berlangsung terus-menerus dan tidak membaik meskipun sudah diberikan pengobatan biasa.
- 5) Komplikasi seperti hemoroid yang parah atau infeksi pada luka perineum.
- 6) Gangguan pada fungsi dasar panggul yang membutuhkan penanganan oleh spesialis.

Rujukan biasanya diberikan kepada dokter spesialis obstetri-ginekologi atau spesialis penyakit dalam untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.

C. Hemoroid

1. Definisi

Hemoroid setelah melahirkan adalah kondisi di mana pembuluh darah vena di area rektum dan anus memberi tekanan dan mengembang, sehingga menyebabkan kembang kempis pada ibu setelah melahirkan. Kondisi ini adalah salah satu masalah yang sering terjadi saat masa nifas, karena adanya peningkatan tekanan di dalam perut selama kehamilan dan proses melahirkan, terutama saat melakukan tindakan mengejan.

Hemoroid terjadi secara fisiologis karena terganggunya aliran darah kembali pada vena di daerah pleksus hemoroidalis, sehingga menyebabkan pembuluh darah membesar dan mengalami peradangan. Selama masa kehamilan, rahim membesar dan menekan pembuluh darah di daerah panggul, sehingga aliran darah dari usus besar menjadi terhambat. Setelah melahirkan, kondisi ini bisa semakin buruk karena proses melahirkan secara vaginal yang membutuhkan mengejan keras, sehingga tekanan pada pembuluh darah meningkat dan menyebabkan terbentuknya hemoroid.

Dari segi medis, hemoroid yang terjadi setelah melahirkan bisa diketahui berdasarkan gejala seperti darah yang keluar saat buang air besar, rasa sakit atau tidak nyaman di sekitar anus, ada benjolan di sekitar anus, serta terasa gatal. Meskipun kebanyakan kasus hemoroid tidak begitu parah dan bisa sembuh dengan cara pengobatan yang tidak berdasarkan operasi, kondisi ini tetap perlu diperhatikan karena dapat mengganggu kenyamanan ibu saat menjalani masa nifas dan dalam beraktifitas sehari-hari.

2. Etiologi

Penyebab hemoroid setelah melahirkan terjadi karena beberapa faktor, seperti perubahan tubuh selama kehamilan, cara melahirkan, serta kebiasaan yang dilakukan saat masa nifas. Hemoroid terjadi karena vena di area rektum dan anus membesar dan membengkak, terutama di pleksus hemoroidalis, yang

disebabkan oleh tekanan yang meningkat dan gangguan aliran darah pada vena tersebut.

Salah satu penyebab utamanya adalah meningkatnya tekanan di dalam perut selama masa kehamilan. Pembesaran rahim memberi tekanan pada vena cava inferior dan pembuluh darah di daerah pelvis, yang menyebabkan aliran darah kembali dari rektum terganggu. Akibatnya, darah menggenang dan menyebabkan pembuluh darah hemoroid mengembang. Kondisi ini semakin memburuk karena perubahan hormon, terutama kenaikan hormon progesteron yang membuat dinding pembuluh darah rileks, sehingga vena lebih gampang membesar.

Selain itu, proses melahirkan melalui vagina adalah faktor penyebab penting. Saat ibu berusaha meneran, tekanan di dalam perut meningkat banyak, sehingga memberikan tekanan besar pada vena di sekitar dubur.

Faktor lain yang ikut berperan adalah sembelit yang terjadi setelah melahirkan. Ibu yang sedang nifas sering mengalami sembelit karena gerakan usus menjadi lambat, kurangnya makanan ber serat, dan rasa takut untuk buang air besar karena sakit di area luka perineum. Konstipasi membuat ibu perlu mengejan lebih keras ketika buang air besar, sehingga menambah tekanan pada pembuluh darah di area anus dan membuat hemoroid semakin parah.

Trauma perineum juga menjadi faktor etiologi penting. Luka episiotomi atau robekan pada jalan lahir bisa membuat ibu merasa nyeri, sehingga ia kesulitan untuk ber BAB. Penahanan ini membuat tinja menjadi kering dan meningkatkan tekanan saat buang air besar berikutnya. Selain itu, trauma pada jaringan dapat mengganggu aliran darah di area lokal, sehingga memperparah kondisi pembuluh darah di sekitar anus.

Faktor lain yang juga memengaruhi adalah kurangnya kemampuan berpindah atau bergerak setelah proses melahirkan. Imobilisasi membuat aliran darah tidak lancar, termasuk di area pelvis, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya stasis vena. Selain itu, obesitas, bayi yang lahir dengan berat badan besar, serta pengalaman hemoroid sebelumnya juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hemoroid setelah melahirkan.

Dari segi gaya hidup, kurangnya asupan cairan dan pola makan yang rendah serat juga menjadi penyebab tidak langsung. Kedua faktor tersebut turut menyebabkan sembelit, yang akhirnya memperburuk keadaan hemoroid.

3. Faktor risiko

Faktor risiko terjadinya hemoroid setelah melahirkan (Postpartum) terjadi karena adanya pengaruh dari perubahan tubuh selama kehamilan, cara melahirkan, serta kondisi khusus dari ibu itu sendiri. Hemoroid setelah

melahirkan cukup umum terjadi, dengan angka kejadian sekitar 30 hingga 40 persen pada ibu yang baru melahirkan. Berikut adalah faktor-faktor risikonya:

a. Konstipasi selama kehamilan dan nifas

Konstipasi merupakan faktor risiko paling dominan. Perubahan hormon, khususnya peningkatan progesteron, membuat usus lebih lambat bekerja, sehingga tinja menjadi kering dan susah dikeluarkan. Kondisi ini menyebabkan mengejan yang terlalu berlebihan saat buang air besar, yang meningkatkan tekanan di dalam rongga perut dan tekanan pada pembuluh darah di daerah rektal.

b. Riwayat hemoroid atau penyakit perianal sebelumnya

Perempuan yang pernah mengalami hemoroid sebelum atau selama hamil memiliki kemungkinan lebih besar kambuh lagi setelah melahirkan. Hal ini berkaitan dengan melemahnya dinding pembuluh darah dan kemungkinan statis Vena.

c. Proses persalinan pervaginam dan mengejan lama

Persalinan secara alami, terutama jika membutuhkan waktu mengejan lebih dari 20 menit, memberi tekanan pada vena hemoroid, sehingga menyebabkan pembuluh darah di sekitar anus mengembang. Persalinan dengan menggunakan tindakan vakum atau forceps juga bisa menjadi salah satu penyebab risiko.

d. Berat badan bayi lahir besar (makrosomia)

Bayi yang beratnya lebih dari atau sama dengan 3.800 gram dapat meningkatkan tekanan di dalam perut saat melahirkan, sehingga meningkatkan kemungkinan terkena hemoroid setelah melahirkan.

e. Tekanan intraabdomen akibat kehamilan

Pembesaran rahim selama kehamilan mengakibatkan tekanan pada vena besar di bawah lambung dan vena di daerah pelvis, sehingga menyebabkan pengumpulan darah dalam pembuluh vena. Kondisi ini berlangsung hingga masa nifas dan menyebabkan terbentuknya hemoroid.

f. Paritas tinggi (multiparitas)

Persalinan yang lebih dari tiga kali meningkatkan risiko karena otot dasar panggul menjadi lemah dan tekanan berulang pada sistem vena di daerah anorektal.

g. Gaya hidup dan faktor diet

Asupan serat yang rendah, kurangnya cairan, dan aktivitas fisik yang tidak cukup selama masa kehamilan dan nifas bisa menyebabkan sembelit, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan terkena hemoroid.

h. Faktor umum lain (obesitas, usia, riwayat keluarga)

Faktor-faktor seperti obesitas, usia ibu yang lebih tua, dan riwayat keluarga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami hemoroid.

4. Patofisiologi

Hemoroid postpartum adalah kondisi di mana jaringan vena hemoroid di area anus mengalami pembengkakan dan pelebaran, yang terjadi karena perubahan pada tubuh selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Secara alami, pleksus hemoroidalis berperan sebagai penyangga pembuluh darah yang membantu menjaga kemampuan menahan buang air besar. Namun, dalam kondisi yang tidak normal, terjadi ketidakseimbangan tekanan dan aliran darah vena, sehingga menyebabkan pembuluh darah menjadi macet dan membesar.

Dari segi penyebabnya, mekanisme utama dimulai dengan meningkatnya tekanan di dalam perut dan tekanan pada vena di daerah pelvis selama kehamilan dan proses melahirkan. Pembesaran rahim menekan vena besar di bawah dan vena di daerah pelvis, sehingga mengganggu aliran darah kembali dari area usus besar. Akibatnya terjadi penumpukan darah dan pembesaran pembuluh darah hemoroid. Setelah melahirkan, kondisi ini bisa tetap ada atau semakin parah, terutama jika ibu mengalami susah buang air besar dan sering mengejan saat BAB.

Selain itu, trauma dan peningkatan tekanan yang terjadi selama proses persalinan pervaginam juga memainkan peran yang cukup penting. Mengejan kuat selama masa persalinan pada tahap II dapat meningkatkan tekanan di dalam perut secara signifikan, sehingga memperburuk pembengkakan pembuluh darah hemoroid. Hal ini menyebabkan kerusakan pada jaringan penyangga di dalam saluran anus, sehingga bantalan hemoroid bergerak turun atau menggantung.

Faktor yang ikut berperan adalah perubahan hormon, terutama kenaikan hormon progesteron saat hamil yang menyebabkan otot pembuluh darah rileks. Kondisi ini membuat vena lebih mudah membesar dan lebih rentan mengalami pengumpulan darah.

Selanjutnya, konstipasi setelah melahirkan bisa membuat kondisi lebih buruk karena tekanan saat buang air besar meningkat dan feses yang keras menggores mukosa anus. Hal ini bisa memicu peradangan, pembengkakan, bahkan pendarahan pada hemoroid.

Secara umum, patofisiologi hemoroid setelah melahirkan adalah gabungan dari stagnasi aliran darah di vena, peningkatan tekanan dalam rongga perut, kelemahan jaringan penyangga, serta faktor hormon, yang pada akhirnya menyebabkan pembesaran, peradangan, dan keluarnya pleksus hemoroid.

5. Klasifikasi

Hemoroid postpartum secara dasar sama dengan hemoroid pada orang umum, dengan perbedaan pada penyebabnya, yaitu kehamilan dan proses persalinan. Klasifikasi ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat keparahan serta pengelolaan klinis dengan tepat.

a. Klasifikasi Berdasarkan Lokasi. Secara anatomi, hemoroid dibagi menjadi:

1) Hemoroid interna

Berada di atas linea dentata dan dilapisi mukosa. Biasanya tidak terasa sakit karena jumlah reseptor sakitnya sedikit, tetapi sering kali menyebabkan pendarahan saat BAB.

2) Hemoroid eksterna

Berada di bawah linea dentata dan dilapisi kulit. Lebih sering menimbulkan rasa sakit, terutama ketika terjadi trombosis

3) Hemoroid campuran

Kombinasi hemoroid internal dan eksternal yang umum terjadi pada ibu hamil setelah melahirkan karena tekanan saat proses persalinan.

b. Klasifikasi Berdasarkan Derajat (Goligher Classification)

Klasifikasi ini umumnya digunakan dalam pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahan hemoroid internal.

1) Derajat I

Tidak terjadi prolaps, hanya perdarahan saat defekasi.

2) Derajat II

Terjadi Prolaps, tetapi dapat masuk kembali sendiri.

3) Derajat III

Prolaps saat buang air besar dan harus dimasukkan kembali secara manual.

4) Derajat IV

Prolaps tetap terjadi dan tidak bisa dipindahkan kembali, sering kali disertai komplikasi seperti trombosis atau strangulasi.

Setelah melahirkan, ibu sering mengalami hemoroid berupa hemoroid interna derajat II hingga III, yang disebabkan oleh tekanan di dalam perut yang meningkat selama proses melahirkan serta kebiasaan mengejan. Selain itu, konstipasi setelah melahirkan bisa membuat kondisi hemoroid menjadi lebih parah.

Secara umum, klasifikasi hemoroid yang terjadi setelah melahirkan meliputi pembagian berdasarkan lokasi hemoroid, yaitu internal, eksternal, atau campuran, serta tingkat keparahannya yang dibagi menjadi empat tingkat, yaitu I hingga IV. Penentuan klasifikasi ini sangat penting untuk menentukan jenis terapi yang

diberikan, baik berupa pengobatan konservatif maupun operasi jika kondisinya cukup parah.

6. Tanda-gejala

Hemoroid yang terjadi setelah melahirkan biasanya disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam perut yang terjadi selama kehamilan dan proses melahirkan. Gejala klinisnya bisa berbeda-beda tergantung jenisnya, apakah internal atau eksternal, serta tingkat keparahannya, namun secara umum memiliki pola gejala yang khas.

Gejala yang paling umum adalah adanya perdarahan dari rektum tanpa rasa sakit, terutama saat atau setelah buang air besar. Darah biasanya berwarna merah segar dan tampak mengalir atau melekat pada buang air besar. Kondisi ini biasanya lebih sering terjadi pada hemoroid internal karena letaknya di atas garis dentata yang memiliki sedikit reseptor nyeri.

Selain itu, ibu yang sedang masa postpartum sering merasa tidak nyaman atau merasa area anus terasa penuh. Keluhan ini bisa berupa rasa sakit, terasa tersumbat, atau perasaan belum tuntas setelah mengejan buang air besar. Pada beberapa situasi, terjadi prolaps yaitu benjolan yang keluar dari anus, terutama saat mengejan. Benjolan tersebut bisa masuk sendiri atau harus didorongkan secara manual, tergantung pada tingkat keparahannya.

Pada hemoroid eksterna, gejala yang paling sering dialami adalah sakit di area anus, terutama saat terjadi pembekuan darah. Nyeri umumnya terasa tajam dan semakin parah ketika duduk, berjalan, atau melakukan BAB. Hal ini terjadi karena area di bawah garis dentata memiliki banyak saraf nyeri.

Gejala lain yang sering muncul adalah gatal di sekitar anus dan kulit di area itu menjadi iritasi. Kondisi ini terjadi karena ada mukus atau sisa tinja yang keluar dan mengganggu kulit di sekitar anus. Selain itu, juga terdapat pembengkakan dan peradangan yang menyebabkan bengkak di area tertentu.

Setelah melahirkan, ibu sering mengalami gejala yang semakin parah karena sembelit setelah melahirkan dan kebiasaan mengejan saat BAB. Dalam beberapa situasi, hemoroid bisa menyebabkan masalah seperti trombosis, strangulasi, atau anemia karena pendarahan yang terus-menerus jika tidak dikelola dengan tepat.

7. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang untuk hemoroid setelah melahirkan dilakukan agar diagnosis bisa ditentukan secara jelas, mengevaluasi tingkat keparahannya, serta memastikan tidak ada penyakit lain di sekitar anus seperti fisura ani, polip, atau kanker. Setelah melahirkan, pemeriksaan ini sangat penting bagi ibu karena keluhan seperti perdarahan dari anus sering kali dianggap sebagai hal normal yang terjadi setelah melahirkan.

a. Colok dubur (Digital Rectal Examination/DRE).

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa adanya massa, rasa sakit, tingkat ketegangan sfingter, serta kelainan lain di bagian rektum. DRE sangat membantu untuk menghilangkan diagnosis lain meskipun pada kasus hemoroid interna, hasilnya biasanya normal.

b. Anoskopi.

Pemeriksaan utama yang dilakukan untuk hemoroid interna. Anoskop memungkinkan melihat langsung permukaan rektum bagian bawah dan area pleksus hemoroidalis. Pada pemeriksaan ini terlihat vena yang membesar dan berwarna biru atau merah, serta terjadi prolaps. Anoskopi membantu mengetahui letak dan tingkat keparahan hemoroid, sehingga sangat penting dalam merencanakan pengobatan.

c. Proktoskopi atau Sigmoidoskopi

Pemeriksaan ini juga bisa dilakukan untuk melihat bagian rektum yang lebih dalam. Pemeriksaan ini dilakukan bila ada gejala yang tidak biasa, seperti perdarahan yang terus-menerus, perubahan cara buang air besar, atau ada kecurigaan penyakit lainnya. Dalam kondisi tertentu, kolonoskopi dilakukan untuk memeriksa seluruh usus besar, khususnya jika ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan kanker atau anemia yang belum ada penjelasannya.

d. Pemeriksaan laboratorium,

Pemeriksaan ini khususnya tingkat hemoglobin. Hal ini penting bagi ibu yang baru melahirkan karena mereka berisiko mengalami anemia karena kehilangan darah selama proses melahirkan, yang bisa semakin parah jika ada perdarahan dari hemoroid yang sudah kronis.

e. Biopsi (Bila diperlukan)

Selain itu, jika ditemukan area yang mencurigakan selama pemeriksaan endoskopi, dapat dilakukan pemeriksaan biopsi terhadap jaringan tersebut. Biopsi dilakukan untuk memastikan diagnosis dan memeriksa apakah ada kemungkinan kanker di daerah anorektal, meskipun prosedur ini tidak biasa dilakukan pada kasus hemoroid yang tidak terlalu parah.

8. Komplikasi

Hemoroid yang terjadi setelah melahirkan biasanya tidak terlalu parah dan bisa sembuh dengan cara pengobatan tanpa operasi. Namun, jika tidak diatasi dengan tepat atau terjadi dalam jangka waktu yang lama, kondisi ini bisa menjadi lebih buruk dan menyebabkan masalah kesehatan bagi ibu yang baru melahirkan serta mengurangi kualitas hidupnya. Komplikasi ini terjadi karena perdarahan yang terus-menerus, gangguan pada pembuluh darah, dan peradangan di jaringan sekitar anus.

a. Anemia

Anemia merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi karena adanya perdarahan di area rektal yang berulang-ulang. Meskipun perdarahan dari hemoroid biasanya tidak terlalu banyak, tetapi jika terjadi secara terus-menerus, bisa menyebabkan kadar hemoglobin dalam darah berkurang. Pada ibu yang sedang masa postpartum, kondisi ini lebih berisiko karena ibu Postpartum sudah kehilangan darah selama proses melahirkan. Gejala anemia seperti merasa lemas, wajah pucat, sakit kepala, dan mudah lelah bisa menghambat proses pemulihan setelah melahirkan.

b. Trombosis hemoroid

Komplikasi ini bisa cukup parah karena terbentuknya gumpalan darah di dalam pembuluh darah hemoroid, terutama pada hemoroid yang berada di luar. Kondisi ini membuat sakit sangat, bengkak, dan terdapat benjolan keras di sekitar lubang anus. Setelah melahirkan, ibu sering mengalami trombosis karena tekanan yang meningkat saat proses persalinan dan juga karena sembelit yang terjadi setelah melahirkan.

c. strangulasi hemoroid

Strangulasi Hemoroid atau penyempitan pada pembuluh darah hemoroid, terutama pada hemoroid yang ada di dalam rectum dan menonjol keluar. Strangulasi terjadi ketika hemoroid tertekan oleh otot sfingter anus, sehingga aliran darah ke area tersebut terganggu. Hal ini bisa menimbulkan rasa sakit yang parah, pembengkakan, bahkan kerusakan jaringan jika tidak segera diatasi. Kondisi ini adalah masalah yang serius dan membutuhkan bantuan medis secepat mungkin.

d. Infeksi dan abses anorektal.

Hemoroid yang terluka, mengalami iritasi, atau pecah bisa menjadi jalan masuknya bakteri. Infeksi bisa membuat rasa sakit semakin parah, kulit kemerahan, terjadi pembengkakan, dan bahkan bisa terbentuk benjolan yang berisi cairan kotor. Pada wanita yang sedang masa nifas dan memiliki daya tahan tubuh yang berkurang, risiko terkena infeksi bisa semakin tinggi.

e. Iritasi kulit dan terbentuknya skin tag (lipatan kulit)

Hemoroid kronis dapat menyebabkan **iritasi kulit dan terbentuknya skin tag (lipatan kulit)** di sekitar anus. Kondisi ini membuat orang merasa tidak nyaman, gatal di sekitar anus, dan kesulitan membersihkan area itu dengan baik. Jika iritasi berlangsung terus-menerus, maka bisa membuat inflamasi di area tersebut semakin parah.

f. Prolaps Menerap

Dalam kasus yang parah, hemoroid bisa menyebabkan prolaps yang tetap tidak bisa kembali ke tempat semula. Kondisi ini bisa mengganggu kegiatan sehari-hari, menyebabkan rasa sakit yang berkelanjutan, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi lain seperti pembekuan darah dan gangguan pernapasan. Penelitian menunjukkan bahwa hemoroid yang sudah parah dapat menyebabkan gangguan besar terhadap kualitas hidup pasien dan biasanya memerlukan pembedahan.

9. Penatalaksanaan

Penanganan hemoroid setelah melahirkan bertujuan untuk mengurangi keluhan, mempercepat proses sembuh, serta mencegah kemunculan kembali gejala tersebut. Terapi dilakukan secara bertahap, mulai dari cara yang tidak invasif hingga prosedur yang lebih besar, tergantung pada tingkat dan keparahan hemoroid.

a. Terapi Non-Farmakologis (Konservatif)

Terapi utama untuk hemoroid setelah melahirkan adalah pendekatan tanpa penggunaan obat. Ibu di sarankan makan makanan yang kandungan serat, seperti sayuran, buah, dan biji-bijian, sebanyak 25 hingga 35 gram per hari, serta minum lebih banyak cairan. Tujuannya adalah agar tinja menjadi lebih lembut, sehingga membuat proses BAB lebih mudah dan tidak perlu mengejan terlalu keras. Selain itu, perubahan kebiasaan buang air besar juga sangat penting, misalnya tidak menahan BAB dan tidak duduk terlalu lama di toilet.

Metode lain yang bisa membantu adalah mandi duduk dengan air hangat (sitz bath) selama 10 hingga 15 menit beberapa kali sehari untuk meredakan rasa sakit, pembengkakan, dan peradangan di sekitar area anus. Aktivitas fisik yang tidak terlalu berat juga direkomendasikan untuk mendorong pergerakan usus dan mencegah sembelit.

b. Terapi Farmakologis

Jika cara pengobatan tradisional tidak cukup, maka bisa diberikan pengobatan dengan obat untuk mengendalikan gejala tersebut. Obat yang umum digunakan meliputi:

- 1) Laksatif atau stool softener untuk mencegah konstipasi
- 2) Analgesik untuk mengurangi nyeri
- 3) Salep atau obat topikal (seperti kortikosteroid atau anestesi lokal) digunakan untuk mengurangi peradangan dan rasa tidak nyaman.

Terapi medikamentosa bertujuan utama untuk mengurangi gejala, bukan menghilangkan masalah secara permanen. Penggunaan obat perlu memperhatikan keamanan bagi ibu yang sedang menyusui.

c. Terapi Non-Bedah (Minimal Invasif)

Pada hemoroid derajat II–III yang tidak sembuh dengan pengobatan konservatif, dapat dilakukan tindakan non-bedah seperti:

- 1) Ligasi pita karet (rubber band ligation)
- 2) Skleroterapi
- 3) Koagulasi inframerah

Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi aliran darah ke area hemoroid, sehingga memicu pemulihan dan penyusutan. Metode ini cukup aman dan efektif, serta biasanya dipilih sebelum menjalani operasi bedah.

d. Terapi Bedah

Tindakan operatif dilakukan untuk kondisi yang lebih parah, seperti hemoroid tingkat III hingga IV, trombosis yang berat, atau prolaps yang tidak berpindah. Prosedur yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Hemoroidektomi (pengangkatan hemoroid)
- 2) Stapled hemorrhoidopexy

Meskipun cara ini efektif, biasanya diambil sebagai opsi terakhir karena sifatnya yang menginvasi dan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama.

e. Edukasi dan Pencegahan

Edukasi merupakan bagian penting dalam penatalaksanaan. Ibu yang sedang masa menyusui disarankan untuk menjaga kebersihan bagian perianal, menghindari mengejan terlalu keras, serta tetap menjaga pola makan yang sehat.

10. Asuhan kebidanan dan Dokumentasi

Asuhan kebidanan kepada ibu yang sedang masa nifas dan mengalami hemoroid bertujuan untuk mengurangi rasa sakit atau keluhan yang dirasakan, mencegah terjadinya komplikasi, serta membantu meningkatkan kenyamanan ibu selama proses pemulihan. Pendekatan yang digunakan adalah manajemen kebidanan berdasarkan metode Varney, yang disusun dalam format SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Planning), dan telah terbukti efektif dalam berbagai kasus setelah melahirkan.

a. Pengkajian (Assessment Awal)

Pengkajian meliputi data subjektif dan objektif:

- 1) Data subjektif: ibu mengeluh merasa nyeri saat buang air besar, ada perdarahan, terdapat benjolan di sekitar anus, merasa gatal, atau merasa tidak nyaman saat duduk.

- 2) Data objektif: ditemukan hemoroid (dalam atau luar), prolaps, bengkak, atau gejala peradangan di area sekitar anus.

Pemeriksaan tambahan seperti pengecekan tanda vital dan kondisi umum ibu yang baru melahirkan juga penting untuk mengetahui apakah ada komplikasi yang terjadi. Dibutuhkan pemeriksaan yang mendalam karena masa nifas adalah waktu yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan fisik, termasuk hemoroid.

b. **Diagnosis Kebidanan**

Diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pengkajian, misalnya:

P1A0 hari ketiga setelah melahirkan dengan hemoroid derajat II, mengalami nyeri dan susah buang air besar.

Diagnosis ini dibutuhkan agar bisa membuat rencana perawatan yang sesuai dan tepat berdasarkan kondisi ibu.

c. **Perencanaan Asuhan**

Perencanaan meliputi:

- 1) Edukasi tentang diet tinggi serat dan cairan
- 2) Anjuran tidak mengejan berlebihan saat BAB
- 3) Perawatan lokal seperti mandi rendam air hangat (sitzen bath).
- 4) Penyediaan terapi kolaboratif seperti laksatif atau salep topikal sesuai dengan indikasinya.
- 5) Edukasi kebersihan perianal

Perencanaan pengasuhan harus dilakukan secara individual dan memperhatikan kondisi ibu serta keamanan saat menyusui.

d. **Implementasi**

Pelaksanaan asuhan dilakukan sesuai rencana, antara lain:

- 1) Memberikan konseling tentang pola makan sehat
 - 2) Mengajarkan teknik relaksasi saat BAB
 - 3) Membimbing ibu melakukan perawatan area anus
 - 4) Kerja sama dengan tenaga medis dalam memberikan obat jika dibutuhkan.
- Pemberian edukasi terbukti membantu ibu meningkatkan kemampuan mereka dalam merawat diri sendiri selama masa nifas.

e. **Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan asuhan, misalnya:

- 1) Nyeri berkurang
- 2) Tidak ada perdarahan
- 3) BAB lancar tanpa mengejan
- 4) Hemoroid mengecil atau tidak prolaps

Evaluasi dilakukan secara rutin pada setiap kunjungan nifas (KF1 hingga KF4) agar proses pemulihan bisa berjalan optimal.

11. Red flags & rujukan

Hemoroid yang terjadi setelah melahirkan biasanya adalah kondisi yang tidak berbahaya dan dapat diatasi dengan cara konservatif. Namun, dalam praktik kebidanan, sangat penting untuk mengenali tanda-tanda bahaya yang menunjukkan adanya komplikasi atau kemungkinan penyakit yang lebih serius. Identifikasi dini sangat penting agar ibu yang baru melahirkan dapat mendapatkan penanganan atau rujukan yang tepat waktu.

a. Red Flags Hemoroid Postpartum

Beberapa gejala berbahaya yang perlu diwaspadai pada ibu yang mengalami hemoroid setelah melahirkan meliputi:

1) Perdarahan rektal berlebihan atau berulang .

Perdarahan normal pada hemoroid biasanya ringan. Jika darah keluar dalam jumlah banyak, terus-menerus, atau muncul di luar waktu buang air besar, maka hal ini bisa jadi tanda adanya kondisi serius seperti anemia atau masalah lain pada kolon.

2) Nyeri yang sangat mengganggu dan tidak membaik meskipun sudah diterapi dengan cara konservatif.

Nyeri ringan biasanya tidak berbahaya, tetapi nyeri yang berat dan terus-menerus menunjukkan adanya trombosis hemoroid atau komplikasi lain seperti abses di daerah anus.

3) Benjolan keras, kebiruan, dan sangat nyeri

Kondisi ini menyebabkan trombosis hemoroid, yaitu pembentukan darah beku dalam vena hemoroid yang harus ditangani oleh tenaga medis secepat mungkin.

4) Tanda infeksi (demam, kemerahan, bengkak, keluar nanah)

Infeksi di area perianal atau abses bisa terjadi dan cukup serius jika hemoroid mengalami iritasi atau mengalami luka. Gejala seperti demam, nyeri yang berat, dan munculnya benjolan merupakan tanda-tanda yang memerlukan pemeriksaan segera.

5) Konstipasi berat atau tidak bisa BAB

Kondisi ini bisa membuat hemoroid lebih parah dan menandakan gangguan pada sistem pencernaan yang perlu diperiksa lebih lanjut.

6) Perubahan pola BAB atau gejala tidak khas

Diare yang berlangsung lama, penurunan berat badan, atau adanya darah dalam feses, bisa menjadi tanda-tanda yang mengarah pada diagnosis lain seperti kanker kolorektal.

7) Tidak ada perbaikan setelah 1–2 minggu terapi

Hemoroid postpartum umumnya membaik dalam beberapa minggu. Jika tidak ada peningkatan, maka dokter atau tenaga medis harus melakukan pengevaluasian lebih lanjut.

b. Indikasi Rujukan

Rujukan dilakukan apabila ditemukan kondisi berikut:

- 1) Hemoroid derajat III–IV dengan prolaps menetap
- 2) Trombosis hemoroid dengan nyeri berat
- 3) Perdarahan signifikan hingga menyebabkan anemia
- 4) Dugaan infeksi atau abses anorektal
- 5) Kecurigaan penyakit lain (fisura ani, polip, keganasan)
- 6) Tidak respon terhadap terapi konservatif

Rujukan biasanya dilakukan ke dokter spesialis bedah atau bedah perut untuk pengecekan lebih lanjut, termasuk kemungkinan prosedur seperti ligasi atau operasi.

c. Peran Bidan dalam Rujukan

Dalam pelayanan kebidanan, bidan memainkan peran yang sangat penting dalam:

- 1) Deteksi dini red flags melalui pengkajian komprehensif
- 2) Memberikan edukasi kepada ibu tentang tanda bahaya
- 3) Menentukan waktu rujukan yang tepat
- 4) Melakukan kolaborasi dengan tenaga medis lain

Selain itu, bidan harus memastikan bahwa kondisi ibu yang baru melahirkan tetap stabil, karena ada kemungkinan terjadi komplikasi lain seperti perdarahan setelah melahirkan atau infeksi yang juga memerlukan penanganan segera.

Latihan

Seorang Perempuan umur 31 tahun P2A0 melahirkan 8 jam yang lalu secara spontan pervaginam di Puskesmas mengatakan belum buang Air Kecil dan merasa takut untuk BAK. Hasil Anamnesis : Klien merasakan kandung kemih penuh dan terasa nyeri. Hasil Pemeriksaan : Kesadaran Komposmentis , TTD 100/60 mmHg, N 110 x/menit, R 24 x/menit, S 39°C, kandung kemih teraba keras, nyeri tekan perut bagian bawah, terdapat luka bekas episiotomi derajat 2, kontraksi uterus melemah.

Pertanyaan :

1. Apa masalah utama pada kasus tersebut?
2. Apa Faktor resiko yang mempengaruhi kasus tersebut ?
3. Apakah Tindakan awal bidan yang dapat dilakukan ?
4. Jelaskan asuhan kebidanan yang tepat sesuai kasus tersebut?
5. Kapan ibu harus dirujuk?

SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Nifas : Gangguan Eliminasi
3	Kasus	Retensi urine dengan tindakan awal dan pra rujukan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang Perempuan umur 31 tahun P2A0 melahirkan 8 jam yang lalu secara spontan pervaginam di Puskesmas mengatakan belum buang Air Kecil dan merasa takut untuk BAK. Hasil Anamnesis : Klien merasakan kandung kemih penuh dan terasa nyeri. Hasil Pemeriksaan : Kesadaran Komposmentis , TTD 100/60 mmHg, N 110 x/menit, R 24 x/menit, S 39°C, kandung kemih teraba keras, nyeri tekan perut bagian bawah, terdapat luka bekas episiotomi derajat 2, kontraksi uterus melemah. TUGAS Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. Lakukan pemeriksaan fisik terfokus sesuai kasus. Sampaikan diagnosis kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. Berikan KIE kepada ibu dan jelaskan rencana rujukan
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. Tuliskan nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka

No.	Komponen	Isi
		Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: Actual mark (0/1/2/3) Global rating (1/2/3/4) Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. Jika peserta menyatakan akan melakukan pemeriksaan fisik , penguji memberikan data: TTD 100/60 mmHg, N 110 x/menit, R 24 x/menit, S 39°C , kandung kemih teraba keras, nyeri tekan perut bagian bawah, terdapat luka bekas episiotomi derajat 2, kontraksi uterus lemah. Jika peserta meminta hasil anamnesa, penguji memberikan data kandung kemih penuh dan terasa nyeri Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: Menilai ulang kondisi ibu secara cepat, menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas, Menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih, Melakukan pemantauan tanda vital, Menyiapkan rujukan segera, Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: PS berperan sebagai ibu nifas PS tampak cemas, sesekali meringis saat merasakan nyeri, memegang perut bawah, dan berbicara terputus saat nyeri datang. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif.

No.	Komponen	Isi
		Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Perut saya bagian bawah terasa nyeri. Peserta: Sejak kapan merasa nyeri? PS: Kira-kira sudah 30 menit yang lalu, Bu. Peserta: BAK terakhir kapan setelah melahirkan? PS: belum samasekali bu Peserta: Apakah sudah mencoba untuk BAK mandiri di kamar mandi atau di pispot? PS: belum, karena saya merasa takut untuk BAK. Peserta: apa yang ditakutkan dengan BAK? PS: luka jahitan di jalan lahir bu. Peserta: baik , saya coba untuk melakukan pemeriksaan Fisik ya Bu? PS: baik bu, tolong bantu saya ya bu Peserta: Ada riwayat darah tinggi, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Ibu, saya akan melakukan seraingkaian pemeriksaan fisik ibu untuk menunjang data yang saya butuhkan PS: Baik, Bu, saya bersedia. Peserta: Saya akan melakukan tindakan awal dan menyiapkan rujukan. PS: Iya, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen (bukan Phantom hamil) - Phantom vagina untuk simulasi pemeriksaan fisik
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	Tempat tidur/periksa — 1 Phantom abdomen— 1

No.	Komponen	Isi
		Phantom vagina — 1 Lembar dokumentasi — 1 set Tensimeter — 1 Stetoskop — 1 Jam tangan/stopwatch — 1 Termometer — 1 Sarung tangan bersih — 1 pasang Handrub — 1 botol Infus Set – 1 Pack Tisu — 1 pack Kateter — 1 set bengkok — 1 Formulir rujukan — 1 lembar Lembar jawaban peserta — 1 lembar Pena — 1
13	Penulis	Bd. Anita Indra Afriani, S.ST, M.Kes
14	Referensi	Cunningham, F.G., et al. (2022). <i>Williams Obstetrics</i> (26th ed.). McGraw-Hill. Dewi, D. N. I., et al. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Retensi Urine Pasca Operasi. <i>Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia</i> . Djusad, S. (2024). <i>Evaluation of Risk Factors of Postpartum Urinary Retention after Vaginal Delivery. Universa Medicina</i> , 43(1), 31–37. Hapitria, P. (2023). Studi Kasus Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dengan Retensio Urine. <i>Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda</i> . Hesti, I., & Rahmawati, A. L. (2025). Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan Dengan Retensi Urin. <i>Jurnal Kesehatan Wira Buana</i> .

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan eliminasi retensi urine dan Tindakan Awal
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu nifas dengan retensin urine, lalu menilai keterampilan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan eliminasi retensi urine dan Tindakan Awal
	segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	mahasiswa saat melakukan tindakan awal penanganan dan menyiapkan rujukan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada nifas dengan retensi urine, dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan Postnatal yang evidence-based, woman-centred.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang nifas dengan gangguan eliminasi, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu, membaca data, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan gangguan eliminasi retensi urine, identifikasi tanda bahaya dan pengambilan keputusan awal.	Seorang Perempuan umur 31 tahun P2A0 melahirkan 8 jam yang lalu belum buang Air Kecil, kandung kemih penuh dan terasa nyeri perut bagian bawah, terdapat luka bekas episiotomi derajat 2, kontraksi uterus melemah.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, kontraksi uterus, adanya tanda-tanda perdarahan dan infeksi, menyiapkan	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu, membaca tanda-tanda gangguan eliminasi dan infeksi, menyimpulkan adanya gangguan eliminasi dengan retensi urine, menyiapkan infus, menganjurkan pengosongan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan eliminasi retensi urine dan Tindakan Awal
	infus, memasang kateter, dan menyiapkan rujukan. WHO juga mencantumkan keterampilan seperti menilai perdarahan, mengenali gangguan eliminasi retensi urine, memasang kateter, menjaga keseimbangan cairan, serta pencatatan sebagai keterampilan penting.	kandung kemih, dan memasang kateter lalu menjelaskan perlunya rujukan segera.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali adanya tanda tanda gangguan eliminasi dan tanda infeksi , kontraksi uterus yang mulai melemah sebagai tanda bahwa nifas tidak lagi aman untuk ditunggu di fasilitas awal.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada nifas, WHO menekankan identifikasi tanda bahaya dan langkah penanganan yang efektif.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan mengenali tanda bahaya, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan eliminasi retensi urine dan Tindakan Awal
		kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus gangguan eliminasi retensi urine, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan nifas secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Tabel 3. 1 Portofolio pada Gangguan Eliminasi masa nifas dengan retensi urine

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Retensi urine
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara	Pada topik gangguan eliminasi, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian Nifas dengan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Retensi urine
	bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	gangguan eliminasi, mengenali tanda bahaya ibu, melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu Nifas dengan retensi urine, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi 163 rofession, pengenalan gangguan eliminasi masa nifas, dan tindakan awal pra-rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu nifas, stabilisasi awal, dan persiapan rujukan pada kasus retensi urine
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu Seorang Perempuan umur 31 tahun P2A0 melahirkan 8 jam yang lalu belum buang Air Kecil, kandung kemih penuh dan terasa nyeri perut bagian bawah, terdapat luka bekas episiotomi derajat 2, kontraksi uterus melemah.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Retensi urine
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan retensi urine, ketelitian membaca 164 rofession, pemantauan perdatahan, pencegahan keterlambatan rujukan, dan komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus retensi urine.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali retensi urine dan menjelaskan rujukan, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai perdarahan, penilaian kandung kemih dan ketegasan saat melakukan eskalasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus gangguan eliminasi, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai adanya gangguan eliminasi masa nifas, mengenali retensi urine, dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan 164 rofession, mengenali tanda bahaya, dan mengambil

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Retensi urine
		keputusan awal yang tepat pada persalinan bermasalah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik gangguan eliminasi, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel 3. 2 Case Report pada Gangguan Eliminasi masa nifas dengan retensi urine

Komponen	Deskripsi	Gangguan Eliminasi masa nifas dengan retensi urine
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu nifas dengan retensi urine, nyeri pada perut bagian bawah, suhu badan naik dan kontraksi uterus melemah.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, 165 rofess rujukan, dan perkembangan kondisi ibu setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif,	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan ibu nifas 8 jam belum buang Air Kecil, kandung kemih

Komponen	Deskripsi	Gangguan Eliminasi masa nifas dengan retensi urine
	analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	penuh dan terasa nyeri perut bagian bawah, terdapat luka bekas episiotomi derajat 2, kontraksi uterus melemah analisis retensi urine dengan kecurigaan infeksi dan perdarahan, tindakan awal stabilisasi, dan keputusan rujukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menilai adanya gangguan eliminasi masa nifas, mengenali retensi urine, dan melakukan tindakan awal secara aman..
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus retensi urine, mahasiswa belajar bahwa 166 rofession, pemantauan ibu, dan keputusan eskalasi dini merupakan inti keselamatan dalam asuhan nifas dengan gangguan eliminasi
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep nifas dengan gangguan eliminasi, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 3. 3 Refleksi Gangguan Eliminasi masa nifas dengan retensi urine

Komponen	Deskripsi	Gangguan Eliminasi masa nifas dengan retensi urine
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus retensi urine, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali retensi urine dapat menyebabkan perburukan kondisi ibu
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah membaca 167 rofession, tidak memantau tanda infeksi dan perdarahan, atau menunda rujukan, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah Perdarahan, Syok dan infeksi
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis, salah menilai tanda infeksi, keterlambatan mengenali tanda perdarahan, penggunaan stimulasi yang tidak tepat, dan keterlambatan rujukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan 167 rofession secara konsisten, pemantauan tanda vital, penilaian 3P, stabilisasi awal ibu, komunikasi cepat kepada keluarga, dan

Komponen	Deskripsi	Gangguan Eliminasi masa nifas dengan retensi urine
		rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada persalinan lama, pengkajian serial, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

D. Rangkuman

Masa nifas adalah masa tubuh beradaptasi secara fisiologis dan mudah mendapat gangguan, terutama pada sistem eliminasi, seperti retensi urine, konstipasi, dan hemoroid. Ketiga kondisi tersebut saling terkait dan sering muncul karena perubahan hormon, trauma saat melahirkan, serta kebiasaan ibu setelah melahirkan.

Retensi urine setelah melahirkan adalah kondisi di mana ibu tidak bisa berkemih sendiri dalam waktu tertentu setelah melahirkan atau masih ada banyak urin di dalam kandung kemih. Kondisi ini terjadi karena terjadi pembengkakan pada jaringan perineum, kerusakan saraf selama proses melahirkan, dampak dari anestesi, dan juga hilangnya sensasi pada kandung kemih. Gejalanya antara lain kesulitan untuk berkemih, perasaan kandung kemih yang masih penuh, serta rasa sakit di bagian suprapubik. Jika tidak diatasi, penumpukan urine bisa menyebabkan infeksi pada saluran kemih dan mengganggu kerja kandung kemih.

Konstipasi setelah melahirkan adalah kondisi sulit buang air besar yang sering dialami, karena usus menjadi lambat bergerak, hormon progesteron berubah, konsumsi serat dan air kurang, serta rasa takut mengejan karena sakit di area perineum. Gejala yang muncul adalah feses keras, jumlah buang air besar berkurang, dan rasa tidak tuntas setelah buang air besar. Konstipasi yang terus-

menerus bisa membuat kondisi hemoroid semakin buruk dan mengurangi rasa nyaman bagi ibu yang sedang melahirkan.

Hemoroid postpartum adalah pembengkakan pada pembuluh darah di area anus dan rektum yang disebabkan oleh tekanan di dalam perut yang meningkat selama kehamilan dan proses melahirkan. Gejala yang sering dialami adalah terjadi perdarahan saat buang air besar, rasa nyeri, munculnya benjolan di sekitar anus, dan merasa gatal atau tidak nyaman. Hemoroid sering terkait dengan sembelit karena kebiasaan mengejan bisa membuat kondisi tersebut semakin parah.

Penanganan ketiga kondisi tersebut biasanya dilakukan secara konservatif, yaitu dengan meningkatkan pemasukan cairan dan serat, mempercepat gerakan tubuh, serta memberikan edukasi. Pada kasus retensi urine, dapat dilakukan kateterisasi bila diperlukan, sedangkan untuk konstipasi dan hemoroid, bisa diatasi dengan menggunakan laksatif ringan, mandi duduk, serta pengobatan topikal.

Glosarium

PPUR : Postpartum urinary retention
SC : *Sectio Caesarea*
PVR : Post-void residual urine
USG : Ultrasonografi
ISK : Infeksi saluran kemih
DRE : Digital Rectal Examination

Referensi

- Agrawal, S., & Shanker, O. (2022). *Postpartum Urinary Retention after Vaginal Delivery: Assessment of Risk Factors in a Case Control Analytical Study*. International Journal of Innovative Research in Medical Science. <https://ijirms.in/index.php/ijirms/article/view/1569>
- Annisa BW, Yuliansyah LFA. Diagnosis dan Tatalaksana Hemoroid. *Unram Medical Journal*. 2022.
- Bahtiar, H., et al. (2024). Hubungan pemenuhan nutrisi terhadap gejala konstipasi. *Jurnal Ilmiah STIKES Yarsi Mataram*
- Baruch, Y., Barba, M., Melocchi, T., Cola, A., Inzoli, A., & Frigerio, M. (2025). Long-term lower urinary tract symptoms among women with postpartum urinary retention. *Journal of Clinical Medicine*, 14(12), 4184. (Open Access).
- Bates' Guide to Physical Examination and History Taking – 2021
- Berek, J.S. (2020). *Berek & Novak's Gynecology* (16th ed.). Wolters Kluwer.
- Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing – 2022
- Cahyono, J. B. S. (2022). *Konstipasi Kronis pada Dewasa: Patofisiologi dan Terapi*. Penerbit EGC.
- Cahyono, J. B. S. (2022). *Konstipasi Kronis pada Dewasa: Patofisiologi dan Terapi*. EGC.
- Campbell-Walsh-Wein Urology – 2020
- Cunningham, F.G., et al. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill.
- Djusad, S. (2024). *Evaluation of Risk Factors of Postpartum Urinary Retention after Vaginal Delivery*. *Universa Medicina*, 43(1), 31–37.
- Fraser, D.M. & Cooper, M.A. (2021). *Myles Textbook for Midwives* (17th ed.). Elsevier.
- Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology – 2021
- Hall, J.E. (2021). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Hapitria, P. (2023). Studi Kasus Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dengan Retensio Urine. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*.
- Hapitria, P. (2024). *Asuhan kebidanan pasca persalinan dengan retensio urine*. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*.
- Hesti, I., & Rahmawati, A. L. (2025). Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan Dengan Retensi Urin. *Jurnal Kesehatan Wira Buana*.
- Hidayati, N., & Susilo, H. M. (2023). *Penatalaksanaan constipation pada ibu nifas dengan manajemen kebidanan*. *Jurnal Kebidanan*

- Holistik Jurnal Kesehatan* (2024). *Definisi dan karakteristik konstipasi*.
- Indian Journal of Physical Therapy and Research (2022). *Postpartum constipation and contributing factors*.
- Indrawaty, et al. (2022). Predisposisi Inkontinensia Urin pada Postpartum. *Voice of Midwifery*.
- Interventions for preventing postpartum constipation. *Cochrane Database / PMC* (2021).
- Johannsson, H. O., et al. (2022). Anorectal disorders during pregnancy and postpartum period. *BMC Gastroenterology*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Buku Ajar Kesehatan Ibu dan Nifas*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kulsum, U., et al. (2025). Asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan konstipasi. *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*
- Mareintika R, Ernawati T. The Holistic Management of Internal Hemorrhoids. *Medical Profession Journal*. 2024.
- Mulyani, N. S., et al. (2022). *Edukasi gizi sebagai upaya pencegahan konstipasi*. Jurnal Abdimas Kesehatan.
- Naibaho, R.M. (2021). *Efektivitas Bladder Training pada Ibu Postpartum*. Jurnal Keperawatan Priority
- Puspasari, I.H., & Rahmawati, A.L. (2025). *Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan Dengan Retensi Urin*. Jurnal Kesehatan Wira Buana
- Rahayu, N. M. (2025). *Hubungan asupan serat dan cairan dengan kejadian konstipasi pada ibu postpartum*. .
- Ramadilla, D. G., et al. (2021). *Pengaruh senam Kegel pada ibu postpartum*. Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi
- Rao, S. S. C., et al. (2022). *Constipation and anorectal disorders in pregnancy and postpartum*. American Journal of Gastroenterology.
- Repository Poltekkes Tanjungkarang (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Retensi Urine Pasca Operasi.
- Safi'i, S. Y., et al. (2024). *Asuhan kebidanan komprehensif pada ibu nifas dengan konstipasi*.
- Schmuck, R. B., & Roblick, M. (2025). *Incidence and management of proctological conditions during pregnancy and postpartum*. Visceral Medicine.
- Sunarti, N. (2022). *Asuhan keperawatan pada ibu nifas dengan gangguan eliminasi urin*. Jurnal Keperawatan Muhammadiyah.
- Tim SDKI-SLKI-SIKI. (2021). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia dan Intervensi Keperawatan*. DPP PPNI.

- Utami, H. E., et al. (2022). *Bladder training pada ibu postpartum*. Jurnal Ilmu Kesehatan.
- Wijayanti IT, et al. *Fisiologi dan Patofisiologi Persalinan*. K-Media; 2024.
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. (Open access).
- Yumni H, et al. *Asuhan Keperawatan Patologi Postpartum*. PT Mahakarya Citra Utama; 2025.
- Zahra, Y., & Susilawati, E.H. (2022). *Gangguan Berkemih pada Postpartum*. Jurnal Kesehatan Siliwangi

Profil Penulis



Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.

Penulis Lahir di Semarang, 23 Maret 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV Kebidanan pada Program Studi D-IV Kebidanan, STIKes Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro jurusan MKIA (Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak) lulus tahun 2014, melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan lulus tahun 2022 dan S2 pada STIKes Guna Bangsa Yogyakarta jurusan Magister Kebidanan lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004 di Akademi Kebidanan Karya Husada Semarang sampai dengan sekarang yang sudah bertransformasi menjadi Universitas Karya Husada Semarang. Penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas, Natural Therapy Kebidanan, Natural Advance Therapy, Promosi Kesehatan, Metodik Khusus, Panum Asuhan Kebidanan Nifas, Evidence Based Midwifery. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku di OPTIMAL, publikasi artikel, seminar, webinar serta pelatihan-pelatihan yang mendukung kinerja di Kebidanan. JaFung : Lektor. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mayang230380@gmail.com

Motto: "Kejarlah Akhiratmu, Dunia Akan Mengikutimu"



Rizka Fatmawati, S.SiT., M.Kes., M.Keb.

lahir di Klaten, 14 September 1988. Saat ini penulis merupakan dosen pada program study Sarjana Kebidanan dan Profesi di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Penulis sudah menyelesaikan Pendidikan D3 Kebidanan di STIKES Muhammadiyah Klaten, D IV Bidan Pendidik di STIKES Ngudi Waluyo Semarang, S2 Kesehatan di UNS dan S2 Kebidanan di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta. Penulis aktif dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama di bidang Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian masyarakat dengan terbukti sudah menerbitkan sejumlah jurnal nasional, buku serta HaKI.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail rizkafatmawati@umpku.ac.id

Motto : "Carpe diem" (ambil kesempatan hari ini), "Jangan pernah menyerah", "Terus maju", "Bersyukur selalu", "Yakin pada diri sendiri", dan "Jadilah dirimu sendiri"

Profil Penulis



Bd. Anita Indra Afriani, S.Si.T.,M.Kes.

Lahir di Banjarnegara pada tanggal 1 April 1990. Memulai pendidikan SMA sejak tahun 2005 di SMA N 1 Banjarnegara, kemudian pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan D-III Kebidanan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan pada tahun 2011 melanjutkan D-IV Bidan Pendidik di STIKes Karya Husada Semarang, pada tahun 2012 mengikuti Pendidikan Pekerti AA di IKIP PGRI Semarang dan melanjutkan

Pada Program Magister Kesehatan di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus ditahun 2014. Pada tahun 2021 lanjut Pendidikan Profesi Bidan di STIKes Guna Bangsa Yogyakarta. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Karya Husada Semarang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang di Prodi Kebidanan. Penulis mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Komunikasi Konseling Dalam Praktik Kebidanan, Asuhan Kebidanan pada Nifas dan Menyusui, Natural Theraphy pada Ibu Nifas dan Menyusui, Promosi Kesehatan, Manajemen Kewirausahaan, Kewirausahaan Dalam Praktik Kebidanan. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian baik Ekternal maupun Internal serta melaksanakan pengabdian Masyarakat Slogan hidup: Selalu belajar untuk menjadi Versi terbaik dari diri sendiri dan selalu berfikir positif . Penulis dapat dihubungi melalui E-mail: aanitaindraafriani@gmail.com .

Sinopsis

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui: Pemantauan, Konseling, dan Komplikasi disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, serta praktisi kesehatan yang membutuhkan pemahaman sistematis mengenai asuhan pada ibu masa nifas dan menyusui. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam pemantauan kondisi ibu, pemberian konseling, serta pengenalan komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas.

Materi dalam buku ini disajikan secara runtut, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar ibu menyusui, khususnya kebutuhan gizi dan dukungan gaya hidup sehat. Pembahasan ini penting karena status gizi, pola istirahat, aktivitas fisik, kesehatan mental, dan dukungan keluarga berpengaruh terhadap pemulihan ibu serta keberhasilan proses menyusui.

Selanjutnya, buku ini menguraikan infeksi masa nifas, meliputi endometritis, infeksi luka, faktor risiko, tanda dan gejala, serta tatalaksana awal yang dapat dilakukan sesuai kewenangan bidan. Materi ini membantu pembaca memahami pentingnya deteksi dini, pemantauan tanda bahaya, edukasi kebersihan diri, serta rujukan tepat waktu untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

Buku ini juga membahas gangguan eliminasi dan komplikasi lain yang sering dialami ibu pada masa nifas, seperti retensi urine, konstipasi, dan hemoroid. Pembahasan mencakup penyebab, dampak terhadap kenyamanan ibu, upaya pencegahan, konseling, serta penanganan awal yang dapat diberikan dalam praktik kebidanan.

Melalui buku ajar ini, pembaca diharapkan mampu memahami konsep asuhan kebidanan nifas dan menyusui secara komprehensif, menerapkan pemantauan yang tepat, memberikan konseling yang efektif, serta mengenali komplikasi sejak dini. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi acuan pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi calon bidan dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang aman, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan ibu.

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui: Pemantauan, Konseling, dan Komplikasi disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, serta praktisi kesehatan yang membutuhkan pemahaman sistematis mengenai asuhan pada ibu masa nifas dan menyusui. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam pemantauan kondisi ibu, pemberian konseling, serta pengenalan komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas.

Materi dalam buku ini disajikan secara runtut, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar ibu menyusui, khususnya kebutuhan gizi dan dukungan gaya hidup sehat. Pembahasan ini penting karena status gizi, pola istirahat, aktivitas fisik, kesehatan mental, dan dukungan keluarga berpengaruh terhadap pemulihan ibu serta keberhasilan proses menyusui.

Selanjutnya, buku ini menguraikan infeksi masa nifas, meliputi endometritis, infeksi luka, faktor risiko, tanda dan gejala, serta tatalaksana awal yang dapat dilakukan sesuai kewenangan bidan. Materi ini membantu pembaca memahami pentingnya deteksi dini, pemantauan tanda bahaya, edukasi kebersihan diri, serta rujukan tepat waktu untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

Buku ini juga membahas gangguan eliminasi dan komplikasi lain yang sering dialami ibu pada masa nifas, seperti retensi urine, konstipasi, dan hemoroid. Pembahasan mencakup penyebab, dampak terhadap kenyamanan ibu, upaya pencegahan, konseling, serta penanganan awal yang dapat diberikan dalam praktik kebidanan.

Melalui buku ajar ini, pembaca diharapkan mampu memahami konsep asuhan kebidanan nifas dan menyusui secara komprehensif, menerapkan pemantauan yang tepat, memberikan konseling yang efektif, serta mengenali komplikasi sejak dini. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi acuan pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi calon bidan dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang aman, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan ibu.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-18-7 (PDF)



9

786347

927187

